

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS PRÓ-
REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
ESCOLA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E HUMANIDADES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM CIÊNCIAS DA
RELIGIÃO**

CRISTINA GALDINO DE ALENCAR

***COPING* ESPIRITUAL E A SÍNDROME DE *BURNOUT* ENTRE
DOCENTES DE ENFERMAGEM**

**GOIÂNIA
2026**

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS PRÓ-
REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
ESCOLA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E HUMANIDADES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU*
EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO**

CRISTINA GALDINO DE ALENCAR

***COPING* ESPIRITUAL E A SÍNDROME DE *BURNOUT* ENTRE
DOCENTES DE ENFERMAGEM**

Tese de doutorado apresentada à Escola de Formação de Professores e Humanidades da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Programa de Pós-Graduação Strictu Senso em Ciências da Religião, como requisito para obtenção do título de Doutor em Ciências da Religião. Bolsista Capes.

Orientadora: Dra. Carolina Teles Lemos Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Goiânia/Brasil Linha de pesquisa: Religião e Movimentos Sociais

**GOIÂNIA
2026**

Catálogo na fonte – Sistema de Bibliotecas da PUC Goiás
Maria Auxiliadora Marques e Silva – Bibliotecária – CRB1/1740

- A368c Alencar, Cristina Galdino de
Coping espiritual e a Síndrome de Burnout entre docentes
de enfermagem / Cristina Galdino de Alencar. -- 2026.
156 f.: il.
- Texto em português, com resumo em inglês
Orientadora: Prof.^a Dr.^a Dra. Carolina Teles Lemos.
Tese (doutorado) -- Pontifícia Universidade Católica de Goiás,
Escola de Formação de Professores e Humanidades, Goiânia, 2026
Inclui referências: f. 105-142.
1. Burnout (Psicologia). 2. Estresse ocupacional. 3. Espiritualidade –
trabalho. 4. Qualidade de vida. 5. Professores - satisfação no trabalho. 6.
Professores de enfermagem - saúde mental. I. Lemos, Carolina Teles. II.
Pontifícia Universidade Católica de Goiás - Programa de Pós-Graduação
em Ciências da Religião. - 25/02/2026. III. Título.
- CDU: 2-584:159.944(043)



Pontifícia Universidade Católica de Goiás
 Pontifical Catholic University of Goiás
 Av. Universitária, 1069, Setor Universitário
 Caixa Postal 86 - CEP 74.605-010
 Goiânia - Goiás - Brasil

ATA Nº 136/2026

SESSÃO PÚBLICA DE DEFESA DE DOUTORADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

No dia **25 de fevereiro de 2026**, às **14h**, foi realizada via webconferência, a sessão pública de Defesa de Tese de **CRISTINA GALDINO ALENCAR**, discente do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em **Ciências da Religião** da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com trabalho intitulado **"COPING ESPIRITUAL E A SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE DOCENTES DE ENFERMAGEM"**. A Banca Examinadora foi composta por: Prof. Dr. José Reinaldo Felipe Martins Filho / PUC Goiás (Presidente); Profa. Dra. Lisa Valéria Vieira Torres / PUC Goiás; Prof. Dr. Clóvis Ecco / PUC Goiás; Profa. Dra. Ana Karina Bezerra Pinheiro / UFC; Prof. Dr. Abimar Oliveira de Moraes / PUC Rio; Prof. Dr. Eduardo Gusmão de Quadros / PUC Goiás (Suplente) e Prof. Dr. Douglas Ferreira Barros / PUC Campinas (Suplente). O trabalho da Banca Examinadora foi conduzido pelo(a) Presidente da Banca que, inicialmente após apresentar os docentes integrantes da Banca Examinadora, concedeu 30 minutos ao(a) discente para que este(a) expusesse seu trabalho. Após a exposição o(a) Presidente da Banca concedeu a palavra a cada membro para que estes arguissem o(a) discente. A banca examinadora deliberou pela manutenção do título original do trabalho apresentado. Durante a arguição os membros da banca apresentaram suas contribuições ao trabalho, com sugestões para conclusão do estudo e apresentação dos resultados da pesquisa. Após o encerramento das arguições a banca examinadora, reunida isoladamente, avaliou o trabalho desenvolvido e o desempenho do(a) discente, considerando sua trajetória no curso e o trabalho produzido. Como resultado a Banca Examinadora deliberou pela **APROVAÇÃO da Tese**. Proclamado o resultado pelo(a) Presidente da Banca, foram encerrados os trabalhos e, para constar, lavrou-se a presente Ata que é assinada pelos membros da banca e pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião.

Goiânia, GO, 25 de fevereiro de 2026

Assinam esta Ata, Banca Examinadora

Prof. Dr. José Reinaldo Felipe Martins Filho / PUC Goiás (Presidente); Profa. Dra. Lisa Valéria Vieira Torres / PUC Goiás; Prof. Dr. Clóvis Ecco / PUC Goiás; Profa. Dra. Ana Karina Bezerra Pinheiro / UFC e Prof. Dr. Abimar Oliveira de Moraes / PUC Rio.

Prof. Dr. José Reinaldo Felipe Martins Filho - Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião

Dedico este trabalho ao meu pai (in memoriam) e a minha mãe, como forma de honrar a vida que ganhei por meio deles.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus, o alicerce da minha vida, por guiar meus passos nesta jornada. A Ele consagro esta conquista e confio em Sua direção para cada passo futuro.

À minha família — minha mãe Marilda e meus filhos, Erick e Pricilla — que estiveram ao meu lado em todos os momentos, confortando-me nas horas difíceis e sendo a minha maior fonte de força e inspiração. Vocês são meu porto seguro e, sem o seu apoio incondicional, esta conquista não seria possível. Não poderia deixar de agradecer ao meu querido pai, Nilson, que, antes de partir no início desta caminhada, deixou palavras de incentivo e orgulho, desejando meu sucesso com um sorriso no rosto. Sua lembrança continua sendo uma inspiração constante em minha vida.

À minha orientadora, Prof.^a Dr.^a Carolina Teles Lemos, cuja presença foi essencial para esta conquista e para cada vitória alcançada ao longo do caminho. Sua orientação cuidadosa, paciência e dedicação foram pilares que me ajudaram a descobrir meu percurso, incentivando-me sempre a ir além e a superar meus próprios limites. Sou profundamente grata por sua generosidade ao compartilhar seu conhecimento, por acreditar no meu potencial e por me guiar com tanta sabedoria e respeito.

Aos amigos e colegas de trabalho, que partilharam, de certa forma, essa experiência comigo, presentes em diversas fases de minha vida, que colaboraram e ofereceram carinho e compreensão em várias situações, entendendo, inclusive, os necessários momentos de reflexão e quando precisei estar mais ausente.

À minha turma do doutorado, pela convivência maravilhosa, momentos de alegrias, trocas de experiências e aprendizados.

À CAPES, pelo apoio concedido, que foi fundamental para a realização desta formação.

A todos os profissionais que aceitaram participar da pesquisa. Obrigada pela disposição e por permitirem, que de alguma forma, eu pudesse participar e agregar à suas vidas.

Por fim, agradeço a todos os professores e colaboradores da Universidade, que de forma direta ou indiretamente, estiveram envolvidos na construção de minha formação acadêmica. Em especial, agradeço ao coordenador do curso, Prof. Dr. Clóvis Ecco, pela presteza e pelo notável apoio que me foi concedido.

Muito obrigada!

"Deus me deu a vida, meus pais me ensinaram a vivê-la, e minha família me inspirou a vencer!"

RESUMO

ALENCAR, Cristina Galdino de. **COPING ESPIRITUAL E A SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE DOCENTES DE ENFERMAGEM**. Tese (Doutorado em Ciências da Religião). 2025. - Escola de Formação de Professores e Humanidades, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2026.

A Síndrome de *Burnout* (SB), manifestada por exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal, representa um problema crescente que impacta a saúde mental e o desempenho profissional de professores. Diante desse cenário desafiador no ambiente de trabalho, o uso de estratégias de coping espiritual (CRE) entre docentes de enfermagem emerge como o principal referencial prático e teórico para lidar com as adversidades e os estados estressores, buscando ressignificar o sofrimento e promover a qualidade de vida. Adotando um enfoque fenomenológico-hermenêutico, o estudo encontra seu alicerce ético na Alteridade Radical de Emmanuel Levinas que, ao postular a responsabilidade incondicional pelo Outro, estabelece o fundamento para o Cuidado Integral. A sustentabilidade desse compromisso ético de acolhimento exige, implicitamente, o autocuidado como condição prática, o *coping* Espiritual é analisado como o fator protetivo que permite ao docente mitigar o *Burnout* e preservar sua capacidade de resposta e presença. Diante desse panorama, o trabalho teve como objetivo investigar a relação entre o coping espiritual, a Síndrome de *Burnout*, a qualidade de vida e os impactos de gênero na vida profissional dos docentes de enfermagem. Trata-se de um estudo de metodologia mista, conduzido com 103 docentes de enfermagem da cidade de Goiânia e região metropolitana. Para a coleta de dados, foram utilizados instrumentos validados, como o Copenhagen Burnout Inventory (CBI), o Coping Religioso-Espiritual (CRE) e o World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF), à profundidade das análises qualitativas, baseadas em respostas abertas que permitiram elucidar elementos e reflexões sobre a práxis do cuidado integral. As análises envolveram métodos estatísticos robustos (t-testes, ANOVAs, correlações e regressões) para os dados quantitativos e análise de conteúdo para as respostas abertas qualitativas, permitindo uma compreensão aprofundada da práxis do cuidado integral. Os resultados evidenciaram uma correlação positiva entre o *coping* espiritual e a qualidade de vida, reforçando a importância da espiritualidade na atribuição de sentido à vida e no bem-estar psicológico. Além disso, observou-se uma associação entre o *coping* espiritual e a redução dos sintomas da Síndrome de *Burnout*, demonstrando que a dimensão espiritual humana, vivenciada de várias formas, age positivamente sobre a saúde mental dos docentes de enfermagem. Em conclusão, as práticas espirituais não apenas contribuem significativamente para o bem-estar dos indivíduos, mas também se configuram como uma estratégia relevante no enfrentamento do estresse ocupacional. Este estudo fornece subsídios para a compreensão da dimensão espiritual como um recurso promotor de esperança, acolhimento e amparo, sugerindo que a integração de programas de apoio à saúde mental que considerem o *coping* espiritual, juntamente com uma análise das vulnerabilidades de gênero e a necessidade de abordagens multidimensionais e responsabilidade ética, pode beneficiar substancialmente os docentes de enfermagem, proporcionando-lhes uma vida com maior sentido e plenitude, mesmo diante das perdas, renúncias e decepções inerentes à profissão.

Palavras-chave: Saúde mental. Estratégias de enfrentamento. Qualidade de vida. Espiritualidade no trabalho.

ABSTRACT

ALENCAR, Cristina Galdino de. **SPIRITUAL COPING AND BURNOUT SYNDROME AMONG NURSING TEACHERS**. Thesis (Doctorate in Religious Sciences). 2025. - School of Teacher Training and Humanities, Pontifical Catholic University of Goiás, Goiânia, 2026.

Burnout Syndrome (BS), manifested by emotional exhaustion, depersonalization, and low personal accomplishment, represents a growing problem impacting the mental health and professional performance of teachers. Faced with this challenging work environment, the use of spiritual coping strategies (SCR) among nursing faculty emerges as the main practical and theoretical framework for dealing with adversity and stressful states, seeking to reframe suffering and promote quality of life. Adopting a phenomenological-hermeneutical approach, the study finds its ethical foundation in Emmanuel Levinas's Radical Alterity, which, by postulating unconditional responsibility for the Other, establishes the basis for Integral Care. The sustainability of this ethical commitment to care implicitly requires self-care as a practical condition; Spiritual Coping is analyzed as the protective factor that allows the teacher to mitigate Burnout and preserve their capacity for response and presence. Given this panorama, the study aimed to investigate the relationship between spiritual coping, Burnout Syndrome, quality of life, and the impacts of gender on the professional lives of nursing faculty. It is a mixed-methodology study conducted with 103 nursing faculty members from Goiânia and its metropolitan region. For data collection, validated instruments such as the Copenhagen Burnout Inventory (CBI), the Religious-Spiritual Coping (CRE), and the World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF) were used, adding to the depth of qualitative analyzes based on open responses that allowed the elucidation of elements and reflections on the praxis of integral care. The analyzes involved robust statistical methods (t-tests, ANOVAs, correlations, and regressions) for the quantitative data and content analysis for the qualitative open responses, enabling an in-depth understanding of the praxis of integral care. The results showed a positive correlation between spiritual coping and quality of life, reinforcing the importance of spirituality in giving meaning to life and promoting psychological well-being. Furthermore, an association was observed between spiritual coping and the reduction of Burnout Syndrome symptoms, demonstrating that the human spiritual dimension, experienced in various ways, acts positively on the mental health of nursing faculty. In conclusion, spiritual practices not only contribute significantly to the well-being of individuals but also constitute a relevant strategy in coping with occupational stress. This study provides subsidies for understanding the spiritual dimension as a resource promoting hope, support, and solace, suggesting that the integration of mental health support programs that consider spiritual coping, along with an analysis of gender vulnerabilities and the need for multidimensional and ethical approaches, can substantially benefit nursing faculty, providing them with a life with greater meaning and fulfillment, even in the face of the losses, resignations, and disappointments inherent in the profession.

Keywords: Mental health. Coping strategies. Quality of life. Workplace spirituality.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1A	Correlações entre Dimensões do <i>Burnout</i> e Qualidade de Vida (WHOQOL-BREF) entre Docentes de Enfermagem.....	76
Figura 2A	Correlações entre Dimensões do <i>Coping</i> Espiritual (CRE) e Qualidade de Vida (WHOQOL-BREF) entre Docentes de Enfermagem.....	80
Figura 2B	Correlações entre Dimensões do <i>Coping</i> Espiritual (CRE) e Qualidade de Vida (WHOQOL-BREF) entre Docentes de Enfermagem.....	81
Figura 3A	Correlações entre Dimensões do <i>Coping</i> Espiritual (CRE) e <i>Burnout</i> (CBI) entre Docentes de Enfermagem.....	83
Figura 3B	Correlações entre Dimensões do <i>Coping</i> Espiritual (CRE) e <i>Burnout</i> (CBI) entre Docentes de Enfermagem.....	84

LISTA TABELAS

TABELA 1	Frequência e comparação da população de estudo, segundo nível de formação acadêmica. Goiás 2024. Grande Goiânia -GO (2024)	66
TABELA 2	Diagnóstico médico de condições relacionadas ao estresse segundo variáveis ocupacionais e demográficas entre docentes de enfermagem. Grande Goiânia - GO (2024)	68
TABELA 3	Diagnóstico médico de condições relacionadas ao estresse segundo afastamento, carga horária e satisfação com o ambiente de trabalho entre docentes de enfermagem. Grande Goiânia - GO (2024)	70
TABELA 4	Diagnóstico médico de condições relacionadas ao estresse segundo atividades de recuperação, percepção de saúde e envolvimento espiritual entre docentes de enfermagem. Grande Goiânia - GO (2024)	72
TABELA 5	Confiabilidade dos Itens avaliados nas escalas utilizadas no estudo	74
TABELA 6	Resultados da Regressão Linear para o Escore de <i>Burnout</i> (CBI) entre Docentes de Enfermagem	86
TABELA 7	Resultados da Regressão Linear para o Escore de <i>Coping</i> Espiritual (CRE) entre Docentes de Enfermagem	87
TABELA 8	Análise de Regressão Linear para o Escore de Qualidade de Vida (WHOQOL) e Variáveis Sociodemográficas e de <i>Coping</i> Espiritual	89

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

MBI	<i>Maslach Burnout Inventory</i>
CBI	<i>Copenhagen Burnout Inventory</i>
CRE	<i>Coping religioso/espiritual</i>
WHOQOL-BREF	<i>World Health Organization Quality of Life - Bref</i>
CID-11	Classificação Internacional de Doenças, 11 ^a edição
R/E	Religiosidade e Espiritualidade
JD-R	<i>Job Demands-Resources</i>
CESQT	<i>Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo</i>
TCLE	<i>Termo de Consentimento Livre e Esclarecido</i>
QVT	<i>Qualidade de Vida no Trabalho</i>
SB	<i>Síndrome de Burnout</i>

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	Error! Bookmark not defined.
1 ENQUADRAMENTO TEÓRICO: A EVOLUÇÃO DA RELAÇÃO HUMANA COM RELIGIÃO, RELIGIOSIDADE, ESPIRITUALIDADE E SAÚDE	Error! Bookmark not defined.
1.1 TRANSFORMAÇÕES E IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL E FÍSICA ..	Error! Bookmark not defined.
1.1.1 Espiritualidade e Religiosidade no Enfrentamento de Doenças e na Promoção da Saúde Mental.....	Error! Bookmark not defined.
1.1.2 Integração entre Ciências da Religião e Ciências da Saúde: Potencialidades e Desafios	Error! Bookmark not defined.
1.1.3 A Importância do Cuidado Espiritual na Qualidade de Vida e na Prática Profissional de Saúde.....	Error! Bookmark not defined.
2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O COPING ESPIRITUAL, BURNOUT E QUALIDADE DE VIDA	Error! Bookmark not defined.
2.1 MECANISMOS DE ENFRENTAMENTO: ESTILOS E CONTEXTOS DE SAÚDE, ABORDAGENS E DESAFIOS	30
2.2 ESTRATÉGIAS DE COPING ESPIRITUAL: PRÁTICAS E BENEFÍCIOS.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 ORIGEM E EVOLUÇÃO DA SÍNDROME DE BURNOUT.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 DEFINIÇÕES E MODELOS DE SAÚDE RELACIONADOS À SÍNDROME DE BURNOUT.....	Error! Bookmark not defined.
3 PERSPECTIVAS DE SAÚDE RELACIONADAS AO BURNOUT.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 A SÍNDROME DE BURNOUT.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.1 Abordagens e Estratégias de Prevenção e Manejo	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Impactos do Burnout na Saúde Sistêmica.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.3 Necessidade de Abordagens Multidimensionais.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 A ÉTICA DA ALTERIDADE E O FUNDAMENTO DO CUIDADO INTEGRAL	Error! Bookmark not defined.
3.2.1 A Responsabilidade Radical e o Diálogo Político-Estrutural	40
4 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DE DOCENTES DE ENFERMAGEM	Error! Bookmark not defined.
4.1 ASPECTOS CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS NA AVALIAÇÃO DA QVT	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Determinantes da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)	43
5 GÊNERO SOB O OLHAR PLURAL: UMA ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO CONCEITO E	

SUAS IMPLICAÇÕES NA SAÚDE E EQUIDADE SOCIAL	Error! Bookmark not defined.
5.1 DESVENDANDO O CONCEITO DE GÊNERO: FUNDAMENTOS PARA ENTENDER SEUS EFEITOS NAS RELAÇÕES DE PODER.....	Error! Bookmark not defined.
5.1.1 A Evolução do Conceito de Gênero: De sua Origem à Dinâmica de Poder	Error! Bookmark not defined.
5.1.2 Articulação: gênero, alteridade e ética a partir de Levinas	48
5.1.3 Gênero e Saúde mental na Trajetória da Enfermagem.....	49
5.2 A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DE GÊNERO PARA AVANÇAR NA EQUIDADE E COMPREENSÃO DAS VULNERABILIDADES	50
5.2.1 Um Olhar Essencial para a Equidade e o Combate à Vulnerabilidade.....	50
6 CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRABALHO E SUA JORNADA PELA HISTÓRIA E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS.....	52
6.1 PERSPECTIVAS CONCEITUAIS E HISTÓRICAS SOBRE O TRABALHO	52
6.1.1 A Relação entre Trabalho e Saúde	53
6.1.2 Revoluções Industriais e Seus Impactos.....	53
6.1.3 Impacto da Síndrome de <i>Burnout</i> nas Relações de Trabalho	54
7 A METODOLOGIA INVESTIGATIVA: DA CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL ÀS QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO	56
7.1 MATERIAIS E MÉTODOS.....	56
7.2 VARIÁVEIS EM ESTUDO	Error! Bookmark not defined.6
7.3 PARTICIPANTES NO ESTUDO	Error! Bookmark not defined.7
7.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS	Error! Bookmark not defined.8
7.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS	Error! Bookmark not defined.1
7.6 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS.....	62
8 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS.....	Error! Bookmark not defined.2
9 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS	Error! Bookmark not defined.4
9.1 RESULTADOS QUANTITATIVOS	64
9.2 RESULTADOS QUALITATIVOS	Error! Bookmark not defined.
9.2.1 Sobrecarga e Pressão no Trabalho	Error! Bookmark not defined.
9.2.2 Impactos Emocionais do Trabalho Docente	Error! Bookmark not defined.
9.2.3 Relação entre Espiritualidade e Bem-Estar.....	Error! Bookmark not defined.
9.2.4 Falta de Controle e Autonomia no Trabalho.....	Error! Bookmark not defined.
9.2.5 Ambientes de Trabalho Tóxicos	Error! Bookmark not defined.
9.2.6 Desafios Tecnológicos e Ensino Remoto	Error! Bookmark not defined.
10 DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS	Error! Bookmark not defined.1
11 CONSIDERAÇÕES FINAIS	Error! Bookmark not defined.
12 REFERÊNCIAS.....	Error! Bookmark not defined.

ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO.....	144
ANEXO B -TERMO DE COMPROMISSO	146
ANEXO C- ESCALA CRE ESCALA DE <i>COPING</i> (ENFRENTAMENTO) RELIGIOSO- ESPIRITUAL	147
ANEXO D - INVENTÁRIO DE <i>BURNOUT</i> DE COPENHAGEN - CBI – PT.....	150
ANEXO E - ESCALA WHOQOL BREF (DE QUALIDADE DE VIDA)	151
ANEXO F - QUESTIONÁRIO COM CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS E DADOS OCUPACIONAIS	Error! Bookmark not defined.53

INTRODUÇÃO

Em um cenário contemporâneo caracterizado pela aceleração e pelas constantes transformações sociais, alcançar o equilíbrio entre corpo, mente e espírito tornou-se um desafio crucial. No ambiente profissional, a Síndrome de *Burnout* (SB) destacou-se como uma condição de grande relevância, afetando diretamente a saúde mental e o desempenho de diversos profissionais. Originalmente descrita por Herbert J. Freudenberger em 1974 como Staff Burnout, essa condição era caracterizada por exaustão emocional, desilusão e isolamento, especialmente em trabalhadores da saúde mental. Entretanto, a Síndrome de *Burnout* evoluiu para um fenômeno global que impacta profissionais de diversas áreas, como educação, tecnologia, e serviços, refletindo a complexidade e a extensão de seus efeitos (Fontes, 2016; Perniciotti *et al.*, 2020).

A relevância desse tema se intensifica ao considerarmos a definição de saúde proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1948, como "um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade". Este conceito, quando aplicado ao contexto da saúde mental, especialmente no que diz respeito ao *Burnout*, revela-se ainda mais relevante. Nesse contexto, a SB representa um obstáculo significativo para a conquista desse estado de bem-estar integral. Longe de ser uma realidade, simboliza um compromisso, um horizonte a ser perseguido.

Uma síndrome ocupacional com múltiplos determinantes, o *Burnout* abrange mais do que apenas sentir-se fisicamente e emocionalmente exausto. É um presságio para mergulhar profundamente dentro de nós mesmos, redefinir nossos valores e cultivar um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Investir em saúde mental, afinal, não é apenas uma responsabilidade individual, mas uma necessidade coletiva. A importância da questão e a prevenção do *Burnout* são um investimento que traz retorno para todos.

Nesse contexto, o *Coping* Religioso/Espiritual (CRE) emergiu como uma abordagem relevante. O CRE, definido em *Pargament* (1998) e *Koenig et al.* (1998) como o uso de crenças e práticas religiosas para lidar com o estresse, é um fator potencial de resiliência e bem-estar. Para investigá-lo, utilizou-se a escala de *Coping* Religioso-Espiritual (CRE), adaptada ao Brasil por Panzini *et al.* (2004), a fim de analisar como essas estratégias impactam a saúde mental em ambientes de alta demanda emocional.

No campo educacional, especialmente entre os docentes de enfermagem, a interação entre *coping* espiritual e *Burnout* foi pouco explorada, apesar das evidências que sugerem que práticas espirituais podem mitigar os efeitos da síndrome. Os docentes de enfermagem enfrentam desafios únicos, lidando não apenas com demandas pedagógicas, mas também com o impacto emocional de preparar futuros profissionais de saúde para cenários de alta complexidade.

A experiência como docente e coordenadora de cursos de Enfermagem me possibilitou uma visão clara dos desafios enfrentados na área. Este estudo é o resultado dessa vivência, motivado pela falta de debate sobre a relação entre a espiritualidade e o bem-estar físico e mental na área da saúde. É essa lacuna, somada às minhas experiências pessoais e profissionais, que impulsionou minha pesquisa.

Essa jornada, em particular, me expôs a inúmeros casos de esgotamento profissional. Observei colegas enfrentarem essa realidade e a vivenciei na minha própria pele, quando atuei como coordenadora em uma instituição de ensino superior. Tais experiências fizeram questionar as abordagens convencionais da saúde, que muitas vezes ignoram as dimensões mais profundas do sofrimento humano.

A formação multidisciplinar em Enfermagem, docência e Ciências da Religião proporciona uma perspectiva crítica sobre as normativas do ensino superior no Brasil, que historicamente tendem a marginalizar a discussão sobre fé e espiritualidade. Contudo, essa marginalização contrasta com a evidente e crescente relevância que a literatura e as pesquisas recentes têm demonstrado sobre a temática da saúde em suas múltiplas manifestações e dimensões.

Assim, este trabalho propôs trazer essa discussão para o centro do debate, explorando como a espiritualidade e as práticas religiosas podem ser ferramentas importantes e valiosas no enfrentamento de doenças, no manejo do estresse e na promoção de uma saúde integral. A pesquisa, portanto, é um reflexo direto da minha trajetória, buscando dar voz a uma questão que, embora crucial para o bem-estar humano, ainda encontra resistência no ambiente acadêmico e na prática clínica.

Essa experiência impulsionou a investigação de questões fundamentais, buscando compreender a fundo a realidade desses profissionais. As perguntas que nortearam esta pesquisa foram: qual o nível de compreensão dos educadores de enfermagem sobre espiritualidade e religiosidade? De que maneira o Coping Religioso/Espiritual (CRE) se correlaciona com a prevenção ou mitigação da Síndrome de Burnout entre os docentes de enfermagem? Como as dimensões do CRE e da espiritualidade influenciam os resultados relacionados ao Burnout nesse público? De que forma os docentes de enfermagem integram a espiritualidade em sua prática pedagógica e profissional, e como isso se relaciona com sua própria qualidade de vida?

Assim, este estudo investigou a relação entre o *coping* espiritual e a Síndrome de *Burnout*, com foco nos docentes de enfermagem, por meio de uma abordagem interdisciplinar que integrou conceitos das Ciências da Religião e das Ciências da Saúde. O objetivo foi avaliar como estratégias espirituais influenciaram a qualidade de vida e a saúde mental desses profissionais, oferecendo evidências relevantes para a formulação de políticas de apoio e intervenções no ambiente de trabalho.

O estudo foi desenvolvido com docentes enfermeiros atuantes em instituições de ensino médio e superior no estado de Goiás, empregando métodos quantitativos e qualitativos para a avaliação do *Burnout* (CBI), do *Coping* Religioso/Espiritual (Escala CRE) e da Qualidade de Vida (WHOQOL-BREF). Os achados preliminares demonstram a importância do CRE como um elemento protetor contra o *Burnout* e como uma via para promover a Qualidade de Vida, especialmente em contextos laborais de alta demanda emocional.

Está organizado em três partes principais, que se apresentam divididas em capítulos e seções. Ele investiga a relação entre o coping espiritual, a Síndrome de *Burnout*, a qualidade de vida e os impactos de gênero na vida profissional dos docentes de enfermagem.

A primeira parte do trabalho, que compreende os Capítulos 1 a 6, é dedicada à Fundamentação Teórica, estabelecendo as bases conceituais e o referencial analítico para a pesquisa. No Capítulo 1, explora-se a historicidade da interação entre espiritualidade e saúde, abordando as transformações e impactos na saúde mental e física. Serão discutidos subtemas como a relevância da espiritualidade e religiosidade no enfrentamento de doenças e na promoção da saúde mental, a integração entre as ciências da religião e da saúde, e a importância do cuidado espiritual na qualidade de vida e na prática profissional. No Capítulo 2, aprofundamo-nos nos mecanismos de enfrentamento, com foco nas estratégias de *coping* espiritual, suas práticas e benefícios. Serão apresentadas a origem e evolução da Síndrome de *Burnout*, bem como suas definições e modelos de saúde relacionados, contextualizando esses conceitos fundamentais para a pesquisa.

O Capítulo 3 é dedicado à Síndrome de *Burnout* (SB) e aborda suas diversas perspectivas. Serão exploradas as abordagens e estratégias de prevenção e manejo da SB, os impactos do *Burnout* na saúde sistêmica e a necessidade de abordagens multidimensionais para seu enfrentamento. O Capítulo 4 se concentra nos aspectos conceituais e metodológicos da avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), com uma ênfase particular nos docentes de enfermagem. Serão investigados os determinantes da QVT, oferecendo uma compreensão aprofundada sobre os fatores que influenciam o bem-estar profissional nesta categoria. No Capítulo 5, serão abordados o conceito de gênero e sua articulação com a saúde e a enfermagem. Uma análise das vulnerabilidades e potencialidades relacionadas à saúde mental e gênero serão apresentadas, destacando a relevância dessa perspectiva para o estudo. Para finalizar a fundamentação teórica, o Capítulo 6 oferece uma visão sobre o trabalho em suas perspectivas conceituais e históricas. Será explorada a relação entre trabalho e saúde, os impactos das Revoluções Industriais e, finalmente, a influência da Síndrome de Burnout nas relações de trabalho.

A segunda parte, representada pelos Capítulos 7 e 8, detalha a metodologia empregada na pesquisa. O Capítulo 7 descreve minuciosamente a metodologia utilizada no estudo, apresentando os materiais e métodos, as variáveis em estudo (quantitativas e qualitativas), a caracterização dos participantes, os instrumentos de coleta de dados, os procedimentos de coleta e os métodos de análise estatística dos dados. Fundamental para qualquer pesquisa, o Capítulo 8 discute as considerações éticas que nortearam todo o processo de investigação, garantindo a integridade e o respeito aos participantes.

A terceira e última parte do estudo, compreendendo os Capítulos 9 a 12, dedica-se à apresentação, discussão dos resultados e conclusão. Os resultados obtidos a partir das análises realizadas serão expostos. Primeiramente, serão apresentados os resultados quantitativos e, em seguida, os resultados qualitativos, que abordam temas como sobrecarga e pressão no trabalho, impactos emocionais do trabalho docente, relação entre espiritualidade e bem-estar, falta de controle e autonomia no trabalho, ambientes de trabalho tóxicos e desafios tecnológicos e ensino remoto. A discussão aprofundará os resultados apresentados no capítulo anterior, interpretando-os à luz da revisão da literatura e dos objetivos do estudo, buscando conexões e implicações. Finalmente, as considerações finais destacarão as contribuições, limitações e perspectivas futuras do estudo.

PARTE I

1 ENQUADRAMENTO TEÓRICO: A EVOLUÇÃO DA RELAÇÃO HUMANA COM RELIGIÃO, RELIGIOSIDADE, ESPIRITUALIDADE E SAÚDE

“O caminho para compreensão e exploração científica não é apenas sobre a parte material do mundo [...] a ciência é apenas mais uma maneira de nos envolvermos com o mistério de quem somos” (Gleiser, 2019).

O estudo do *Coping* Religioso/Espiritual (CRE), especialmente do *coping* espiritual, tem raízes profundas nas tradições culturais e filosóficas milenares que sempre destacaram a importância da espiritualidade na superação de desafios e na melhoria da qualidade de vida. Este capítulo convida o leitor a explorar os aspectos históricos e conceituais que deram forma a essa maneira única de enfrentamento, mostrando como diversas culturas têm incorporado a dimensão espiritual como um recurso valioso para lidar com situações adversas.

Além disso, a pesquisa mergulha na evolução das atitudes religiosas ao longo dos séculos, destacando as transformações significativas nas crenças, práticas e estruturas religiosas. Essa análise oferece *insights* valiosos sobre as raízes históricas do conceito de Religiosidade/Espiritualidade (CRE) e como esses elementos moldam a compreensão moderna da espiritualidade como um mecanismo eficaz de *coping*. Ao considerar as diferentes manifestações do CRE, buscamos entender a importância do contexto cultural na formação das práticas espirituais, enfatizando como essas práticas foram adaptadas e reinterpretadas ao longo do tempo para atender às necessidades humanas em constante transformação.

1.1 TRANSFORMAÇÕES E IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL E FÍSICA

Na contemporaneidade, observamos uma variedade crescente de perspectivas religiosas e estilos de vida, que nem sempre se alinham com as religiões institucionalizadas. Como tal, essa pluralidade nos leva a uma compreensão necessária dos conceitos de religião, religiosidade e espiritualidade, de modo a transcender as limitações impostas pelas tradições e denominações históricas.

1.1.1 Espiritualidade e Religiosidade no Enfrentamento de Doenças e na Promoção da Saúde Mental

Quanto mais distintos são tais conceitos, mais sutil pode ser a maneira de lidar com novas formas de fé, as quais frequentemente combinam elementos de distintas tradições ou se desvinculam delas. A clareza conceitual é crucial para compreender que uma pessoa pode ser espiritual sem se identificar com uma religião específica, ou que sua crença religiosa não se restrinja a uma única denominação. Essa distinção é fundamental para a análise sociológica e filosófica da complexa dinâmica religiosa atual.

A partir da etimologia da palavra ‘religião’, a base para esse entendimento é estabelecida. Derivando do latim *religare* (ligar novamente), transmite a ideia de uma conexão entre humanos e divindade. Esse vínculo, como Mircea Eliade explica em *O Sagrado e o Profano* (1992), é a conexão entre o mundo ordinário (o profano) e o que está fora do tempo/espço (o sagrado).

Nesse sentido, etimologia e distinção dos conceitos andam de mãos dadas, porque a raiz da palavra ‘religião’ implica desde o início uma busca por contato com o sagrado. Mas, no mundo atual, essa conexão não depende mais necessariamente de sistemas religiosos institucionais ou substantivos. A espiritualidade torna-se uma manifestação individual, quase autônoma, dessa busca. A religiosidade é a experiência pessoal dessa conexão dentro desse contexto religioso específico.

Dessa forma, manter os conceitos claros deixa evidente que a busca por *religare* com o sagrado permanece presente na sociedade hoje, mas agora é expressa em uma variedade mais ampla de formas e menos vinculada a formas estruturais específicas.

Para Koenig (2004), a religião pode integrar dois componentes, a religião como uma instituição social, as igrejas e a religião como experiência pessoal, aqui se referindo a religiosidade. Assim, a religiosidade assenta nas diversas formas, de como a pessoa ou grupo vivencia a religião, podendo ser expressas através das suas representações sociais, das práticas religiosas e das relações ou vínculos estabelecidos com os membros de uma comunidade religiosa (Koenig, 2004). Já o termo ‘espiritualidade’ deriva do latim *spiritus*, que está relacionado à respiração, significando dar vida, sopro da vida, ou aquilo que dá vida ao organismo físico (Luccetti *et al.*, 2015; Koenig *et al.*, 2015).

Koenig (2004) analisa a evolução histórica da compreensão dos conceitos de religiosidade e espiritualidade. Inicialmente, a crença religiosa ocupava uma posição de maior relevância em comparação à espiritualidade, sendo esta última restrita a contextos estritamente religiosos. Contudo, em um desenvolvimento que o autor denomina como a versão moderna, a espiritualidade passou a adotar uma perspectiva mais pluralista, estendendo-se além das fronteiras das crenças religiosas (Koenig, 2004). Dessa forma, o autor reconhece a possibilidade

de indivíduos desenvolverem uma espiritualidade independente da prática religiosa institucionalizada.

Alinhando-se com o pensamento de Koenig (2004), Pessanha (2009) concorda que a espiritualidade aponta para pelo menos dois pontos diferentes. Primeiramente, a espiritualidade é entendida como a busca de sentido na vida além de uma relação com o divino ou transcendente. A segunda visão do autor compreende a espiritualidade como uma referência à atuação humana, cuja finalidade é superar as adversidades que ocorrem no cotidiano e não necessariamente relacionadas ao divino

Segundo Anandarajah (2001) a espiritualidade é uma parte complexa e multidimensional da experiência humana, e possui alguns aspectos correlacionados. Segundo autora, o aspecto cognitivo ou filosófico envolve a busca pelo sentido, propósito e verdade da vida, bem como pelas crenças e valores que os norteiam. Os aspectos experienciais e emocionais envolvem sentimentos de esperança, amor, conexão, paz interior, conforto e apoio. Esses sentimentos refletem a qualidade dos recursos internos de um indivíduo e sua capacidade de dar e receber amor espiritual, bem como o tipo de relacionamento e conexão que existe consigo mesmo, com a comunidade, com o meio ambiente, com a natureza e além como uma força maior que o eu, sistema de valores, Deus ou consciência cósmica. E por fim, o aspecto comportamental da espiritualidade, que envolve a maneira como uma pessoa expressa externamente suas crenças pessoais e seu estado espiritual interno. Para Puchalski *et al.* (2014, p. 646), a espiritualidade pode ser vista como:

Um aspecto dinâmico e intrínseco da experiência humana, por meio do qual se busca e expressa o significado, propósito e transcendência da existência. Tal estado perpassa a vivência da pessoa em suas relações consigo mesma, com a família, com os outros, a comunidade, a natureza e com aquilo que é significativo e sagrado.

Eliade (1992) argumenta que a busca pelo sagrado é uma das constantes da experiência humana. O autor explica que a espiritualidade é o processo pelo qual as pessoas buscam e expressam o significado, o propósito e a transcendência de sua existência. Isso abrange todas as áreas da vida, incluindo as relações pessoais, familiares, sociais, com a comunidade, com a natureza e com o que cada um considera sagrado ou significativo. Em outras palavras, a busca pelo sagrado, é fundamental para a forma como vivenciamos a realidade.

De forma complementar, para Lucchetti *et al.* (2011), a espiritualidade é uma busca pessoal de compreensão das questões existenciais humanas, como o sentido da vida, e da morte, bem como de suas relações com o sagrado/transcendente, sendo que esse processo não está

necessariamente relacionado com práticas religiosas. Por fim, Hill e Pargament (2003), afirmam que a espiritualidade pode ser compreendida como o coração e alma da religião, podendo ser expressa fora, por exemplo, na fé pessoal e por aqueles que não são formalmente religiosos.

Dessa forma, entende-se que a religiosidade e a espiritualidade são partes fundamentais da experiência humana, profundamente enraizadas na história e permeando diversas culturas ao longo dos séculos. A religiosidade, frequentemente associada a sistemas de crenças organizadas e práticas rituais formais, tem sido um elemento central na estrutura social e moral desde as civilizações antigas até as principais religiões contemporâneas (Eliade, 1987; Armstrong, 1993). De acordo com Koenig *et al.* (2012, p. 11), a religiosidade está entrelaçada com as crenças, práticas e observâncias de uma religião específica, incluindo rituais e escrituras que reconhecem e se comunicam com o Sagrado, o Divino ou Deus.

Conforme pode ser observado entre as conceituações de espiritualidade oferecidas pelos autores abordados, alguns elementos são comuns, como a busca individual por sentido, pelo sagrado e pelo transcendente; bem como a experiência de conexão, seja intrapessoal, interpessoal e transpessoal, que pode ou não sofrer a interferência de doutrinas religiosas. Essa abordagem é particularmente relevante no contexto contemporâneo, onde muitos indivíduos buscam formas de espiritualidade desvinculadas de sistemas de crenças rígidos, citadas anteriormente.

Para entender de forma mais aprofundada a história da espiritualidade e a razão pela qual nos encontramos neste paradigma, que, embora pareça novo, possui raízes profundas, é fundamental realizar uma jornada histórica e investigar a evolução das crenças espirituais ao longo do tempo.

Nas sociedades primitivas, a espiritualidade estava intimamente ligada à natureza e aos fenômenos naturais. Animismo, totemismo e xamanismo eram práticas comuns, com as crenças em espíritos que habitavam seres vivos e elementos naturais. Essas práticas refletiam uma visão de mundo onde o sagrado permeava todos os aspectos da vida cotidiana. Civilizações como a egípcia, a mesopotâmica, a hindu e a chinesa desenvolveram sistemas espirituais complexos, com deuses, rituais e mitologias próprias (Eliade, 1964).

A Era Axial, exemplarmente, foi um período de profunda transformação espiritual em várias regiões do mundo, resultando no surgimento de tradições religiosas e filosóficas que ainda influenciam a humanidade. Na Índia, textos como os Vedas e as *Upanishads* foram compostos, estabelecendo bases filosóficas e espirituais que influenciariam o Hinduísmo (Flood, 1996). Esses textos introduziram conceitos como karma, dharma e reencarnação.

Fundado por *Siddhartha Gautama* (Buda), o Budismo emergiu na Índia, promovendo ensinamentos sobre o caminho para a iluminação e a libertação do ciclo de renascimento (Gethin, 1998). A prática da meditação e a busca pela cessação do sofrimento são centrais nesta tradição.

Na China, Confúcio e Laozi fundaram tradições espirituais que enfatizavam a ética, a harmonia social e a conexão com o Tao, a força universal (Fung, 1948). Enquanto o Confucionismo focava na moralidade e nas relações humanas, o Taoísmo buscava a unidade com o cosmos através da simplicidade e da contemplação. Em Israel, os profetas judeus desenvolveram uma espiritualidade baseada na aliança com um Deus único, *Yahweh*, e na observância da *Torá* (Neusner, 1991).

O Judaísmo enfatizava a justiça, a misericórdia e a fidelidade a Deus. Já o Cristianismo surgido no primeiro século d.C., se espalhou rapidamente pelo Império Romano, enfatizando a fé em Jesus Cristo como o Salvador e a prática de amor ao próximo (Stark, 1996), tendo se tornado uma das maiores religiões do mundo, com uma rica tradição teológica e litúrgica. No século VII, o profeta *Muhammad* fundou o Islamismo na Arábia, com ensinamentos contidos no Alcorão e práticas como as cinco orações diárias (Esposito, 2005). O Islamismo se expandiu rapidamente, influenciando vastas regiões da África, Ásia e Europa.

Durante a Idade Média, a espiritualidade cristã floresceu, com a fundação de ordens monásticas e o desenvolvimento da teologia escolástica (Le Goff, 1993). O misticismo cristão também ganhou destaque com figuras como Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, que exploraram a união íntima com Deus.

No século XVI, a Reforma Protestante, liderada por figuras como Martinho Lutero e João Calvino, desafiou a autoridade da Igreja Católica e promoveu uma espiritualidade baseada na leitura pessoal da Bíblia (Macculloch, 2004). Este movimento resultou em uma diversidade de denominações protestantes. Posteriormente, o século XVIII traria uma mudança na perspectiva de espiritualidade, com o Iluminismo enfatizando a razão e a ciência (Gay, 1966). Movimentos como o Pietismo surgiram, buscando uma espiritualidade mais pessoal e emocional em resposta à racionalidade iluminista. O Romantismo reacendeu o interesse pela espiritualidade, destacando a intuição e a emoção (Berlin, 1999). Movimentos como o Espiritismo, fundado por Allan Kardec, e a Teosofia, fundada por Helena Blavatsky, exploraram novas dimensões espirituais e a comunicação com o mundo espiritual.

Já no século XX, vimos o surgimento de novos movimentos espirituais, como a Nova Era, que combina elementos de várias tradições espirituais, e o crescente interesse por práticas orientais como o Yoga e a Meditação (Heelas, 1996). Essas práticas são frequentemente vistas

como formas de autoconhecimento e bem-estar. A globalização e a comunicação instantânea facilitaram o diálogo inter-religioso, promovendo uma maior compreensão e integração de diferentes tradições espirituais (Knitter, 2002). Este diálogo tem contribuído para a promoção da paz e da cooperação entre diversas comunidades religiosas e não religiosas.

Após um breve relato histórico sobre a diversidade de espiritualidades, chegamos a teoria do Cuidado Transpessoal, desenvolvida em 1985, por Jean Watson, baseada nos trabalhos filosóficos ocidentais e orientais. Essa teoria propõe que a saúde envolve uma interação complexa entre mente, corpo, alma e espírito. Similarmente, a Teoria das Necessidades Básicas de Wanda Horta enfatiza o cuidado integral, reconhecendo a espiritualidade como uma necessidade humana fundamental (Souza et al., 2021).

Embora as teorias de Watson e Horta enfatizem a espiritualidade como componente essencial da saúde, o conceito de saúde segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2022) diverge por não a incluir explicitamente em sua definição. Essa espiritualidade, segundo Carrette e King (2005), reflete uma busca por propósito e bem-estar, em um mundo cada vez mais secularizado. Ela se manteria, assim, em constante evolução, refletindo as transformações sociais e as novas compreensões do mundo, abrangendo desde tradições milenares até inovações contemporâneas (Heelas, 1996).

Essa visão integradora da espiritualidade destaca a importância do significado, das relações e da transcendência na vida humana. Postula a relevância de uma abordagem que contemple a heterogeneidade das manifestações espirituais, bem como a complexidade inerente à experiência humana ao longo do *continuum* histórico (Armstrong, 2005). Tal perspectiva permite reconhecer a espiritualidade como um recurso fundamental no enfrentamento de patologias, na promoção do bem-estar e na construção de uma existência imbuída de propósito e sentido.

A espiritualidade moderna e pós-moderna, conforme descrita por Boff (2006) reflete um novo paradigma que serve como fonte de inspiração e esperança, proporcionando um sentido pleno de vida e a capacidade de auto transcendência, transcendendo o plano físico e finito. Esse entendimento integral e complementar é essencial para o paradigma contemporâneo da medicina, que visa tratar o paciente de forma completa, incorporando aspectos espirituais nos cuidados médicos (Heelas, 1996). Apesar dos avanços, a implementação completa e abrangente desse modelo ainda enfrenta desafios, principalmente a falta de informação nos órgãos de formação da área da saúde. Segundo Souza (2021), esse conceito se estende ao autocuidado, que é tão importante quanto cuidar do outro, alinhando-se aos princípios da Teoria do Autocuidado de *Dorothea Orem* (Souza, et al. 2021).

Ao estender o conceito de espiritualidade para o autocuidado, Boff (2006) enfatiza que cuidar de si mesmo é tão essencial quanto cuidar do outro. Esse enfoque holístico no autocuidado sugere que a auto transcendência e a busca por um sentido pleno de vida são fundamentais não apenas para o bem-estar individual, mas também para a capacidade de oferecer cuidado compassivo e eficaz aos outros. A ideia é que a espiritualidade pode servir como um recurso interno vital, auxiliando tanto pacientes quanto profissionais de saúde a enfrentar os desafios da vida e da prática médica.

No entanto, é importante reconhecer que a incorporação da espiritualidade nos cuidados médicos ainda enfrenta desafios significativos. A prática médica convencional, frequentemente, se concentra em aspectos físicos e tangíveis da saúde, podendo haver resistência à inclusão de dimensões espirituais, que são mais subjetivas e difíceis de quantificar. Além disso, a diversidade de crenças espirituais entre pacientes e profissionais de saúde pode complicar a implementação de uma abordagem verdadeiramente holística.

Apesar desses desafios, a visão de Boff (2006) e Heelas (1996), destacam uma evolução necessária na medicina, onde a integração de aspectos espirituais pode enriquecer significativamente a experiência de cura. Este paradigma não apenas promove um cuidado mais completo e humano, mas também encoraja uma visão mais ampla da saúde e do bem-estar, que inclui a mente, o corpo e o espírito.

Assim, a espiritualidade moderna, conforme descrita por Boff (2006), oferece um novo paradigma que pode transformar a prática médica contemporânea. Ao enfatizar a importância da auto transcendência e do cuidado integral, essa abordagem holística promete um cuidado mais compassivo e completo, beneficiando tanto pacientes quanto cuidadores e com certeza formadores, instrutores e docentes. No entanto, sua implementação requer uma mudança cultural e uma aceitação mais ampla da importância dos aspectos espirituais na saúde e no bem-estar.

1.1.2 Integração entre Ciências da Religião e Ciências da Saúde: Potencialidades e Desafios

A interdisciplinaridade entre as ciências da religião e da saúde destaca a crescente convergência na forma como ambas as áreas reconhecem a importância da espiritualidade e da religiosidade para a saúde humana. Isso significa que há um reconhecimento mútuo de que aspectos espirituais e religiosos desempenham papéis cruciais no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas.

As ciências da religião se dedicam a estudar como a religiosidade se manifesta e é compreendida em diferentes contextos históricos e culturais. Pesquisadores como Durkheim (2026) e Otto (1923) analisaram, por exemplo, como as crenças e práticas religiosas influenciam sociedades e culturas ao longo do tempo.

Por sua vez, as ciências da saúde se preocupam em examinar de forma empírica, através de pesquisas e dados concretos, como a espiritualidade e a religiosidade afetam a saúde física, mental e social dos indivíduos.

Segundo Gerone (2020), é fato, a histórica associação entre espiritualidade e saúde, destacando a proximidade entre religião e cuidado humano ao longo do desenvolvimento humano e científico, como citado anteriormente. Nas civilizações antigas, por exemplo, sacerdotes com funções médicas, como xamãs e druidas, desempenhavam papéis fundamentais no serviço de saúde, representando poderes divinos de cura. Na Idade Média, a influência da Igreja Católica era evidente, com médicos, enfermeiros e religiosos colaborando no cuidado hospitalar, incluindo práticas religiosas no tratamento de enfermos. O avanço científico promovido na Idade Moderna trouxe um distanciamento temporário entre questões religiosas e saúde.

Na contemporaneidade, a religiosidade e a espiritualidade têm despertado um crescente interesse na área da saúde. A medicina está expandindo seu foco além da saúde física para incluir aspectos relacionados à religião, religiosidade e espiritualidade, adotando uma perspectiva relacional. Essa mudança reflete uma transição dos paradigmas mecanicistas para uma abordagem mais integrativa, que considera tanto a assistência médica quanto a compreensão do ser humano como um todo.

Os estudos de Hummer *et al.* (2004) demonstram que o engajamento religioso pode estar associado a taxas reduzidas de doenças cardiovasculares, depressão e até mesmo a uma maior longevidade. Essa associação é corroborada pela meta-análise de Chida *et al.* (2009), que revelou uma correlação positiva entre religiosidade/espiritualidade e saúde. Descobriu-se que a prática religiosa regular está vinculada a menores taxas de mortalidade e melhor recuperação de doenças graves. Segundo os autores, essa relação pode ser explicada pelo fato de que a religião e a espiritualidade incentivam comportamentos saudáveis, fortalecem o suporte social e oferecem mecanismos de enfrentamento eficazes em situações de estresse.

Nesse contexto, práticas espirituais como meditação e oração destacam-se por sua capacidade de modular respostas neuroendócrinas e inflamatórias, contribuindo para uma saúde geral mais equilibrada (Oman; Thoresen, 2005). Essa interação entre espiritualidade e respostas

biológicas aprofunda a compreensão dos impactos positivos da religiosidade no bem-estar físico.

Essa modulação das respostas neuroendócrinas e inflamatórias, por sua vez, desponta como uma área de crescente interesse científico. Estudos indicam que práticas espirituais podem influenciar diretamente os sistemas biológicos que regulam a saúde, ampliando o entendimento sobre os benefícios de integrar a espiritualidade ao cuidado médico. Esses achados reforçam não apenas o valor emocional da espiritualidade, mas também sua relevância como componente integral para a saúde geral do paciente (Koenig *et al.*, 2012; Pargament *et al.*, 2004).

Seybold e Hill (2001) complementam esses achados ao mostrar que a religiosidade/espiritualidade pode influenciar positivamente a adesão ao tratamento médico, sugerindo que a fé religiosa proporciona uma estrutura de significado e propósito que motiva os pacientes a seguir recomendações médicas e participar ativamente do seu próprio cuidado (Seybold; Hill, 2001). No caso da síndrome de *Burnout* entre docentes de enfermagem, isso interfere no autocuidado dos profissionais.

A interdisciplinaridade entre as ciências da religião e da saúde permite uma análise mais profunda dos mecanismos pelos quais a espiritualidade afeta a saúde. Esse corpo de pesquisas, assim como outras já citadas anteriormente, sugere que a religiosidade e a espiritualidade oferecem benefícios tangíveis à saúde física e mental, indo além do suporte emocional para incluir efeitos fisiológicos diretos (Seybold; Hill, 2001; Hummer *et al.*, 2004; Oman; Thoresen, 2005; Harris *et al.*, 2008; Park *et al.*, 2013). Assim, ao integrar essas perspectivas, podemos avançar na compreensão de como a religiosidade e a espiritualidade não apenas moldam identidades culturais, mas desempenham um papel crucial na saúde e no bem-estar e qualidade de vida.

1.1.3 A Importância do Cuidado Espiritual na Qualidade de Vida e na Prática Profissional de Saúde

A espiritualidade desempenha um papel significativo na qualidade de vida, especialmente no cuidado em saúde mental, influenciando tanto a percepção subjetiva do bem-estar quanto os resultados clínicos. A integração da espiritualidade nos cuidados de saúde mental apresenta desafios e implicações que refletem a complexidade da experiência humana e a diversidade cultural.

A espiritualidade, frequentemente definida como uma busca por significado e propósito na vida, está intimamente ligada à saúde mental e ao bem-estar emocional (Koenig, 2012). Estudos têm demonstrado que indivíduos que reportam uma forte conexão espiritual tendem a apresentar melhor qualidade de vida percebida, maior resiliência emocional e uma capacidade aumentada de lidar com estressores psicológicos (Koenig *et al.*, 2012; Pargament, 2002).

A qualidade de vida, neste contexto, é compreendida como um conceito multidimensional que abrange aspectos físicos, psicológicos, sociais e espirituais (World Health Organization, 1997). A espiritualidade contribui para cada um desses domínios, proporcionando suporte emocional, fortalecimento da autoestima, melhoria nas relações sociais e uma sensação de conexão com algo maior que o indivíduo (Koenig *et al.*, 2003).

No entanto, a integração da espiritualidade no cuidado em saúde mental não é isenta de desafios. Profissionais de saúde muitas vezes enfrentam obstáculos como falta de formação específica em espiritualidade, preocupações éticas relacionadas à imposição de crenças pessoais e a necessidade de respeitar a diversidade cultural e religiosa dos pacientes (Lucchetti *et al.*, 2012; Koenig, 2008).

Além disso, a avaliação da espiritualidade nos contextos clínicos pode ser complexa devido à sua natureza subjetiva e multifacetada. Ferramentas como a Escala de *Coping* Religioso/Espiritual (CRE) têm sido desenvolvidas para ajudar na avaliação sistemática das necessidades espirituais dos pacientes e na adaptação do cuidado de acordo com suas preferências e valores espirituais (Pargament *et al.*, 2000; Panzini *et al.*, 2007).

Integrar a espiritualidade ao cuidado em saúde, especialmente na saúde mental, contribui para uma experiência mais positiva do paciente e pode favorecer melhores resultados clínicos. Pacientes que recebem suporte espiritual tendem a relatar maior satisfação com o tratamento, melhor adesão às terapias recomendadas e, em alguns casos, uma recuperação mais rápida de condições psicológicas adversas (Koenig, 2012; Puchalski *et al.*, 2004).

Dessa maneira, os profissionais de saúde mental são encorajados a desenvolver competências em avaliação espiritual e a integrar abordagens sensíveis à espiritualidade em seus planos de cuidado. Essas abordagens não apenas respeitam a integralidade do paciente, mas também reconhecem a importância da espiritualidade como um recurso valioso na promoção da saúde mental e da qualidade de vida.

A espiritualidade tem sido amplamente reconhecida como um fator relevante na promoção da qualidade de vida, particularmente no contexto da saúde mental. Estudos demonstram que práticas espirituais e religiosas estão associadas a melhores resultados psicológicos e emocionais, fornecendo recursos valiosos para enfrentar o estresse, a

adversidade e os desafios da saúde mental (Koenig *et al.*, 2012; Pargament, 1997). Segundo Park *et al.* (2013), a espiritualidade impacta significativamente a saúde mental ao atuar em diferentes dimensões. Primeiramente, ela oferece sentido e propósito, auxiliando os indivíduos a compreenderem e lidar com experiências difíceis e o sofrimento existencial. Além disso, práticas como meditação e oração têm sido associadas a maior resiliência psicológica e melhor gestão de emoções negativas (Koenig *et al.*, 2001). A participação em comunidades religiosas também desempenha um papel central ao proporcionar um senso de pertencimento e apoio social, elementos cruciais para o bem-estar emocional (Harris *et al.*, 2008).

Apesar desses benefícios, há desafios na incorporação da espiritualidade ao cuidado em saúde. A falta de treinamento específico para que profissionais abordem adequadamente as dimensões espirituais dos pacientes é um dos principais entraves (Balboni *et al.*, 2010). Médicos e enfermeiros relatam desconforto ou falta de preparo para tratar questões espirituais ou religiosas, o que pode resultar em abordagens superficiais ou evasivas (Puchalski & Guenther, 2013). Essa lacuna compromete a integralidade do cuidado, reforçando a necessidade de capacitação e formação voltada para a espiritualidade no contexto clínico.

Historicamente, a formação médica e de enfermagem tem dado pouca ênfase à espiritualidade como componente essencial do bem-estar geral do paciente. Essa perspectiva biomédica restritiva pode ignorar o impacto das crenças religiosas e práticas espirituais na saúde física e emocional dos indivíduos (Harrison, 2017). Além disso, a falta de diretrizes claras e protocolos institucionais para integrar a espiritualidade no cuidado diário contribui para variações na qualidade e na acessibilidade desse tipo de suporte entre profissionais e instituições (Koenig, 2008).

Esses desafios ressaltam a necessidade de uma abordagem mais estruturada e sistemática, a qual considere a espiritualidade como um componente integral no cuidado em saúde, promovendo um modelo de atendimento mais holístico e humanizado. Assim, torna-se necessário investir em programas educacionais que capacitem os profissionais de saúde a reconhecerem e responder às necessidades espirituais dos pacientes de maneira sensível e eficaz (Astrow *et al.*, 2007).

A espiritualidade e a religiosidade (ER) estão intrinsecamente ligadas à busca de sentido na existência humana e desempenham um papel significativo na resolução de questões emocionais, como medo, raiva, ansiedade, depressão, suicídio e problemas de saúde mental. A qualidade de vida e a promoção da saúde são frequentemente impulsionadas por práticas espirituais, como cultos religiosos, ou pela integração com outras religiões, refletindo a sacralidade do cotidiano (Pandya, 2017).

A tríade religião/espiritualidade/saúde (E/R/S), contudo, pode ter efeitos tanto positivos quanto negativos no processo saúde-doença de clientes de saúde mental. Diversas evidências sugerem que as práticas religiosas e espirituais podem ser benéficas para pessoas que sofrem de transtornos mentais, facilitando o tratamento e promovendo avanços significativos na qualidade de vida dos pacientes (Fariñas *et al.*, 2018; Reinaldo e Santos, 2016).

É essencial que os profissionais de saúde tenham conhecimento adequado sobre essas dimensões, especialmente no contexto da saúde mental, para entenderem as diversas conexões na vida dos clientes. Dentro das equipes multidisciplinares, destaca-se o papel de enfermeiros e enfermeiras, que buscam, desde a formação, conectar-se com os pacientes para compreender seus cuidados gerais. A enfermagem permite uma compreensão holística dos indivíduos (Ballarin *et al.*, 2016).

Por fim, a análise apresentada neste capítulo evidencia a relação histórica e interdisciplinar entre espiritualidade, religiosidade e saúde, destacando seu papel transformador na promoção do bem-estar e no enfrentamento de adversidades. A espiritualidade transcende barreiras culturais e religiosas, oferecendo um suporte essencial para a qualidade de vida, especialmente no contexto contemporâneo, onde o ser humano busca sentido e propósito diante das complexidades da vida moderna. Ao integrar perspectivas históricas e conceituais, compreende-se que a espiritualidade atua como uma ponte entre o cuidado emocional, social e físico, ampliando as fronteiras do cuidado humano. Essa base teórica é crucial para compreender as dinâmicas do coping espiritual e sua aplicação no contexto de saúde mental e prática profissional, que serão aprofundadas nos capítulos subsequentes.

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O *COPING* ESPIRITUAL, *BURNOUT* E QUALIDADE DE VIDA

No contexto das ciências da religião, juntamente com as áreas das ciências humanas e da saúde, debates intensos têm se concentrado no conceito de *Coping*, que se refere à capacidade de enfrentar e reagir de maneira eficaz a situações estressantes ou desafiadoras, sendo frequentemente descrito no Brasil como ‘enfrentamento’ (Paiva, 1998).

2.1 MECANISMOS DE ENFRENTAMENTO: ESTILOS E CONTEXTOS DE SAÚDE, ABORDAGENS E DESAFIOS

Segundo Carver e Scheier (1994), as pessoas desenvolvem formas habituais de lidar com o estresse, sendo que esses hábitos (ou estilos de *Coping*) podem influenciar suas reações

em novas situações. Os autores definem o estilo de *coping* não em termos de preferência de um aspecto sobre outros, mas quanto à tendência a ter uma reação de *Coping* diante de situações estressantes. No entanto, os estilos de *coping* não necessariamente implicam a presença de traços subjacentes de personalidade que predisõem a pessoa a responder de determinada forma. Em vez disso, os estilos de *coping* podem refletir a tendência a responder de uma forma particular quando confrontados com uma série específica de circunstâncias.

Os estilos de *coping* não são definidos pela preferência de um método sobre outro, mas pela tendência de reagir a situações estressantes. Eles não necessariamente refletem traços de personalidade subjacentes, mas podem indicar uma tendência a responder de determinada forma à circunstâncias específicas. Band e Weisz (1998) apresentam a tipologia de *coping* primário e secundário, onde o coping primário lida com situações objetivas e o secundário envolve a adaptação às condições de estresse.

Já as estratégias de *coping*, ao contrário dos estilos, são vinculadas a fatores situacionais e podem mudar durante os estágios de uma situação estressante. Folkman e Lazarus (1984) classificam essas estratégias em duas categorias principais: *coping* focalizado na emoção - que busca regular o estado emocional associado ao estresse - e *coping* focalizado no problema, que visa alterar a situação estressante. O *coping* focalizado no problema pode ser direcionado externamente, através de ações como negociar para resolver um conflito, ou internamente, através da reestruturação cognitiva. Ambas as estratégias podem se complementar, onde o *coping* emocional pode facilitar a resolução de problemas e vice-versa.

Diversas abordagens teóricas sobre *coping* foram propostas na literatura especializada, destacando-se os variados estilos, conforme apontam Band e Weisz (1998). A partir dos anos 1960, algumas abordagens comportamentais surgiram, seguidas por uma terceira geração de pesquisadores que estudam a convergência entre enfrentamento e personalidade. Segundo Folkman e Lazarus (1984), esse interesse é alimentado pela evidência crescente de que os fatores contextuais não explicam todas as variações nas estratégias de enfrentamento. Os pesquisadores propuseram então um modelo cognitivista com categorias científicas, hoje utilizadas em grande parte das pesquisas em diversas áreas de estudo.

Nesse contexto, o modelo de Folkman e Lazarus (1984) distingue entre duas abordagens principais: estratégias voltadas para aspectos emocionais, que lidam com o estresse ou suas consequências, e estratégias focadas na resolução de problemas, que envolvem a ação direta para mudar a situação estressante (Lazarus e Folkman, 1984).

Pargament (1990), autor de referência no estudo do CRE, constatou que todas as pessoas possuem um conjunto de crenças e práticas que influenciam a forma como percebem e lidam

com situações difíceis na vida. A religião faz parte desse sistema, aparecendo em diferentes fases do processo de enfrentamento e desempenhando várias funções, como a interpretação e avaliação de eventos de vida significativos, a adoção de estratégias de enfrentamento (EE) e os resultados dessas estratégias (Pargament, 2011). O CRE abrange cinco funções principais: busca de significado, estabelecimento de controle, fornecimento de consolo espiritual, cultivo da intimidade com Deus e outras pessoas, e potencial para transformação da vida (Pargament; Koenig; Peres, 2000).

Considerando essas diferentes funções do *coping* religioso, Pargament (1997) classificou-o em *coping* religioso/espiritual positivo (CREP) e negativo (CREN). O CREP inclui atividades como buscar apoio espiritual, colaborar com Deus para resolver problemas, reinterpretar os estressores de maneira benevolente, encontrar consolo em textos religiosos, buscar e oferecer perdão, orar pelo bem-estar dos outros, buscar assistência de líderes religiosos e membros da comunidade, entre outras estratégias (Koenig *et al.*, 1998; Pargament; Smith; Koenig; Perez, 1998; Pargament *et al.*, 2000). Por outro lado, o CREN pode ter consequências negativas para os indivíduos, como questionar a existência, o amor e as ações de Deus, sentir-se insatisfeito ou descontente com Deus ou com a instituição religiosa, envolver conflitos com outros membros da comunidade religiosa e duvidar da capacidade de Deus de intervir em situações estressantes (Koenig *et al.*, 1998; Pargament *et al.*, 2000).

São consideradas renomadas as pesquisas de Koenig (1995) realizadas na interseção entre saúde, religião e espiritualidade. Ele investigou amplamente os efeitos do *coping* religioso sobre a saúde mental e física, particularmente em contextos clínicos e de envelhecimento.

Tanto Koenig (2012) quanto Pargament (1997) investigam, por exemplo, como a participação em atividades religiosas ou a adoção de práticas espirituais podem influenciar a saúde mental, ajudar na recuperação de doenças e proporcionar um suporte emocional e social significativo.

Desse modo, a incorporação consciente da espiritualidade e religiosidade nas estratégias de enfrentamento (EE) de doenças pode proporcionar um suporte adicional significativo aos pacientes, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e resultados de saúde mais positivos.

2.2 ESTRATÉGIAS DE *COPING* ESPIRITUAL: PRÁTICAS E BENEFÍCIOS

A Escala *Coping* Religioso/Espiritual (CRE) representa uma ferramenta fundamental na avaliação e compreensão das estratégias de *coping* que indivíduos utilizam para enfrentar situações estressantes e desafiadoras. Desenvolvida com base no modelo de *coping* proposto

por Lazarus e Folkman (1984), a CRE foi adaptada e validada para medir especificamente como aspectos religiosos e espirituais são integrados no enfrentamento de adversidades.

A tradução e adaptação da CRE para o contexto brasileiro foi realizada por Panzini *et al.* (2007), ampliando sua aplicabilidade em estudos populacionais e clínicos no país. A escala permite uma análise detalhada das diferentes dimensões do coping religioso/espiritual, como a busca por significado em eventos estressantes, a prática de rituais religiosos, a participação em comunidades de fé, entre outros aspectos relevantes para a saúde mental e emocional dos indivíduos.

Estudos têm demonstrado que a utilização de estratégias de *coping* religioso/espiritual pode estar associada a melhores resultados de saúde, incluindo menor incidência de sintomas depressivos e ansiosos (Smith *et al.*, 2003; Ano; Vasconcelles, 2005). Além disso, a CRE tem sido empregada em pesquisas que exploram a relação entre espiritualidade, qualidade de vida e bem-estar psicológico, evidenciando seu papel na promoção de recursos internos e na resiliência diante de desafios pessoais e profissionais (Pargament *et al.*, 2000).

Avaliar o *coping* religioso/espiritual por meio da CRE não apenas oferece insights sobre como indivíduos lidam com o estresse, mas também facilita a implementação de intervenções psicossociais que incorporam aspectos espirituais e religiosos no tratamento de condições de saúde mental. Essa abordagem holística reconhece a importância da dimensão espiritual na saúde integral dos pacientes, promovendo uma prática clínica mais abrangente e centrada no indivíduo (Koenig *et al.*, 2012).

Portanto, a CRE não apenas expande o entendimento sobre as estratégias de *coping* utilizadas pelos indivíduos, mas contribui significativamente para a integração de aspectos religiosos e espirituais nos contextos clínicos e de pesquisa, fortalecendo a base teórica e prática da psicologia da saúde e dos cuidados integrativos.

2.3 ORIGEM E EVOLUÇÃO DA SÍNDROME DE *BURNOUT*

A Síndrome de *Burnout* foi reconhecida pela primeira vez na década de 1970, nos Estados Unidos, sendo associada ao ambiente de trabalho. O termo foi introduzido pelo psicólogo Herbert Freudenberger (1974), no artigo *Staff Burn-Out*, publicado no *Journal of Social Issues*. Nesse estudo, o autor descreveu a síndrome como um estado de exaustão física e emocional, frequentemente acompanhado por sentimentos de fracasso, desmotivação e esgotamento decorrentes de demandas ocupacionais excessivas.

O interesse por este campo de estudo intensificou-se devido a três fatores essenciais, conforme apontado por Perlman e Hartman (1982): (a) a crescente importância dos serviços humanos na promoção do bem-estar individual e coletivo; (b) a maior valorização e exigência dos usuários em relação aos serviços sociais, educacionais e de saúde; e (c) o reconhecimento, pelos pesquisadores, dos efeitos potentes e prejudiciais do estresse tanto nas pessoas quanto nos ambientes em que estão inseridas. Entre as contribuições de Freudenberger, destacam-se obras como *Situational Anxiety* (1989), desenvolvido em colaboração com Gail North e Estafa (1991), publicado em português em parceria com Geraldine Richelson. Nessas publicações, o autor aprofundou a definição do *Burnout* como uma consequência do trabalho intenso, caracterizada por dois grupos principais de sintomas: físicos e comportamentais. Ele também enfatizou que o esgotamento não ocorre de maneira uniforme entre os indivíduos, variando de acordo com as respostas pessoais ao estresse.

Posteriormente, Nahas *et al.* (2017) ampliaram a compreensão do *Burnout*, incluindo o aspecto emocional entre os sintomas. Entre os sinais físicos mais frequentes estão exaustão, dores de cabeça, insônia, problemas gastrointestinais e dificuldades respiratórias. No âmbito emocional, destacam-se problemas de memória, depressão e ansiedade. Já os aspectos comportamentais incluem a raiva, irritabilidade, frustração, episódios frequentes de choro, isolamento social, o uso de álcool e outras drogas. Além disso, indivíduos acometidos podem apresentar paranoia, com sensações de perseguição ou um senso de superioridade, acreditando serem mais competentes que os colegas.

Esses sintomas, como discutido por Tibola *et al.* (2023), estão frequentemente associados a outros sinais, como tensão muscular, cefaleia, fadiga crônica, aumento da pressão arterial, alterações no peso corporal (perda ou ganho), taquicardia, diminuição da libido e maior suscetibilidade a infecções. Esses indicadores reforçam a complexidade do *Burnout*, que afeta tanto a saúde física quanto a psicológica dos indivíduos.

Conforme Andrade (2021) e Da Paz (2024), algumas pessoas recorrem ao uso abusivo de substâncias químicas, como tranquilizantes, ao consumo de drogas ilícitas, para lidar com os sintomas do *Burnout*. Nesse contexto, Nahas *et al.* (2017) ressaltam que a dificuldade em participar de atividades satisfatórias, estabelecer relacionamentos significativos e desempenhar papéis sociais contribui para o início e a manutenção do uso de drogas entre indivíduos com transtornos mentais. Esses comportamentos não apenas agravam a saúde mental, mas também aumentam o descontrole emocional, desestimulam hábitos saudáveis, como atividade física e alimentação equilibrada, e, em casos extremos, podem levar ao suicídio devido à vulnerabilidade emocional.

De acordo com Sousa (2022), Freudenberger destacou que trabalhadores altamente comprometidos e dedicados tendem a ser mais vulneráveis ao *Burnout*, devido à intensidade com que se envolvem no trabalho e à dificuldade em estabelecer limites saudáveis entre vida pessoal e profissional. Além disso, jovens profissionais em início de carreira, especialmente no primeiro ano de trabalho, são particularmente suscetíveis à síndrome, em função de fatores como descontentamento com a liderança e desinteresse progressivo pelas tarefas laborais. Esses aspectos reforçam a necessidade de estratégias preventivas e de suporte para profissionais em risco.

A concepção original de Freudenberger paralelamente foi expandida por Maslach (1977), que desenvolveu uma abordagem multidimensional para a síndrome de *Burnout*. A autora foi fundamental para a popularização do termo, introduzindo-o publicamente no Congresso Anual da *American Psychological Association* (APA). Ela utilizou a expressão para descrever um fenômeno cada vez mais comum entre profissionais de serviços humanos: um estado de esgotamento resultante de meses ou anos de intensa dedicação. Essa definição situou o *Burnout* no contexto do estresse ocupacional, evidenciando suas repercussões no bem-estar físico e psicológico dos profissionais.

No Brasil, os primeiros estudos sobre a Síndrome de *Burnout* foram conduzidos por França (1987), enquanto as pesquisas mais consolidadas emergiram na década de 1990, com Benevides-Pereira, que analisou os fatores organizacionais relacionados à síndrome. A literatura aponta que demandas excessivas, combinadas com escassez de recursos, alta responsabilidade e baixa autonomia, constituem condições propícias ao desenvolvimento do *Burnout* em diversos contextos laborais.

Pesquisas recentes, como as de Pasqualucci *et al.* (2019) e Membrive-Jiménez *et al.* (2020), reforçam que a pressão constante e a intensa carga emocional associadas ao trabalho têm impacto direto na saúde mental dos profissionais, comprometendo seu desempenho funcional. Esse ciclo de exaustão e frustração contínua não apenas afeta os indivíduos, mas também resulta em elevados índices de absenteísmo, rotatividade e afastamentos, o que sobrecarrega ainda mais sistemas já pressionados, como o da saúde.

Diante desse cenário, torna-se indispensável investir em estratégias eficazes de prevenção e manejo do *Burnout*. A promoção de ambientes laborais saudáveis, o estabelecimento de limites claros entre a vida pessoal e profissional, e a adoção de práticas de autocuidado são medidas fundamentais para mitigar os impactos da síndrome de *Burnout*. Além de preservar a saúde física e mental dos trabalhadores, essas ações contribuem para a

manutenção da qualidade dos serviços prestados, beneficiando tanto os indivíduos quanto as organizações.

2.4 DEFINIÇÕES E MODELOS DE SAÚDE RELACIONADOS À SÍNDROME DE BURNOUT

A Síndrome de *Burnout* é um fenômeno multidimensional amplamente estudado em áreas como psicologia, medicina e enfermagem. Trata-se de uma condição associada ao estresse ocupacional crônico, caracterizada por três dimensões principais: exaustão emocional, cinismo (também denominado despersonalização) e redução da realização pessoal (Maslach; Jackson, 1981). Essas dimensões têm sido aceitas como pilares fundamentais para a compreensão da síndrome, orientando a formulação de modelos teóricos e intervenções em saúde.

Nesse contexto, a Organização Mundial da Saúde (OMS), define o *Burnout* como uma síndrome ocupacional resultante do estresse crônico no ambiente de trabalho, que não foi devidamente gerido. Classificado no CID-11 como um fenômeno ocupacional, o *Burnout* se distingue de outras condições médicas, reforçando sua relação direta com as demandas e condições do trabalho. A partir dessa definição, diversos modelos foram desenvolvidos para aprofundar a compreensão da síndrome e propor estratégias para sua prevenção e manejo.

Dentre esses modelos, o proposto por Maslach e Jackson (1981) é o mais amplamente reconhecido e estabelece que o *Burnout* resulta de um desequilíbrio entre as demandas do trabalho e os recursos disponíveis para enfrentá-las. Suas três dimensões incluem a exaustão emocional, caracterizada pelo esgotamento físico e mental, frequentemente acompanhado de uma fadiga constante; o cinismo, também denominado despersonalização, que se manifesta por atitudes negativas, apatia e distanciamento emocional em relação ao trabalho e às pessoas; e a redução da realização pessoal, que gera uma sensação de incompetência, insatisfação e falta de produtividade. Esse modelo serviu de base para o desenvolvimento do *Maslach Burnout Inventory* (MBI), um dos instrumentos mais utilizados para avaliação da síndrome.

A partir de outras perspectivas, surgiram modelos que enfatizam diferentes fatores no desenvolvimento do *Burnout*. O Modelo Demanda-Controle, proposto por Karasek (1979), analisa a relação entre as exigências do trabalho e o nível de controle que o indivíduo possui sobre sua execução. Segundo essa abordagem, a combinação de altas demandas com baixo controle aumenta o risco de *Burnout*, enquanto atividades que oferecem maior autonomia

tendem a atuar como um fator de proteção contra o estresse ocupacional. Esse modelo é amplamente utilizado para avaliar o impacto dos fatores organizacionais no desenvolvimento na saúde do trabalhador.

O Modelo de Conservação de Recursos, desenvolvido por Hobfoll (1989), apresenta o *Burnout* como um processo resultante da perda ou ameaça aos recursos físicos, emocionais e sociais do indivíduo. A dificuldade em repor esses recursos leva ao esgotamento e à progressão da síndrome, sendo essa perspectiva frequentemente aplicada no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento voltadas para o fortalecimento dos recursos individuais.

Já a Teoria da Dissonância Cognitiva, quando aplicada ao *Burnout*, sugere que a síndrome se manifesta a partir do conflito entre as expectativas pessoais e a realidade do ambiente de trabalho. Esse desajuste intensifica o estresse crônico e pode levar ao agravamento da condição.

Em uma abordagem mais recente, Bakker e Demerouti (2007) propuseram o Modelo *Job Demands-Resources* (JD-R), estabelece uma relação entre as demandas ocupacionais e os recursos disponíveis. Segundo essa perspectiva, demandas ocupacionais elevadas aumentam o risco de esgotamento, enquanto recursos como suporte social e autonomia desempenham um papel protetor, atenuando os efeitos negativos das exigências do trabalho e contribuindo para a prevenção do *Burnout*.

Outros modelos também apresentam abordagens diferenciadas sobre a síndrome. O modelo de Kristensen *et al.* (2005) diverge da concepção de Maslach (1997) ao definir o *Burnout* com base na presença de fadiga e exaustão emocional. Nesse entendimento, a redução da realização pessoal é considerada uma consequência da síndrome, enquanto a despersonalização é vista como uma estratégia de enfrentamento. Com base nessa abordagem, foi desenvolvido o *Copenhagen Burnout Inventory* (CBI) para avaliação da condição, sendo o instrumento adotado neste estudo.

Outra perspectiva é apresentada pelo Modelo Bidimensional, proposto por Kalliath *et al.* (2000), que concebe o *Burnout* como composto exclusivamente por exaustão emocional e despersonalização, enquanto a redução da realização pessoal é tratada como uma variável independente, ocorrendo de forma paralela às demais dimensões.

Por fim, o modelo de Gil-Monte (2005) apresenta uma abordagem teórica do *Burnout* estruturada em quatro dimensões interligadas. A ilusão pelo trabalho representa o desejo de alcançar metas profissionais consideradas satisfatórias, enquanto o desgaste psíquico corresponde à exaustão emocional descrita por Maslach (1997). A indolência reflete a despersonalização, marcada pelo distanciamento emocional no ambiente profissional, e a culpa

se manifesta como um sentimento de responsabilidade por comportamentos que entram em conflito com normas internas ou sociais. Com base nesse modelo, Gil-Monte desenvolveu o *Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo* (CESQT) como instrumento de avaliação.

Conforme observado, a Síndrome de *Burnout* é uma condição complexa, cujas definições e modelos variam conforme a abordagem teórica. Desde a concepção inicial de Freudenberger até os modelos contemporâneos, como o JD-R, houve uma evolução significativa na compreensão da síndrome. Esses avanços permitiram o desenvolvimento de instrumentos específicos e estratégias de intervenção mais eficazes. A multiplicidade de perspectivas enriquece o campo, oferecendo bases sólidas para a implementação de ações preventivas e terapêuticas que promovam a saúde ocupacional e o bem-estar dos profissionais.

Este capítulo apresentou uma análise aprofundada sobre o *coping* espiritual, a síndrome de *Burnout* e a qualidade de vida, destacando suas conexões teóricas, práticas e os desafios enfrentados nos contextos de saúde e trabalho. A evolução conceitual do *coping* espiritual, desde sua formulação por Pargament (1997), até sua aplicação em estratégias de enfrentamento positivo e negativo, evidenciou sua relevância como recurso para lidar com adversidades. A relação entre *Burnout* e qualidade de vida foi abordada a partir de modelos clássicos e contemporâneos, mostrando sua complexidade e sua influência no bem-estar físico e mental.

Por fim, foi ressaltada a importância de integrar estratégias de enfrentamento baseadas na espiritualidade nos cuidados clínicos e ocupacionais, promovendo uma abordagem holística para a saúde mental e a qualidade de vida dos profissionais. Essa integração se mostra fundamental para desenvolver intervenções mais eficazes e humanizadas, alinhadas às demandas do contexto atual.

3 PERSPECTIVAS DE SAÚDE RELACIONADAS AO BURNOUT

O Burnout é uma síndrome que afeta simultaneamente os estados físico, emocional e comportamental dos indivíduos, comprometendo sua capacidade funcional e bem-estar geral. Alvarez e Fernandez (1991) descrevem que a Síndrome de Burnout se inicia com um quadro de tensão, marcando a primeira fase, quando o indivíduo percebe que as demandas do trabalho excedem seus recursos disponíveis para o enfrentamento.

3.1 A SINDROME DE BURNOUT

Segundo Maslach e Leiter (2016), trata-se de um problema complexo e multifacetado, influenciado por fatores individuais e organizacionais. Entre os principais sintomas observados, destacam-se:

- **Físicos:** fadiga crônica, dores de cabeça, insônia, problemas gastrointestinais, alterações no peso corporal e maior vulnerabilidade a doenças. Estudos como os de Melamed *et al.* (2006) destacam que esses sintomas refletem o impacto do estresse prolongado sobre os sistemas cardiovascular, imunológico e metabólico, exacerbando condições preexistentes.
- **Emocionais:** ansiedade, depressão, sensação de fracasso, perda de motivação e baixa autoestima. Esses sintomas são frequentemente associados à exaustão emocional descrita por Maslach e Jackson (1981), representando a incapacidade de lidar com as demandas emocionais do trabalho.
- **Comportamentais:** irritabilidade, isolamento social, abuso de substâncias como álcool e medicamentos, e atitudes cínicas em relação ao trabalho. Freudenberg (1974) já havia identificado tais comportamentos como respostas frequentes ao esgotamento profissional.

Sob o prisma dos modelos de saúde pública, o *Burnout* é reconhecido como um problema sistêmico que requer intervenções tanto no nível individual quanto no organizacional. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica o *Burnout* no CID-11 como um fenômeno ocupacional, reforçando a necessidade de políticas de saúde ocupacional que abordem as causas estruturais da síndrome (WHO, 2019).

3.1.1 Abordagens e Estratégias de Prevenção e Manejo

Programas de promoção à saúde mental no trabalho são considerados essenciais para prevenir e manejar a síndrome. Conforme Bakker e Demerouti (2007), o Modelo *Job Demands-Resources* (JD-R) sugere que a redução das demandas ocupacionais combinada com o fortalecimento de recursos, como suporte social e autonomia, pode mitigar os efeitos negativos do estresse crônico. Além disso, práticas de autocuidado, como a promoção de hábitos saudáveis (alimentação balanceada, exercícios físicos e sono adequado), são indispensáveis para a resiliência individual (Sonnetag; Fritz, 2015).

No nível organizacional, intervenções que envolvam a reestruturação de processos de trabalho, treinamentos em gestão do tempo e programas de suporte psicológico são fundamentais. De acordo com Karasek (1979), trabalhos que oferecem maior autonomia e

controle tendem a proteger os indivíduos contra o desenvolvimento do *Burnout*. Além disso, a implementação de espaços seguros para a discussão de demandas emocionais pode ajudar a construir uma cultura de apoio mútuo e reduzir o estigma associado ao estresse ocupacional (Hobfoll, 1989).

3.1.2 Impactos do *Burnout* na Saúde Sistêmica

Os impactos da Síndrome de *Burnout* extrapolam a esfera individual, comprometendo diretamente a produtividade organizacional e a eficiência dos sistemas de saúde. Pesquisas como as de Pasqualucci *et al.* (2019) apontam que a síndrome está associada a altos índices de absenteísmo, rotatividade e afastamentos por problemas de saúde. Tais consequências implicam custos elevados para as instituições e intensificam a sobrecarga dos profissionais remanescentes, perpetuando um ciclo de esgotamento coletivo.

3.1.3 Necessidade de Abordagens Multidimensionais

As definições e modelos de saúde relacionados ao *Burnout* fornecem uma estrutura essencial para compreender suas causas, manifestações e impactos. A abordagem multidimensional da síndrome, que combina os modelos teóricos de Maslach (1981), Karasek (1979) e Hobfoll (1989), permite a criação de intervenções baseadas em evidências que integram os aspectos físico, emocional e organizacional do *Burnout*.

Por exemplo, a integração de estratégias de *mindfulness* e técnicas de *coping* emocional tem demonstrado eficácia na redução dos sintomas de exaustão emocional e ansiedade (Chiesa; Serretti, 2009). Além disso, intervenções que promovem o fortalecimento de comunidades no ambiente de trabalho, como sugerido por Moreira-Almeida (2006), renomado por sua ênfase na dimensão espiritual/existencial e na saúde, contribuem para o suporte social e a sensação de pertencimento, essenciais para a resiliência.

3.2 A ÉTICA DA ALTERIDADE E O FUNDAMENTO DO CUIDADO INTEGRAL

A ética que é inspirada na filosofia de Levinas (1982; 2005), deve ser entendida além de um conjunto de normas, configurando-se como uma postura existencial de alteridade — o reconhecimento da singularidade radical do Outro. Trata-se de um esforço contínuo de acolhimento e resposta que requer abdicar do egocentrismo e abrir-se para o compromisso

verdadeiro. Essa perspectiva sustenta a ‘Atenção Integral’, a qual reconhece o sofrimento humano em suas múltiplas dimensões — física, mental, social e existencial — como uma resposta legítima às injustiças sociais e à dimensão ética da alteridade. É esse acolhimento da diferença profunda do Outro, mesmo quando traumático, que capacita o indivíduo a transcender a passividade, transformando-se em sujeito ativo de sua própria recuperação, configurando o cerne do empoderamento e do cuidado integral.

Para Levinas (2005, p. 269) a dimensão ética se traduz na responsabilidade de ser por, pelo e para o outro. Distanciando-se da filosofia tradicional, ele enfatiza a escuta atenta, na qual a presença do outro questiona a “alegre posse do mundo” e me impõe uma ordem. Essa escuta ética, de cunho radical, exige dispor-se a responder ao sofrimento do outro (sua nudez e miséria). Conforme ressalta Freire (2003, p. 14), essa resposta é responsabilidade e se manifesta no acolhimento, que significa oferecer ao outro um “*ethos*”, uma morada confiada e serena para que ele possa se renovar. A radicalidade reside na impossibilidade de se ficar “alérgico a outrem”, pois “o ser que se exprime impõe-se, mais precisamente apelando para mim da sua miséria e da sua nudez - da sua fome - sem que eu possa ser surdo ao seu apelo” (Levinas, 2005).

É a partir dessa reflexão levinasiana que a alteridade se torna fundamental para a construção da empatia, da escuta qualificada e do diálogo no cuidado. Nessa perspectiva, o papel de profissionais de saúde é central, pois são eles que, no cotidiano, tornam concreto o compromisso com um cuidado ético e humanizado. Contudo, na atualidade, a indiferença ao outro é crescente, e não se pode ignorar o risco de lidar com ele como um objeto de interesse e atuação técnica, o que anula a alteridade. Pôr em questão o saber e o poder sobre o outro — como a pessoa enferma na instituição de saúde — é imperativo para ouvi-lo em seu sofrer, resgatando o cuidado como função maior, superando a ideia de obrigação moral.

A importância de resgatar a dimensão ética levinasiana reside na possibilidade de entender os atores da saúde como sujeitos da responsabilidade pelo outro. Ao retomarmos o conceito de cuidado, cabe assinalar que ele é frequentemente mal interpretado e reduzido à sua dimensão técnica (assistência e tratamento), nivelando-o à cura e ao controle de sintomas. Essa redução é típica de modelos tradicionais, como o biomédico, focado no diagnóstico, que anula a alteridade e o saber vindo do usuário, tratando-o como objeto de intervenção tecnicista.

A partir da escuta ética da alteridade radical, consideramos possível aos profissionais ir além dessa intervenção objetificada. É possível promover a escuta do outro de outro modo e, assim, assumir a caracterização de um sujeito ético-político. Sujeito esse que busca refletir constantemente sobre suas ações e se deixa afetar pelo outro, tornando-se mais capaz de dar

acolhimento e morada – *ethos* - à alteridade, pois, como ressaltou Boff (1999), o encontro com o outro promove o *ethos* necessário à sociabilidade. Tal postura é especialmente relevante no campo da saúde mental, onde a demanda hoje é pela construção da cidadania e a reinserção dos sujeitos na comunidade, pontos basilares da atenção psicossocial.

Não obstante a necessidade de um cuidado ético-político, o ideal de ‘saúde total’ (OMS) contrasta fortemente com a realidade estrutural do adoecimento laboral. Assim, o adoecimento não pode ser reduzido a um mero acidente biológico; ele configura um fenômeno social e uma denúncia ética, revelando a falência das estruturas sociais. Essa falência é materializada por fatores como pobreza, desigualdade e precarização do trabalho. O corpo adoecido torna-se o espaço visível das desigualdades e injustiças, expressando o ponto de ruptura onde a dignidade humana e a justiça social foram violadas, sinalizando o colapso do contrato social. Diante desse diagnóstico, a intervenção deve ultrapassar o âmbito clínico individual para atuar nas causas estruturais que geram o sofrimento.

3.2.1 A Responsabilidade Radical e o Diálogo Político-Estrutural

A urgência de intervenção estrutural é reafirmada pela fragilidade das nossas bases sociais. Em Sousa (2018), a complexidade dessa responsabilidade é abordada por outros pensadores. Para o autor, Derrida complementa Levinas, ao introduzir a aporética da justiça como uma abertura para o “Outro”, a qual não pode ser totalmente codificada ou institucionalizada. Essa abertura, que exige uma reavaliação constante das ações, destaca a tensão entre a lei universal (o sistema) e a responsabilidade ética, que é sempre particular e dependente do contexto. O filósofo da linguagem Bakhtin, por sua vez, aborda a alteridade como constitutiva do sujeito, exigindo um ato responsável (*postupok*), que é uma resposta ativa e não indiferente à singularidade do evento da vida (Sousa, 2018). Essa perspectiva sustenta a crítica à separação entre o ‘mundo da cultura’ (a teoria abstrata e técnica) e o ‘mundo da vida’ (a experiência concreta do adoecimento). Neves busca conciliar essa responsabilidade radical com as realidades práticas do direito, advogando por uma ‘unidade integradora de sentido’ que incorpore a reciprocidade no arcabouço legal. Seu esforço visa equilibrar a primazia ética do Outro com a necessidade de comparabilidade e equidade dos sistemas (Sousa, 2018).

Assim, do ponto de vista de Sousa (2018), as filosofias de Levinas, Derrida, Bakhtin e Neves convergem na crítica fundamental ao pensamento monológico, um paradigma que insufla a ideia de que a verdade é uma propriedade singular e absoluta, negando assim a multiplicidade de perspectivas que enriquecem a nossa compreensão da realidade. Essas

abordagens não apenas questionam a ortodoxia filosófica, mas também propõem a elevação da responsabilidade diante da singularidade do Outro como o imperativo que deve fundar a ética, a justiça e, em última análise, a transformação das estruturas de saúde.

A noção de responsabilidade — seja ela infinita, aporética, do ato ou recíproca — torna-se a ferramenta inadiável para impedir o fechamento do sistema sobre o ‘Mesmo’ e garantir a integridade da vida. Ao praticarmos a alteridade, reconhecemos que a vivência do Outro não é uma ameaça, mas sim uma oportunidade para expandir nossa própria compreensão do ser. Este relacionamento dinâmico propõe não apenas uma reavaliação da ética em sentidos tradicionais, mas também uma reformulação da reação diante das desigualdades presentes nas estruturas sociais e de saúde (Sousa, 2018).

Desse modo, ao alinharmos espiritualidade, ética e alteridade, podemos desvendar novos caminhos para a promoção de justiça social. A transformação das estruturas de saúde, assim, não é apenas uma meta administrativa, mas um verdadeiro projeto de humanidade, onde cada interação com o Outro tem o potencial de reconfigurar nossa própria identidade e reforçar os laços sociais que são imprescindíveis para a um convívio harmônico e respeitoso em sociedade. Essa crítica incisiva proposta por esses pensadores torna-se não apenas uma reflexão teórica, mas uma chamada à ação que nos desafia a viver de forma mais consciente e responsável.

Este capítulo estabeleceu as bases conceituais da pesquisa. Primeiramente, explorou-se a Síndrome de *Burnout* como um fenômeno ocupacional complexo, detalhando seus impactos físicos, emocionais e comportamentais e as estratégias de prevenção e manejo baseadas em modelos como o JD-R (*Job Demands-Resources*), que reforçam a necessidade de ações integradas e suporte. Contudo, a discussão transcendeu a abordagem puramente pragmática ao introduzir a Ética da Alteridade Radical, em Levinas (1985; 2005) e o Fundamento do Cuidado Integral. Essa perspectiva filosófica exige o reconhecimento da vulnerabilidade do Outro e a responsabilidade radical perante seu sofrimento. Ao confrontar as estratégias de manejo do *Burnout* com a Ética da Alteridade, estabeleceu-se que o adoecimento laboral, motivado pela precarização do trabalho e omissão institucional, configura uma denúncia social e uma falha ética, e não apenas um acidente biológico.

Enquanto o manejo do *Burnout* sugere a redução de demandas e o fortalecimento de recursos, a Ética da Alteridade impõe a exigência de transformação das estruturas que geram o sofrimento. A análise que se segue buscará, à luz desse referencial ético-político, interpretar os achados empíricos sobre o *coping* espiritual dos docentes, avaliando se essa estratégia

individual atua como um recurso de resiliência ou como uma compensação espiritual para a ausência da responsabilidade institucional e da justiça social.

4 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS DOCENTES DE ENFERMAGEM

A qualidade de vida tem ganhado relevância em diversas áreas das ciências humanas e biológicas, refletindo uma visão que vai além do simples controle de sintomas ou do aumento da expectativa de vida. Autores como Fleck *et al.* (1999) associam qualidade de vida diretamente à saúde, enquanto outros, como Renwick e Brown (1996), a vinculam à felicidade e satisfação pessoal, e Nahas (2017) ao estilo de vida. Essa abordagem multidimensional integra aspectos físicos, psicológicos e sociais que afetam o bem-estar individual e coletivo, destacando a importância de fatores contextuais e subjetivos (Dantas, Sawada; Malerbo, 2003; Seidl; Zannon, 2004).

4.1 ASPECTOS CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS NA AVALIAÇÃO DA QVT

A avaliação da qualidade de vida é complexa e exige delimitações conceituais que permitam sua análise científica. Farquhar (1995) observa que a definição pode variar desde uma visão global de satisfação com a vida até uma análise segmentada em componentes específicos. Essas abordagens facilitam a medição objetiva e subjetiva, permitindo sua aplicação em diferentes contextos de pesquisa.

Etimologicamente, o termo qualidade deriva do latim *qualis*, que se refere ao modo de ser, abrangendo tanto características positivas quanto negativas. No entanto, o conceito de qualidade de vida geralmente se associa a aspectos positivos e desejáveis (Santin, 2002). Buss (2000) destaca que, embora a saúde contribua significativamente para a qualidade de vida, alcançar altos padrões de bem-estar requer uma abordagem ampla, que envolva políticas públicas eficazes e ações intersetoriais.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), qualidade de vida é a percepção que o indivíduo tem de sua posição na vida, considerando o contexto social e cultural em que está inserido, além dos valores predominantes na sociedade (WHOQOL, 1994; Minayo, Hartz; Buss, 2000). Essa definição abrange tanto aspectos internos, como satisfação pessoal e metas individuais, quanto externos, como condições sociais e culturais que moldam as oportunidades e desafios enfrentados.

4.1.1 Determinantes da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)

O conceito de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) surgiu na década de 1920, com estudos que destacaram os fatores que influenciam o bem-estar no ambiente laboral. Entre esses fatores, o relacionamento interpessoal, a liberdade de expressão e a satisfação no trabalho se destacam como aspectos centrais. A experiência de Hawthorne, conduzida por Mayo em 1959, revelou que a produtividade está mais ligada a fatores psicológicos e sociais, como apoio grupal, do que às condições físicas do ambiente (Rodrigues, 1994).

Chiavenato (1989) afirma que A teoria da motivação de Maslow, desenvolvida em 1971, e a Teoria dos Dois Fatores de Herzberg, de 1968, são fundamentais para a compreensão da QVT. Segundo o autor, enquanto Maslow apresenta uma hierarquia de necessidades que vai das fisiológicas às de autorrealização, Herzberg diferencia fatores higiênicos, como salário e condições de trabalho, de fatores motivacionais, como reconhecimento e desenvolvimento pessoal. Essas teorias indicam que a satisfação no trabalho está relacionada a uma combinação de fatores que vão além das recompensas financeiras.

Fernandes (1989), por sua vez, apresenta um modelo conceitual de QVT foi desenvolvido por Walton, em 1973, que inclui oito critérios fundamentais, como compensação justa, condições de trabalho adequadas e integração social. Esse modelo conceitual enfatiza que a QVT é um processo dinâmico, com expectativas dos trabalhadores em constante evolução. Hackman e Oldham (1975) também contribuíram ao destacar três estados psicológicos essenciais para a satisfação no trabalho: significância do trabalho, responsabilidade percebida e conhecimento dos resultados.

No Brasil, a Constituição de 1988 consagra o trabalho como direito fundamental, mas crises sociais têm limitado o exercício pleno desse direito (Tavares, 1996). Na enfermagem, o trabalho envolve cuidar do corpo humano, no contexto saúde-doença, integrando conhecimentos técnicos e relações interpessoais (Marx, 1994; Silva, 1996). Contudo, fatores como sobrecarga de trabalho, remuneração inadequada e desmotivação estudantil geram estresse significativo. A ausência de mecanismos de mediação e apoio institucional agrava essa situação, enquanto o desenvolvimento de alunos e a satisfação em ensinar são elementos que potencializam a QVT (Mauro, 1977).

Estudos específicos sobre a enfermagem destacam a necessidade de estratégias para prevenir a ‘fadiga imprópria’, que persiste mesmo após períodos de descanso. Esses achados reforçam a importância de compreender os fatores de desgaste e os elementos que promovem

o bem-estar dos docentes, indicando a relevância de ações institucionais para melhorar a saúde e a qualidade de vida no ambiente de trabalho (Rocha; Felli, 2004).

Dessa forma, este capítulo abordou a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) dos docentes de enfermagem, destacando a complexidade de sua avaliação e a relevância de aspectos físicos, psicológicos e sociais no bem-estar laboral. A QVT foi apresentada como um conceito multidimensional que integra tanto percepções individuais quanto fatores contextuais, como condições de trabalho e relações interpessoais.

A partir de modelos teóricos, foram explorados os determinantes da QVT, incluindo fatores higiênicos, motivacionais e de integração social. No contexto da enfermagem, desafios como sobrecarga de trabalho e remuneração inadequada contrastam com elementos positivos, como a satisfação em ensinar e a contribuição para o desenvolvimento estudantil, destacando a dualidade do trabalho docente.

Os achados reforçam a necessidade de estratégias institucionais para mitigar o desgaste emocional e físico, prevenindo a ‘fadiga imprópria’ e promovendo ambientes de trabalho saudáveis. A QVT, assim, emerge como um componente central para a valorização dos docentes de enfermagem e a melhoria das condições laborais no setor educacional.

5 GÊNERO SOB O OLHAR PLURAL: UMA ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO CONCEITO E SUAS IMPLICAÇÕES NA SAÚDE E EQUIDADE SOCIAL

“[...] algumas vezes não é uma questão de primeiro ter o poder e então ser capaz de agir; algumas vezes é uma questão de agir, e na ação, reivindicar o poder de que se necessita” (Butler, 2018, p. 65).

Neste capítulo, partindo de suas definições e conceitos iniciais, exploraremos como a teoria de gênero se transformou ao longo da história, influenciando o modo como entendemos a identidade, o poder e as interações sociais.

5.1 DESVENDANDO O CONCEITO DE GÊNERO: FUNDAMENTOS PARA ENTENDER SEUS EFEITOS NAS RELAÇÕES DE PODER

O termo gênero vem do latim *genus*, referindo-se a tipo, família, origem e nascimento (Carvalho, 2020). No entanto, esse significado etimológico é simplista e não reflete a complexidade que o conceito adquiriu, pois mudou radicalmente ao longo do tempo passando a abranger uma ampla gama de identidades humanas e relações sociais.

5.1.1 A Evolução do Conceito de Gênero: De sua Origem à Dinâmica de Poder

Segundo Lattanzio e Ribeiro (2018), na década de 1950 a noção de gênero ganhou relevância na psicologia, distinguindo sexo biológico de identidade de gênero. O psicólogo John Money, em 1981, foi o primeiro a usar o termo para diferenciar entre sexo anatômico e psicológico, argumentando que o papel de gênero não é inato, mas se desenvolve em um processo de socialização que começa no nascimento. Esse psicólogo comparou a formação de gênero em humanos ao fenômeno de *imprinting* em aves, que se estabelece logo após o nascimento. Embora sua teoria fosse um esboço inicial, ela estimulou pesquisas subsequentes sobre identidade sexual nas esferas psicológica e política.

Para os autores, o psicanalista americano Robert Stoller ampliou o debate no início dos anos 1960, escrevendo que o gênero não deveria ser tratado como uma condição isolada, mas como um resultado social e externo. Em contraste com a noção de Freud, ele enfatizou o papel do "outro" no desenvolvimento do eu. Stoller determinou que a identidade de gênero se desenvolve no contexto das relações iniciais, tipicamente com a mãe. Seu modelo destaca a complexidade da autoidentidade em relação aos efeitos das variáveis interpessoais na autopercepção e no comportamento de gênero (Lattanzio; Ribeiro, 2018).

Mas a identidade de gênero é muito mais rica do que isso, uma mistura completamente fluida de elementos sociais, culturais e psicológicos, talvez, mais importante, os sentimentos pessoais de cada um.

De qualquer forma, a tensão entre sexo e gênero sofre sob as leis de um tipo de masculinidade tóxica. Para esses, todas as mulheres eram completamente inúteis, nem boa companhia nem confortáveis de se estar. E não se trata apenas de aparência, roupas e outras coisas exteriores; as mulheres são fracas, como pode ser provado na prática, mesmo quando objetos muito pequenos são examinados ou padrões de aparência são estabelecidos para as mulheres porque é assim que elas devem se ver.

A identidade de gênero não é apenas sobre ser homem ou mulher; é uma categoria muito mais rica que abrange todos os tipos de fatores sociais, culturais e psicológicos, até mesmo questões pessoais. A visão binária convencional de gênero muitas vezes força as pessoas a desempenharem papéis que normalmente não escolheriam; isso pode resultar em assumir menos facilmente papéis de liderança (ou eleger aqueles que não buscam nenhuma posição de poder).

Uma sociedade que respeita a diversidade das identidades de gênero e permite que todos se explorem de maneira honesta (como se sentem ser) se tornará uma que mais empatiza com as pessoas que sofrem com as injustiças da vida.

Ainda segundo Lattanzio e Ribeiro (2018), o pós-estruturalismo no século XX (1980–1990) trouxe um novo desafio às concepções de sexo e gênero. Para pensadores como Foucault (1979), Louro (1997) e Meyer (2004), a distinção entre sexo e gênero já não era suficiente, pois eles argumentavam que tanto o corpo quanto o gênero são produções sociais, históricas e culturais, enraizadas em discursos e normas.

A filósofa Butler (2003) aprofundou essa ideia, argumentando que o gênero não é algo que ‘somos’, mas algo que ‘fazemos’. Desde o nosso nascimento, somos treinados para seguir uma série de papéis sociais e padrões de comportamento. Essa repetição contínua e, em grande parte, inconsciente, faz com que o gênero pareça algo natural. Dessa forma, somos empurrados para os limites da heteronormatividade, que impõe a ideia de que a heterossexualidade é a norma e que existem apenas dois gêneros. O resultado é que a imitação do que a sociedade dita como o ‘verdadeiro’ homem ou mulher se torna nossa identidade. Essa teoria busca dismantelar o pensamento binário para reconhecer a diversidade de identidades (Butler, 2003).

Essa perspectiva se alinha à visão de Scott (1995), que define o gênero como a principal linguagem pela qual as relações de poder são interpretadas, e ao conceito de poder desenvolvido por Foucault, a partir de 1979, que opera nas ‘pequenas instâncias’ do dia a dia. A subjetividade em relação ao gênero é construída pelas representações disponíveis de homens e mulheres (Bourdieu, 2021).

Essa crítica se estende à colonialidade, descrita como o ‘lado sombrio e necessário da Modernidade’ (Balestrini, 2013). A colonialidade é apresentada como uma matriz de identidade racializada que serve ao controle social e determina a forma como o gênero e a sexualidade são estabelecidos (Carvalho, 2001; Quijano, 2005).

Em uma era de mudanças contínuas, as concepções de gênero evoluem, sinalizando transformações sociais, culturais e históricas. A educação e o mercado de trabalho devem se adaptar para compreender o gênero como algo fluido e não como uma imposição binária.

O debate sobre gênero e identidade de gênero, especialmente a transgênera, torna-se cada vez mais pertinente. Esse diálogo é essencial para construir uma sociedade mais ética e responsável, que reconheça a diversidade de experiências. A Enfermagem, por exemplo, embora seja uma profissão majoritariamente feminina, desafia a ideia de que o gênero determina a vulnerabilidade, mostrando que as normas sociais podem perpetuar a discriminação independentemente do sexo de alguém.

Ao desconstruir essas barreiras normativas, abrimos espaço para uma sociedade mais inclusiva e para o reconhecimento de que a diversidade é uma força, não uma fraqueza.

5.1.2 Articulação: Gênero, Alteridade e Ética a Partir de Levinas

As investigações psicológicas iniciais sobre gênero, conforme destacam Lattanzio e Ribeiro (2018), indicam que o gênero não é uma característica inata, mas um processo social e relacional, influenciado de modo decisivo pelas interações com o outro desde os primeiros momentos de vida, conforme já apontado na teoria do *imprinting* de John Money. Stoller (1968) ressaltou que o desenvolvimento da identidade de gênero ocorre no contexto das relações interpessoais precoces, sobretudo com a mãe, destacando o papel constitutivo do ‘outro’ no surgimento do eu.

Essa ênfase na alteridade como fundamento subjetivo encontra importante interlocução com a filosofia de Levinas (2005), para quem a identidade do sujeito não se forma em isolamento, mas no encontro com o outro. Na obra levinasiana, a ética emerge da responsabilidade incondicional pelo rosto do outro — uma exigência que rompe a solidão do eu e inaugura uma abertura fundamental.

Aplicando esse prisma ao debate sobre gênero, percebe-se que a identidade de gênero não deve ser compreendida apenas como um constructo social ou psicológico, mas também como uma realidade ética e relacional, em que o reconhecimento mútuo e a responsabilidade pelo outro são aspectos centrais.

Ao enunciar que o ‘eu’ está sempre em relação com o outro, Levinas (2005) provoca a problematização das imposições rígidas do binarismo de gênero, valorizando a singularidade e a autonomia da experiência subjetiva em sua relação ética com a alteridade. Essa perspectiva complementa as análises pós-estruturalistas, como as de Butler (2003), que concebe o gênero como uma construção performativa, e as investigações acerca das relações de poder que atravessam as práticas sociais.

Ademais, a ética levinasiana permite compreender como normas sociais e estruturas de poder — como a heteronormatividade e a colonialidade — atuam para restringir a liberdade de ser e negam o reconhecimento integral do outro. Assim, a alteridade ética reprova atitudes desumanizadoras que excluem identidades diversas, defendendo uma sociedade pautada no respeito radical à diferença e na responsabilidade pelos mais vulneráveis, incluindo pessoas transgêneras e racializadas.

Dessa forma, a articulação entre psicologia, psicanálise, pensamento pós-estruturalista e filosofia ética contribui para uma compreensão integrada da identidade de gênero como construção social e cultural em multicamadas, que reclama a abertura ética a cada indivíduo na sua singularidade e irrepetibilidade. Essa ampliação propicia não apenas uma crítica das dinâmicas sociais, mas também um alicerce moral para a construção de uma sociedade inclusiva que valorize a diversidade como expressão genuína da alteridade humana.

Enfim, para esta investigação a filosofia de Levinas (2005) enriquece o debate sobre gênero ao introduzir uma dimensão ética imprescindível para pensar a identidade como um processo aberto de relação e responsabilidade pelo outro, fortalecendo as abordagens psicológicas e culturais e ampliando a reflexão sobre inclusão, reconhecimento e justiça social.

5.1.3 Gênero e Saúde Mental na Trajetória da Enfermagem

A Enfermagem é um campo profissional onde a intersecção entre gênero e saúde molda diretamente os saberes e as práticas. No Brasil do século XX, a profissão foi modernizada sob uma abordagem higienista que, paradoxalmente, associou o papel das enfermeiras a uma ‘missão divina’ e ao ‘instinto materno’ (Lopes, 1998; Sobral, 1995; Parsons, 1997). Essa visão, baseada na crença de que qualidades do cuidado seriam naturais das mulheres, influenciou o recrutamento majoritariamente feminino para a área, ao mesmo tempo em que criou obstáculos para a participação masculina, revelando preconceitos de gênero (Lopes; Leal, 2005; Lopes, 1996).

Durante as décadas de 1960 e 1970, a expansão hospitalar focou na redução de custos, o que impactou diretamente a Enfermagem. Segundo Lautert (1997), essa lógica resultou na contratação de profissionais com baixa qualificação e remuneração, que, devido à fragilidade política da categoria, tinham pouca autonomia. A herança de uma visão religiosa e vocacional da profissão reforçava a exploração, destacando a obediência e o ‘espírito de servir’ como qualidades desejáveis.

A expansão do setor de saúde continuou nas décadas seguintes, mas sem uma melhoria significativa nas condições de trabalho (Elias; Navarro, 2006). Os profissionais enfrentam longas jornadas, falta de pessoal e um ambiente hospitalar inerentemente estressante e de alto risco. A baixa remuneração, que exige duplos empregos, intensifica ainda mais o desgaste.

Não surpreende que a literatura científica aponte um aumento nos casos de adoecimento psíquico, uso de medicamentos e suicídios entre esses profissionais (Elias; Navarro, 2006). Para as mulheres na área, esse cenário se agrava por traços culturais que as sobrecarregam com as

responsabilidades domésticas e familiares, dificultando sua plena participação no mercado de trabalho (Matos, 2003b).

Atualmente, a Enfermagem ainda enfrenta a perpetuação de estereótipos de gênero e a falta de reconhecimento. A dominação simbólica, uma forma de violência não física que perpetua desigualdades por meio de valores e normas sociais, continua a afetar o bem-estar e as oportunidades dos profissionais (Bourdieu, 2010; Lopes; Souza, 1997). Diante disso, o desenvolvimento de uma consciência de gênero é fundamental para compreender os mecanismos ideológicos que moldam a profissão e para promover transformações nas dinâmicas de poder e conhecimento.

5.2 A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DE GÊNERO PARA AVANÇAR NA EQUIDADE E COMPREENSÃO DAS VULNERABILIDADES

A considerar a importância do papel do gênero na compreensão das interações sociais e das identidades de indivíduos transgêneros ou não binários; este estudo optou por utilizar o gênero como um elemento central de análise ainda que não tenha explicitamente identificado tais identidades em suas descobertas originais.

É defendida a necessidade premente da inclusão mais aprofundada do tema tanto na formação quanto nas práticas educacionais na área da saúde, uma solicitação que tem sido enfatizada por várias entidades de saúde em escala global, inclusive pelo Ministério da Saúde brasileiro.

5.2.1 Um Olhar Essencial para a Equidade e o Combate à Vulnerabilidade.

A crescente participação de pessoas trans e não binárias como profissionais, estudantes e pacientes nas áreas da enfermagem e educação ressalta a urgência de um olhar mais humano. No entanto, mesmo com essa maior visibilidade, o ambiente escolar ainda é, para muitos, um lugar hostil, onde vivências de preconceito e humilhação são uma realidade constante, conforme evidenciam os estudos de Bento (2011), bem como os de Souza e Bernardo (2014).

Diante desse contexto de hostilidade e preconceito, é crucial reconhecer que todos os indivíduos enfrentam vulnerabilidades em sua saúde mental e que o esgotamento pode se manifestar, independentemente da sua identidade de gênero. Promover o bem-estar e a qualidade de vida, portanto, deve ser uma prioridade nas atividades dos profissionais da enfermagem e na prática docente. Para promover uma prática profissional realmente inclusiva

e equitativa é essencial compreender as complexidades da identidade de gênero. Essa necessidade persiste mesmo com o avanço contínuo da pesquisa voltada para as populações transgênero e não binárias (Silva et al 2015).

Nesse contexto desafiador no Brasil houve um grande avanço jurídico em 2019 com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que equiparou a homofobia e a transfobia aos crimes de racismo através da aplicação da Lei nº 7.716/1989 até que o Congresso Nacional desenvolva uma legislação específica sobre o assunto. Essas medidas judiciais são fundamentais para combater a discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero, e se somam a outras leis significativas, como a extensão da Lei Maria da Penha, para proteger mulheres trans e travestis e a implementação de cotas em concursos públicos para indivíduos trans em alguns estados.

A acolhida requer uma visão ampliada e verdadeiramente inclusiva que englobe o total respeito à identidade de gênero da pessoa individualmente; a utilização coerente do nome social e dos pronomes apropriados; a assecuração da privacidade e confidencialidade; e o permanente investimento na formação e conscientização dos profissionais envolvidos. No que diz respeito a esse assunto em específico, assegurar o direito ao uso do nome social e validar identidades de gênero são fundamentados por medidas como o Decreto de número 8.727 /2016, que regula esse tema no contexto da administração pública federal, destacando quão crucial é o respeito à autonomia individual.

Adicionalmente, o Provimento nº 73/2018 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), garante o direito à mudança do nome e gênero no registro civil para pessoas trans diretamente no cartório sem exigir aprovação judicial prévia ou prova de cirurgia. Isso solidifica o reconhecimento legal da identidade de gênero no Brasil.

Na área da saúde destaca-se o impactante papel das normativas do SUS que regem o processo de transexualidade e o acesso às cirurgias de redesignação sexual; bem como da Política Nacional de Saúde Integral LGBT que busca assegurar um atendimento completo e respeitosamente qualificado para essa comunidade específica. A promoção de ambientes acolhedores para cuidados médicos e o apoio às políticas públicas visando equidade no acesso aos serviços de saúde e à qualidade de vida constituem medidas fundamentais para o bem-estar global desse grupo populacional.

Neste capítulo, mergulhamos no complexo universo do conceito de gênero, explorando sua evolução histórica e teórica para além de algumas definições. Analisamos como o gênero, compreendido como uma construção social e cultural, molda as relações de poder e a experiência humana. Aprofundamos a discussão sobre a análise de gênero como uma

ferramenta fundamental para identificar e enfrentar as desigualdades sociais. Exploramos como a compreensão das dinâmicas de gênero é crucial para mapear as vulnerabilidades em diferentes contextos, especialmente na saúde, e para promover a equidade. Nosso alvo foi desvendar os fundamentos teóricos que demonstram como as normas de gênero não apenas definem papéis e comportamentos, mas também influenciam a saúde mental e o bem-estar, impactando diretamente o cotidiano de cada indivíduo. Por fim, demonstramos que, ao reconhecer e desconstruir os padrões de gênero, é possível criar ambientes mais justos e inclusivos para todos.

6 CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRABALHO E SUA JORNADA PELA HISTÓRIA E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS

O trabalho, ao longo da história, desempenhou um papel central tanto na organização social quanto na construção da identidade individual. Ele carrega significados diversos, sendo ora visto como uma obrigação indispensável para a sobrevivência, ora como uma fonte de realização pessoal e prazer. Essa dualidade reflete os desafios e mudanças nas dinâmicas laborais ao longo dos séculos, moldadas pelos contextos sociais, econômicos e históricos.

6.1 PERSPECTIVAS CONCEITUAIS E HISTÓRICAS SOBRE O TRABALHO

Na Grécia antiga, o trabalho físico era relegado aos escravos, enquanto o ócio criativo era privilégio das elites. Para Aristóteles, o trabalho era necessário, mas inferior, contrastando com o cultivo do intelecto e das virtudes. Durante a Idade Média, o trabalho adquiriu um caráter moral e religioso, sendo considerado tanto uma penitência quanto um meio de redenção espiritual. Com a Revolução Industrial, o trabalho foi redefinido: embora tenha aumentado a produtividade, introduziu jornadas extenuantes, baixos salários e condições insalubres, o que motivou o surgimento de regulamentações e movimentos sindicais.

No mundo contemporâneo, o avanço tecnológico e a automação têm transformado as formas de organização laboral, substituindo funções repetitivas e criando exigências. Apesar desses avanços, desafios como precarização, desigualdade de gênero e impactos na saúde mental persistem, reforçando a necessidade de políticas públicas e práticas organizacionais que promovam ambientes de trabalho mais saudáveis e justos.

6.1.1 A Relação entre Trabalho e Saúde

A relação entre trabalho e saúde tem sido estudada desde os séculos passados, Bernardino Ramazzini, considerado o pai da medicina ocupacional, em sua obra *De Morbis Artificum Diatriba*, de 1700, analisou os problemas de saúde enfrentados por trabalhadores em diferentes profissões, destacando os impactos do trabalho na saúde física e mental. Sua contribuição pioneira lançou as bases para reflexões posteriores sobre condições laborais e saúde ocupacional, influenciando debates que permanecem relevantes até hoje (Ramazzini, 2016).

Durante a Revolução Industrial, estudos como os de Friedmann e Naville (1962) exploraram os impactos do modelo taylorista e fordista, que priorizavam a eficiência em detrimento das necessidades humanas. Essas análises identificaram dinâmicas de alienação, desgaste e intensificação do trabalho, revelando os custos físicos e psicológicos para os trabalhadores. Essas transformações, ao mesmo tempo em que aumentaram a produtividade, trouxeram desafios significativos para a saúde e o bem-estar, evidenciando a necessidade de políticas laborais mais humanizadas.

6.1.2 Revoluções Industriais e Seus Impactos

A Primeira Revolução Industrial, no século XVIII, marcou o início do uso intensivo de mão de obra assalariada, caracterizada por jornadas extenuantes e condições insalubres. As trabalhadoras, especialmente nas indústrias têxteis, enfrentavam baixos salários e doenças ocupacionais, como problemas respiratórios. Em resposta, surgiram movimentos sindicais e demandas por regulamentação, que moldaram os direitos laborais modernos (Marx, 1968; Minayo-Gomez; Costa, 1997).

No contexto contemporâneo, profissões como a Enfermagem refletem paralelos com a exploração feminina da era industrial. Predominantemente composta por mulheres, a enfermagem enfrenta sobrecarga de trabalho, baixa remuneração e desafios emocionais. Durante a pandemia de COVID-19, essas condições se agravaram, expondo enfermeiras a jornadas extensas e à falta de recursos, evidenciando a necessidade de políticas de proteção e valorização da força de trabalho feminina (Silva *et al.*, 2020).

A evolução histórica das condições de trabalho ilustra a busca contínua por equilíbrio entre produtividade e dignidade humana. Desde as análises pioneiras de Ramazzini (2016) até os estudos contemporâneos, a relação entre trabalho e saúde permanece um tema central. Com

base nos desafios atuais, é essencial promover políticas que garantam ambientes laborais mais justos, valorizando não apenas a produtividade, mas também o bem-estar físico e psicológico dos trabalhadores.

6.1.3 Impacto da Síndrome de *Burnout* nas Relações de Trabalho

A incorporação de tecnologias no ambiente laboral, em vez de aliviar o ritmo de trabalho, tem intensificado as demandas profissionais. Essa dinâmica está diretamente relacionada ao aumento de Lesões por Esforço Repetitivo (LER), uma das principais doenças ocupacionais da atualidade. O uso repetitivo de equipamentos e a execução de tarefas em alta velocidade geram sobrecarga muscular e desgaste físico, muitas vezes ignorados em ambientes focados apenas na eficiência (Minayo-Gomez; Costa, 1997). Como consequência, o *Burnout* diminui a qualidade do trabalho, resultando em mau atendimento, procedimentos equivocados e negligência (Dejours, 1992; Gil-Monte, 1997).

Além das consequências físicas, a intensificação do trabalho exerce um impacto profundo na saúde mental, contribuindo para o aumento dos casos de síndrome de *Burnout*. Segundo Dejours (1992), ambientes de trabalho que desconsideram o equilíbrio entre demandas e recursos disponíveis promovem sofrimento psíquico. Isso leva a sintomas clássicos do *Burnout*, como esgotamento emocional, despersonalização e baixa realização pessoal. Estudos recentes corroboram essa visão, destacando que contextos de alta pressão e recursos limitados são propícios ao desenvolvimento de transtornos relacionados ao estresse ocupacional.

A Enfermagem é especialmente vulnerável a essas dinâmicas. A precarização das condições de trabalho, a sobrecarga de pacientes e a insuficiência de pessoal expõem os profissionais a elevados níveis de estresse e aumentam o risco de *Burnout*. Pesquisas mostram que uma gestão que oferece suporte e um ambiente de trabalho mais saudável pode mitigar esse esgotamento. Essa abordagem destaca a importância de políticas organizacionais que valorizem o bem-estar dos profissionais.

As consequências do *Burnout* vão além da saúde individual, afetando diretamente a qualidade do cuidado prestado. A perda de profissionais experientes é uma das repercussões mais graves para o setor de saúde, evidenciando a insatisfação com as condições de trabalho. O êxodo de profissionais qualificados compromete a continuidade e a eficácia da assistência. A desumanização, característica central da síndrome, mina a relação terapêutica e resulta em profissionais desmotivados, prejudicando tanto os pacientes quanto a instituição.

Diante desse cenário, é fundamental investir em condições dignas de trabalho, remuneração adequada e valorização social dos profissionais da Enfermagem. Movimentos sociais e iniciativas internacionais voltadas para a humanização das relações laborais podem servir de inspiração, e o Código de Ética e Deontologia da Enfermagem (2017) emerge como um pilar para a excelência da assistência. No entanto, como alerta Benevides-Pereira (2012), sem mudanças estruturais significativas, os números apresentados pelos estudos podem ser apenas a ponta do *iceberg*, subestimando a verdadeira dimensão do problema.

PARTE II

7 A METODOLOGIA INVESTIGATIVA: DA CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL ÀS QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO

Este estudo utilizou uma abordagem metodológica mista para explorar a relação entre Coping Espiritual, Síndrome de *Burnout* e qualidade de vida entre docentes de enfermagem. A metodologia combinou análises quantitativas e qualitativas, oferecendo uma avaliação abrangente das dinâmicas em questão.

7.1 MATERIAIS E MÉTODOS

O componente quantitativo concentrou-se na análise estatística de dados, com o objetivo de identificar padrões, correlações e diferenças significativas entre as variáveis estudadas. Esse enfoque buscou mensurar o impacto do coping espiritual sobre a Síndrome de Burnout e a qualidade de vida, levando em conta fatores demográficos e ocupacionais.

Complementarmente, o componente qualitativo baseou-se na análise das respostas abertas dos questionários. Essa abordagem permitiu a extração de insights detalhados sobre as experiências individuais dos docentes, enriquecendo a interpretação dos resultados quantitativos. Dessa forma, foi possível contextualizar os achados de maneira mais profunda, oferecendo uma visão holística sobre o fenômeno estudado.

7.2 VARIÁVEIS EM ESTUDO

Este estudo investigou a relação entre *coping* Espiritual, Síndrome de *Burnout* e qualidade de vida em docentes de enfermagem, utilizando um conjunto diversificado de variáveis quantitativas e qualitativas. As variáveis foram selecionadas com base em sua

relevância teórica e prática, buscando capturar os múltiplos aspectos que influenciam os fenômenos estudados.

Entre as variáveis quantitativas, o *coping* espiritual foi avaliado por meio de instrumentos específicos que mensuram o uso de práticas e crenças espirituais como mecanismos de enfrentamento. A Síndrome de *Burnout* foi medida com base no *Copenhagen Burnout Inventory* (CBI), abrangendo as dimensões de exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal. A qualidade de vida foi analisada por meio do *WHOQOL-BREF*, considerando os domínios físico, psicológico, social e ambiental. Além disso, fatores demográficos e ocupacionais, como idade, gênero, tempo de experiência profissional, carga horária semanal e área de atuação, foram incluídos como variáveis moderadoras.

As variáveis qualitativas englobaram relatos individuais sobre desafios profissionais, incluindo conflitos interpessoais, sobrecarga e dificuldades de acesso a recursos. Foram analisadas, ainda, percepções subjetivas de bem-estar e saúde mental, considerando os impactos emocionais e psicológicos do ambiente de trabalho. Além disso, foram exploradas reflexões sobre o papel da espiritualidade como apoio emocional e sua influência no enfrentamento de adversidades.

As variáveis foram exploradas de forma integrada, considerando as possíveis correlações e influências entre os domínios quantitativos e qualitativos. A análise buscou compreender como o *coping* espiritual pode atuar como moderador dos impactos do *burnout* na qualidade de vida, além de identificar padrões específicos entre diferentes grupos demográficos e ocupacionais.

7.3 PARTICIPANTES NO ESTUDO

O estudo contou com a participação de 103 enfermeiros e/ou enfermeiras, docentes do curso de Enfermagem, cuidadosamente selecionados de um universo inicial de 130 professores elegíveis. Essa amostra, que reflete a diversidade do corpo docente da região de Goiânia, foi coletada em dez das maiores instituições de ensino médio e superior localizadas no município de Goiânia e sua área metropolitana. A inclusão de profissionais com diferentes níveis de experiência, áreas de especialização e contextos de atuação contribuiu significativamente para a representatividade da amostra, enriquecendo a amplitude das perspectivas abordadas na pesquisa.

A amostragem foi fundamentada em cálculos de poder estatístico, considerando um nível de significância de 0,05 e um poder de 0,80 para detectar um tamanho de efeito médio,

conforme os parâmetros de *Cohen* (2013). Esses critérios indicaram a necessidade de pelo menos 100 participantes, permitindo análises estatísticas robustas e com alto grau de confiabilidade. Além disso, foi adotada uma margem de segurança para acomodar possíveis desistências ou dados incompletos, assegurando a validade e a consistência das análises.

Os dados coletados possibilitaram uma exploração detalhada das variáveis em estudo, com análises estratificadas por subgrupos que enriqueceram a compreensão das dinâmicas entre *coping* espiritual, Síndrome de *Burnout* e qualidade de vida. Essa abordagem permitiu identificar nuances importantes, destacando padrões e tendências que refletem as especificidades e os desafios enfrentados por esses profissionais no ambiente laboral.

7.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi realizada por meio de um formulário online no *Google Forms*, que incluiu quatro instrumentos específicos. Para facilitar o processo e esclarecer dúvidas, a pesquisadora principal esteve presente nas instituições no dia agendado para a coleta, e a distribuição do formulário ocorreu durante reuniões de professores, sendo acessado pelos docentes por meio de um *QR code* e/ou *link*. Medidas rigorosas foram adotadas para garantir o anonimato, a confidencialidade e a privacidade dos dados, utilizando identificação numérica dos participantes desde o início da coleta até a análise final.

Adotou-se uma abordagem metodológica diversificada para garantir uma compreensão abrangente das dinâmicas entre *coping* espiritual, Síndrome de *Burnout* e qualidade de vida entre docentes de Enfermagem. Foram selecionados quatro instrumentos de coleta de dados, cada um escolhido por sua capacidade de fornecer insights sobre diferentes aspectos dos fenômenos estudados. Essa seleção permitiu uma análise ampla e diversificada, abrangendo desde fatores pessoais e espirituais até aspectos profissionais e ambientais que influenciam o bem-estar dos professores.

A integração desses instrumentos possibilitou a coleta de dados quantitativos e qualitativos robustos, proporcionando uma visão holística das experiências e percepções dos docentes, enquanto abarcava a complexidade de suas realidades cotidianas. Os detalhes dos instrumentos de coleta empregados na pesquisa foram meticulosamente apresentados, destacando suas características, objetivos e a relevância de sua utilização no contexto do estudo. Esta abordagem metodológica criteriosa garantiu a coleta de dados essenciais para uma eficaz exploração das hipóteses de pesquisa e para o alcance dos objetivos propostos.

Entre os instrumentos utilizados, destaca-se o questionário semiestruturado com características sociodemográficas e ocupacionais, elaborado para obter informações detalhadas sobre os professores de enfermagem participantes do estudo. Composto por questões estruturadas, este instrumento foi projetado para capturar uma ampla gama de informações relevantes para a pesquisa, incluindo dados como idade, gênero, estado civil, número de filhos, formação acadêmica, tempo de atuação na área de enfermagem, vínculo empregatício e carga horária de trabalho, entre outros aspectos.

O objetivo principal deste questionário é obter um perfil detalhado dos participantes, permitindo uma análise aprofundada dos resultados ao correlacionar características pessoais e profissionais com os níveis de *coping* religioso/espiritual, Síndrome de *Burnout* e qualidade de vida. As informações coletadas foram essenciais para entender como variáveis sociodemográficas e ocupacionais influenciam as condições de trabalho e bem-estar dos docentes, fornecendo dados fundamentais para as análises estatísticas e interpretações subsequentes do estudo.

Para avaliar o uso de recursos religiosos e espirituais em situações de estresse, foi aplicada a Escala de *Coping* Religioso Espiritual (CRE) como principal ferramenta psicométrica. Esse instrumento é composto por diversos itens onde os participantes avaliam com base em suas experiências pessoais, especialmente em relação à situação de maior estresse vivenciada nos últimos três anos. A escala possibilita a análise do papel da religiosidade e da espiritualidade como estratégias de enfrentamento diante de desafios vivenciados no contexto profissional e pessoal. Os itens incluem práticas e crenças variadas, como orações, busca de conforto e orientação espiritual, e questionamentos sobre a justiça divina. Cada item é medido em uma escala *Likert*, que varia de "nem um pouco" a "muitíssimo", permitindo quantificar a frequência ou intensidade do uso de cada estratégia de *coping* religioso-espiritual.

O principal objetivo da Escala CRE foi identificar e quantificar a utilização da religiosidade e espiritualidade como mecanismos de enfrentamento diante de desafios e adversidades. Distinguindo entre estratégias adaptativas e mal adaptativas, a escala oferece *insights* sobre a complexidade das respostas individuais ao estresse e como essas respostas afetam o bem-estar psicológico e emocional.

A aplicação da Escala CRE em pesquisas contribui significativamente para o entendimento das relações entre espiritualidade, religiosidade e saúde mental, sendo particularmente relevante em contextos clínicos e terapêuticos. Serve também como base

para o desenvolvimento de intervenções psicossociais que integram aspectos religiosos e espirituais no cuidado e suporte aos indivíduos.

A segunda escala a ser utilizada foi a *Copenhagen Síndrome de Burnout Inventory* (CBI) para avaliar o nível de Síndrome de *Burnout* em indivíduos, especialmente em contextos de trabalho e em profissionais da saúde. Este instrumento, traduzido e validado em português por Fontes (2011), compreende três subescalas principais: *Personal Síndrome de Burnout*, que avalia a exaustão física e psicológica percebida pelo indivíduo independentemente do contexto de trabalho; *Work-related Síndrome de Burnout*, focada na exaustão específica em relação ao trabalho; e *Client-related Síndrome de Burnout*, destinada a profissionais que interagem diretamente com clientes, pacientes ou alunos, avaliando a exaustão decorrente dessa interação.

Cada subescala inclui uma série de afirmações às quais os respondentes devem indicar seu grau de concordância ou frequência de experiência, usando uma escala *Likert*. As perguntas exploram sentimentos de exaustão, cansaço e esgotamento físico e emocional, entre outros aspectos relacionados ao Síndrome de *Burnout*.

O principal objetivo do CBI é fornecer uma medida confiável e válida de Síndrome de *Burnout*, facilitando a identificação de áreas específicas de estresse relacionadas ao trabalho e à interação com clientes ou pacientes. No entanto, é importante destacar que o CBI não estabelece um diagnóstico clínico formal de Síndrome de *Burnout*, o qual requer uma avaliação mais aprofundada e multidimensional, geralmente realizada por profissionais de saúde mental.

A utilização do CBI em pesquisas e contextos organizacionais oferece *insights* valiosos sobre os fatores de risco associados ao Síndrome de *Burnout*, contribuindo para a criação de ambientes de trabalho mais saudáveis e para a promoção do bem-estar dos profissionais. Identificando especificamente as dimensões do Síndrome de *Burnout* relacionadas ao trabalho e à interação com clientes ou pacientes, o CBI possibilita uma abordagem mais direcionada nas intervenções, visando reduzir a exaustão profissional e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores.

Como terceiro instrumento, empregou-se o *WHOQOL-BREF*, um questionário desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) destinado à avaliação da qualidade de vida em variados contextos culturais e demográficos. Consiste em uma versão abreviada do *WHOQOL-100*, contendo 26 itens distribuídos em quatro domínios principais: físico, psicológico, relações sociais e ambiente. Cada item é respondido em uma escala tipo *Likert*, variando em intensidade ou frequência, conforme a natureza da pergunta.

Este instrumento é derivado do *WHOQOL-100*. O questionário *WHOQOL-BREF* contém dois itens da QV geral e saúde geral e 24 itens de satisfação que são divididos em quatro domínios: saúde física com 7 itens (DOM1), saúde psicológica com 6 itens (DOM2), relações sociais com 3 itens (DOM3) e saúde ambiental com 8 itens (DOM4) (Fleck, *et al.*, 2000; OMS, 1996).

Cada item individual do *WHOQOL-BREF* é pontuado de 1 a 5 em uma escala de resposta, que é estipulada como uma escala ordinal de cinco pontos. As pontuações são então transformadas linearmente para uma escala de 0 a 100 (Lemieux, *et al.*, 2011).

O domínio de saúde física inclui itens sobre mobilidade, atividades diárias, capacidade funcional, energia, dor e sono. As medidas do domínio psicológico incluem autoimagem, pensamentos negativos, atitudes positivas, autoestima, mentalidade, capacidade de aprendizagem, concentração de memória, religião e estado mental. O domínio de relações sociais contém perguntas sobre relacionamentos pessoais, apoio social e vida sexual. O domínio da saúde ambiental abrange questões relacionadas com recursos financeiros, segurança, saúde e serviços sociais, ambiente físico de vida, oportunidades de aquisição de novas competências e conhecimentos, recreação, ambiente geral (ruído, poluição atmosférica etc.) e transporte (Nedjat, *et al.*, 2006).

O principal objetivo do *WHOQOL-BREF* é fornecer uma medida rápida e eficaz da qualidade de vida percebida pelos indivíduos, abrangendo aspectos físicos, mentais, sociais e ambientais de seu bem-estar. Ele permite aos pesquisadores e profissionais da saúde avaliar e comparar a qualidade de vida entre diferentes populações, bem como monitorar mudanças ao longo do tempo, seja em resposta a intervenções clínicas, mudanças no estilo de vida ou transições importantes na vida dos indivíduos.

7.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS

Os dados coletados neste estudo foram organizados e analisados seguindo um processo estruturado para garantir a precisão e a integridade na interpretação dos resultados. Inicialmente, após a coleta dos dados via *Google Forms*, as respostas foram automaticamente compiladas em uma planilha digital. Realizou-se uma revisão inicial para identificar e corrigir possíveis inconsistências ou entradas incompletas, assegurando a qualidade dos dados antes da análise subsequente. Em seguida, procedeu-se à codificação das respostas abertas, especialmente aquelas do questionário com características

sociodemográficas e dados ocupacionais. Esta etapa envolveu atribuir códigos numéricos a respostas categóricas para facilitar a análise estatística, permitindo uma avaliação quantitativa eficaz dos dados coletados.

A realização deste trabalho enfrentou múltiplos desafios, pois não exigiram apenas conhecimento técnico e científico, mas também habilidades de gestão, comunicação e negociação. Desde a concepção até a implementação e disseminação dos resultados, diversas barreiras significativas foram encontradas.

Outra dificuldade encontrada, posteriormente, foi na coleta de dados. A promoção de uma cultura de pesquisa, aliada a políticas de incentivo e suporte, são aspectos determinantes para o sucesso das pesquisas. Muitas vezes, os enfermeiros e as enfermeiras estavam sobrecarregados com suas responsabilidades diárias, encontrando dificuldades para se envolverem nas atividades de pesquisa. Foram necessários contatar pessoalmente grande parte dos profissionais, agendando datas e horários para a realização da coleta de dados. Sendo realizado nas dependências da instituição durante reuniões mensais, ou em horários pré-estabelecidos, com duração aproximada de 15 a 30 minutos.

7.6 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

Neste estudo, os dados coletados foram tabulados e tratados utilizando-se o *software Microsoft Excel*, processo que envolveu a organização das informações para garantir precisão e consistência. Verificaram-se inconsistências e corrigiram-se possíveis erros para preparar os dados para análises estatísticas, assegurando a integridade e qualidade das informações. Realizou-se uma análise descritiva e caracterização da amostra por meio da distribuição de frequência, cálculo de médias e desvios padrão.

Testes estatísticos apropriados, como t-testes, ANOVAs, correlações e regressões, foram empregados para explorar as relações entre *coping* religioso/espiritual, Síndrome de *Burnout*, qualidade de vida e variáveis sociodemográficas e ocupacionais. Para o componente qualitativo, conduziu-se uma análise de conteúdo para identificar temas e padrões recorrentes, envolvendo a leitura minuciosa das respostas e a categorização das informações.

8 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, foram exigidos rigorosos protocolos éticos para proteger os participantes. Isso incluiu a obtenção de aprovações de comitês de ética, tornando o processo moroso e exigente. A primeira dificuldade encontrada foi a obtenção de anuência por parte das instituições educacionais. Este processo demandou um tempo considerável, envolvendo diversas reuniões e apresentações de propostas detalhadas para garantir transparência e alinhar os objetivos do estudo com as políticas das instituições. As instituições de ensino consentiram e autorizaram a realização do projeto, sem oferecer riscos físicos ou benefícios diretos aos participantes, além de não haver compensação financeira.

O tempo dispendido nessa fase foi significativo, prolongando-se por vários meses antes que todas as aprovações necessárias fossem obtidas e o estudo pudesse ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Após sua aprovação, todas as etapas foram executadas com o consentimento dos participantes, garantindo anonimato, sigilo, confidencialidade e privacidade.

Ao final todos os materiais produzidos foram armazenados sob responsabilidade do pesquisador, por um período de cinco anos, sendo usados exclusivamente para esta pesquisa e posteriormente deletados.

PARTE III

9 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Esta pesquisa se insere em um contexto de crescente preocupação com a saúde mental e o bem-estar de profissionais de Enfermagem, uma classe laboral especialmente suscetível ao esgotamento físico e emocional decorrente das intensas demandas ocupacionais. Ao investigar como as estratégias de *coping* baseadas na espiritualidade podem mediar ou mitigar os efeitos do *Burnout*, este estudo busca oferecer uma compreensão mais aprofundada sobre os fatores que influenciam a qualidade de vida desses docentes.

No primeiro momento, são apresentadas as variáveis demográficas e ocupacionais, reconhecendo a diversidade de experiências e a influência de características individuais na manifestação e enfrentamento do *Burnout*.

9.1 RESULTADOS QUANTITATIVOS

Foram apresentados os dados descritivos e os resultados dos testes de hipóteses na Tabela 1, comparando a população de estudo segundo o nível de formação acadêmica. Observou-se que a distribuição por faixa etária revela uma predominância de professores mais jovens, com 54,5% dos docentes na faixa de 20-30 anos possuindo especialização e 27,3% mestrado.

Já na faixa etária mais avançada, de 61-70 anos, 77,8% dos docentes possuem doutorado, indicando uma progressão na formação acadêmica associada ao avanço etário. Essa diferença foi estatisticamente significativa, com um p-valor de 0,01, sugerindo que a formação acadêmica está intimamente ligada à idade, com níveis mais elevados de formação concentrados em docentes mais velhos.

Em relação ao gênero, embora não tenha sido observada uma diferença estatisticamente significativa ($p=0,08$), os dados indicam que a maioria das mulheres possui mestrado (37,2%) ou especialização (30,8%), enquanto (28,2%) alcançaram o doutorado. Por outro lado, entre os homens, a distribuição foi menos equilibrada, com (45,8%) possuindo especialização, (33,3%) mestrado, e uma menor proporção (8,3%) com doutorado. Esse achado sugere uma concentração equilibrada de mulheres nos níveis de especialização, mestrado e doutorado, enquanto a proporção de homens é maior na especialização.

Esses achados, mesmo sem significância estatística, refletem um aspecto importante da carreira acadêmica na Enfermagem, onde a presença feminina é predominante e sua ascensão a níveis mais altos de qualificação é notável. É por isso que, mesmo sem ter sido o foco central do questionário, um capítulo à parte foi elaborado para aprofundar a discussão sobre as questões de gênero na Enfermagem.

Nele, buscamos desvendar o conceito de gênero e transgênero, abordando seus impactos nas relações de poder. A análise de gênero também se mostra relevante para compreender as vulnerabilidades e a necessidade de promover a equidade na profissão. Além disso, o capítulo explorou a relação entre gênero e *Burnout*, examinando as dimensões de gênero no desgaste profissional da Enfermagem.

O estado civil dos docentes também foi analisado em relação ao nível de formação acadêmica. Embora o p-valor de 0,13 não indique significância estatística, os dados sugerem que (33,3%) dos docentes casados possuem doutorado, enquanto (39,1%) dos divorciados têm mestrado, e (48,5%) dos solteiros possuem mestrado, indicando que docentes casados ou divorciados tendem a ter maior formação em comparação aos solteiros. Este padrão pode estar relacionado a fatores de estabilidade pessoal e profissional, que influenciam na continuidade e no avanço da formação acadêmica.

Por fim, ao analisar o número de filhos, foi observado que a maioria dos docentes com um ou dois filhos possui mestrado ou doutorado. Especificamente, 34,8% dos docentes com um filho têm doutorado, e 38,7% dos que têm dois filhos possuem mestrado. A ausência de significância estatística ($p=0,23$) neste caso indica que, apesar de uma possível associação entre maior número de filhos e níveis mais elevados de formação, essa relação não é robusta no contexto da amostra estudada. Contudo, os dados sugerem que os docentes com filhos, particularmente aqueles com um ou dois filhos, conseguem equilibrar responsabilidades familiares com a continuidade na formação acadêmica.

Esses resultados fornecem uma visão inicial sobre a composição sociodemográfica dos docentes de Enfermagem na região de Goiânia e sua relação com o nível de formação acadêmica, aspectos que serão fundamentais para uma análise mais aprofundada sobre como essas variáveis interagem com o *coping* espiritual e a Síndrome de *Burnout* no contexto educacional.

Tabela 1 – Frequência e comparação da população de estudo, segundo nível de formação acadêmica. Goiás 2024. Grande Goiânia -GO (2024).

Variável	Nível de formação										p-valor*
	Bacharelado		Especialização		Mestrado		Doutorado		Total		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
Faixa etária											
20 – 30 anos	2	6,1	18	54,5	9	27,3	4	12,1	33	100	0,01
31– 40 anos	2	9,1	9	40,9	7	31,8	4	18,2	22	100	
41 – 50 anos	1	4,0	5	20	14	56,0	5	20,0	25	100	
51 – 60 anos	1	8,3	2	16,7	5	41,7	4	33,3	12	100	
61 – 70 anos	0	0,0	1	11,1	1	11,1	7	77,8	9	100	
71 anos ou mais	0	0,0	0	0	1	100	0,0	0,0	1	100	
Total	6	5,9	35	34,3	37	36,3	24	23,5	102	100	
Qual o seu gênero											
Masculino	3	12,5	11	45,8	8	33,3	2	8,3	24	100	0,08
Feminino	3	3,8	24	30,8	29	37,2	22	28,2	78	100	
Total	6	5,9	35	34,3	37	36,3	24	23,5	102	100	
Estado civil											
Casado (a)	1	2,2	18	40	11	24,4	15	33,3	45	100	0,13
Divorciado (a)	1	4,3	7	30,4	9	39,1	6	26,1	23	100	
Solteiro (a)	4	12,1	10	30,3	16	48,5	3	9,1	33	100	
Viúvo (a)	0	0	0	0	1	100	0	0	1	100	
Total	6	5,9	35	34,3	37	36,3	24	23,5	102	100	
Nº de filhos											
1	3	13	5	21,7	7	30,4	8	34,8	23	100	0,23
2	0	0	9	29	12	38,7	10	32,3	31	100	
3 ou mais	1	8,3	5	41,7	4	33,3	2	16,7	12	100	
nenhum	2	5,6	16	44,4	14	38,9	4	11,1	36	100	
Total	6	5,9	35	34,3	37	36,3	24	23,5	102	100	

* Teste exato de Fisher

Os resultados apresentados na Tabela 2, abaixo, fornecem uma análise detalhada sobre o diagnóstico médico de condições relacionadas ao estresse entre os docentes de enfermagem, considerando diversas variáveis ocupacionais e demográficas. Ao avaliar o tempo de trabalho na Enfermagem, observou-se que 60% dos profissionais com 21 anos ou mais na profissão não possuem diagnóstico de estresse, enquanto aqueles com menos de 10 anos de experiência apresentaram maior incidência de ansiedade (43,2%). O diagnóstico de *Burnout* foi mais

frequente entre docentes com menos de 10 anos de experiência (13,5%), sugerindo que o tempo prolongado na carreira pode contribuir para o desenvolvimento de mecanismos de enfrentamento mais eficazes ou a adaptação ao ambiente de trabalho, embora essa relação exija uma investigação mais aprofundada.

Em relação ao tempo de trabalho no emprego atual, os resultados indicam que a maioria dos docentes com menos de 10 anos na instituição não foi diagnosticada com condições relacionadas ao estresse (39,5%), enquanto a ansiedade foi mais prevalente (34,2%) nesse grupo. O diagnóstico de *Burnout* foi também mais comum entre aqueles com menos de 10 anos de vínculo empregatício (11,8%). Esses dados sugerem que o início de um novo emprego pode ser um período de maior vulnerabilidade ao estresse, possivelmente devido à adaptação às novas demandas e ambientes. O p-valor de 0,05 sugere uma tendência à significância, o que pode indicar que há uma possível relação entre o tempo de emprego e a prevalência de condições de estresse, necessitando de uma análise mais profunda para confirmação.

A análise do horário de trabalho revelou que os docentes que trabalham no período noturno apresentam maiores índices de ansiedade (38,2%) e *Burnout* (11,8%) em comparação aos que trabalham durante o dia. Este dado, acompanhado de um p-valor de 0,04, indica uma associação estatisticamente significativa, sugerindo que o trabalho noturno pode, de fato, estar relacionado a um aumento nos diagnósticos de condições de estresse, possivelmente devido aos impactos negativos que esse horário pode ter sobre o bem-estar geral dos docentes.

Quanto ao vínculo empregatício, docentes contratados em regime CLT (carteira assinada) e aqueles com contratos seletivos apresentaram uma distribuição relativamente equilibrada de diagnósticos de *Burnout* e ansiedade. Notou-se que a ansiedade foi particularmente alta entre docentes com vínculos CLT (30,5%) e entre aqueles classificados na categoria "outro" (27,3%). Além disso, o diagnóstico de *Burnout* foi mais frequente entre aqueles com contratos não permanentes, sugerindo que a precariedade do emprego pode estar associada a níveis mais elevados de estresse.

A presença de outro vínculo empregatício também se mostrou relevante, com docentes que possuem outro emprego apresentando maior incidência de *Burnout* (15,2%) em comparação aos que possuem apenas um emprego (7,1%). Este achado destaca a potencial sobrecarga causada por múltiplos vínculos de trabalho, aumentando a suscetibilidade ao esgotamento profissional.

Por fim, ao considerar o tempo de formação, verificou-se que docentes formados há menos de 10 anos apresentam maior prevalência de ansiedade (40,8%) e *Burnout* (12,2%). Isso pode refletir o impacto do estágio inicial da carreira, onde as demandas profissionais podem

superar as estratégias de enfrentamento já desenvolvidas, resultando em maior vulnerabilidade ao estresse.

Estes resultados destacam a importância de intervenções direcionadas, que considerem as variáveis ocupacionais e demográficas ao abordar o *Burnout* e outras condições relacionadas ao estresse entre docentes de Enfermagem. A compreensão dessas associações é crucial para o desenvolvimento de políticas institucionais que promovam o bem-estar no ambiente de trabalho, especialmente em um contexto de ensino superior onde as exigências são intensas e variadas.

Tabela 2 - Diagnóstico médico de condições relacionadas ao estresse segundo variáveis ocupacionais e demográficas entre docentes de enfermagem. Grande Goiânia - GO (2024).

Diagnóstico médico de condições relacionadas ao estresse													
Variável	Não		Burnout		Ansiedade		Depressão		Outra condição		Total		p-valor*
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
Tempo de trabalho na enfermagem													
menos de 10 anos	12	32,4	5	13,5	16	43,2	2	5,4	2	5,4	37	100	0,07
de 11 a 20 anos	18	51,4	5	14,3	9	25,7	1	2,9	2	5,7	35	100	
21 anos ou mais	18	60	1	3,3	6	20	5	16,7	0	0	30	100	
Total	48	47,1	11	10,8	31	30,4	8	7,8	4	3,9	102	100	
Tempo de trabalho no emprego atual													
menos de 10 anos	30	39,5	9	11,8	26	34,2	7	9,2	4	5,3	76	100	0,40
de 11 a 20 anos	11	73,3	1	6,7	2	13,3	1	6,7	0	0	15	100	
21 anos ou mais	7	63,6	1	9,1	3	27,3	0	0	0	0	11	100	
Total	48	47,1	11	10,8	31	30,4	8	7,8	4	3,9	102	100	
Horário de trabalho													
Diurno	34	52,3	7	10,8	17	26,2	4	6,2	3	4,6	65	100	<0,001
Noturno	12	35,3	4	11,8	13	38,2	4	11,8	1	2,9	34	100	
Plantão	2	66,7	0	0	1	33,3	0	0	0	0	3	100	
Total	48	47,1	11	10,8	31	30,4	8	7,8	4	3,9	102	100	
Vínculo empregatício													
CLT	37	45,1	8	9,8	25	30,5	8	9,8	4	4,9	82	100	0,080
Concursado	3	50	0	0	3	50	0	0	0	0	6	100	
Contrato	2	66,7	1	33,3	0	0	0	0	0	0	3	100	
Outro	6	54,5	2	18,2	3	27,3	0	0	0	0	11	100	
Total	48	47,1	11	10,8	31	30,4	8	7,8	4	3,9	102	100	
Possui outro vínculo empregatício													
Não	28	50	4	7,1	17	30,4	5	8,9	2	3,6	56	100	0,74

Sim	20	43,5	7	15,2	14	30,4	3	6,5	2	4,3	46	100	
Total	48	47,1	11	10,8	31	30,4	8	7,8	4	3,9	102	100	
Tempo de trabalho no emprego atual													
menos de 10 anos	18	36,7	6	12,2	20	40,8	2	4,1	3	6,1	49	100	
de 10 a 20 anos	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100	0,20
21 anos ou mais	27	54	5	10	11	22	6	12	1	2	50	100	
Total	48	47,1	11	10,8	31	30,4	8	7,8	4	3,9	102	100	
Nº de alunos por sala													
até 20 alunos	15	53,6	3	10,7	7	25	1	3,6	2	7,1	28	100	
21 a 40 alunos	25	42,4	7	11,9	19	32,2	6	10,2	2	3,4	59	100	0,88
acima de 40 alunos	8	53,3	1	6,7	5	33,3	1	6,7	0	0	15	100	
Total	48	47,1	11	10,8	31	30,4	8	7,8	4	3,9	102	100	
Nº de disciplinas que ministra													
1	11	47,8	2	8,7	6	26,1	3	13	1	4,3	23	100	
2	15	50	4	13,3	9	30	1	3,3	1	3,3	30	100	
3	5	47,7	0	0	5	41,7	2	16,7	0	0	12	100	0,90
acima de 3	17	45,9	5	13,5	11	29,7	2	5,4	2	5,4	37	100	
Total	48	47,1	11	10,8	31	30,4	8	7,8	4	3,9	102	100	

* Teste exato de Fisher

A Tabela 3 apresenta, abaixo, uma análise dos diagnósticos médicos de condições relacionadas a ansiedade, depressão e Síndrome de *Burnout*, entre docentes de enfermagem, considerando variáveis como número de afastamentos no último ano, duração do afastamento, causas do afastamento, carga horária de trabalho semanal e nível de satisfação com o ambiente de trabalho.

Em relação ao número de afastamentos no último ano, observa-se que os docentes que não precisaram se afastar do trabalho apresentaram menores índices de condições relacionadas ao estresse. Entre aqueles que se afastaram uma vez, (33,3%) foram diagnosticados com ansiedade, enquanto (8,3%) apresentaram diagnóstico de depressão. O diagnóstico de *Burnout* foi mais comum entre os docentes que se afastaram três ou mais vezes (25%), embora esse grupo seja pequeno em número. A categoria de "não se aplica" também registrou incidências de ansiedade (35,8%) e *Burnout* (11,3%).

Ao avaliar a duração dos afastamentos, os dados indicam que docentes que precisaram de afastamentos mais longos, acima de 15 dias, mostraram maior prevalência de depressão (14,3%) e ansiedade (21,4%), enquanto aqueles que se afastaram por até 5 dias tiveram menos diagnósticos de estresse. O grupo com afastamentos entre 6 e 15 dias também apresentou

diagnósticos significativos de ansiedade (27,3%) e outra condição relacionada ao estresse (18,2%).

Quanto às causas do afastamento, docentes afastados por motivos psicológicos tiveram a maior incidência de *Burnout* (26,7%), ansiedade (20%) e outras condições relacionadas ao estresse (13,3%). Em contrapartida, os afastamentos devido a cirurgias, traumas ou maternidade apresentaram uma prevalência menor de *Burnout* (2,9%) e ansiedade (25,7%).

A análise da carga horária de trabalho semanal revelou que docentes que trabalham acima de 40 horas semanais apresentaram uma maior prevalência de *Burnout* (18,2%) e depressão (9,1%), embora a maioria dos diagnósticos de ansiedade tenha sido registrada entre aqueles que trabalham até 30 horas por semana (31,6%).

Finalmente, ao considerar o nível de satisfação com o ambiente de trabalho atual, notou-se que docentes muito insatisfeitos apresentaram alta prevalência de *Burnout* (50%) e ansiedade (50%). Aqueles que se declararam insatisfeitos também mostraram alta incidência de ansiedade (33,3%). Por outro lado, docentes que se consideram satisfeitos ou muito satisfeitos registraram menores taxas de *Burnout* e ansiedade, com os mais satisfeitos apresentando os índices mais baixos de todas as condições de estresse avaliadas.

Embora os resultados apontem tendências importantes em relação às variáveis estudadas, a ausência de significância estatística sugere que as associações observadas devem ser interpretadas com cautela. No entanto, os dados oferecem informações valiosas que podem contribuir para estudos futuros e ações voltadas para o bem-estar dos docentes, principalmente relacionadas ao ambiente de trabalho.

Tabela 3 - Diagnóstico médico de condições relacionadas ao estresse segundo afastamento, carga horária e satisfação com o ambiente de trabalho entre docentes de enfermagem. Grande Goiânia - GO (2024).

Diagnóstico médico de condições relacionadas ao estresse													
Variável	Não		Burnout		Ansiedade		Depressão		Outra condição		Total		p-valor*
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
Quantas vezes afastou no último ano													
1 vez	11	45,8	1	4,2	8	33,3	2	8,3	2	8,3	24	100	0,47
2 vezes	9	56,3	2	12,5	4	25	1	6,3	0	0	16	100	
3 ou mais vezes	6	75	2	25	0	0	0	0	0	0	8	100	
Não se aplica	22	41,5	6	11,3	19	35,8	5	9,4	1	1,9	53	100	
Total	48	47,5	11	10,9	31	30,7	8	7,9	3	3	101	100	
Duração do afastamento													
Até 5 dias	6	60	1	10	3	30	0	0	0	0	10	100	0,38
de 6 a 15 dias	5	45,5	1	9,1	3	27,3	0	0	2	18,2	11	100	

acima de 15 dias	15	53,6	3	10,7	6	21,4	4	14,3	0	0	28	100	
Não se aplica	21	40,4	6	11,5	19	36,5	4	7,7	2	3,8	52	100	
Total	47	46,5	11	10,9	31	30,7	8	7,9	4	4	101	100	
Causas do afastamento													
Cirúrgica/trauma/maternidade	22	62,9	1	2,9	9	25,7	2	5,7	1	2,9	35	100	
Piscológico	5	33,3	4	26,7	3	20	1	6,7	2	13,3	15	100	0,07
Não se aplica	21	40,4	6	11,5	19	36,5	5	9,6	1	1,9	52	100	
Total	48	47,1	11	10,8	31	30,4	8	7,8	4	3,9	102	100	
Carga horaria de trabalho semanal													
Até 30 horas	38	48,1	6	7,6	25	31,6	6	7,6	4	5,1	79	100	
de 31 a 40 horas	3	25	3	25	5	41,7	1	8,3	0	0	12	100	0,36
Acima de 40 horas	7	63,6	2	18,2	1	9,1	1	9,1	0	0	11	100	
Total	48	47,1	11	10,8	31	30,4	8	7,8	4	3,9	102	100	
Nível de satisfação com o ambiente de trabalho													
Muito insatisfeito	0	0	2	50	2	50	0	0	0	0	4	100	
Insatisfeito	4	66,7	0	0	2	33,3	0	0	0	0	6	100	
Neutro	12	38,7	4	12,9	13	41,9	1	3,2	1	3,2	31	100	0,11
Satisfeito	26	54,2	4	8,3	8	16,7	7	14,6	3	6,3	48	100	
Muito satisfeito	6	46,2	1	7,7	6	46,2	0	0	0	0	13	100	
Total	48	47,1	11	10,8	31	30,4	8	7,8	4	3,9	102	100	

* Teste exato de Fisher

A Tabela 4, seguinte, explora as associações entre o diagnóstico médico de condições relacionadas ao estresse e variáveis como a frequência de atividades de recuperação após o trabalho, a percepção da própria saúde física e mental, o grau de envolvimento em práticas espirituais ou religiosas, a percepção da eficácia do *coping* espiritual no manejo do estresse profissional, a frequência de práticas de cuidado pessoal relacionadas à saúde mental, e a satisfação com o suporte emocional disponível no ambiente de trabalho.

Ao analisar a frequência das atividades de recuperação após o trabalho, os resultados indicam que a maioria dos docentes que nunca realiza tais atividades apresentou ausência de diagnósticos médicos de estresse. Aqueles que realizam atividades de recuperação semanalmente - ou várias vezes por semana - mostraram prevalências variadas de ansiedade e depressão, com (50%) de ansiedade para os que realizam essas atividades várias vezes por semana. Apesar das diferenças aparentes, o p-valor de 0,29 sugere que essas associações não são estatisticamente significativas.

Em relação à percepção da própria saúde física e mental, docentes que avaliam sua saúde como ruim apresentaram maiores índices de *Burnout* (13,6%), ansiedade (31,8%), depressão (13,6%) e outras condições relacionadas ao estresse (9,1%). Já aqueles que percebem sua saúde

[illegible]

Total	48	47,1	11	10,8	31	30,4	8	7,8	4	3,9	102	100
-------	----	------	----	------	----	------	---	-----	---	-----	-----	-----

* Teste exato de Fisher

A análise de confiabilidade das escalas utilizadas no estudo foi avaliada por meio dos coeficientes *Cronbach's α* e *McDonald's ω* . Esses coeficientes fornecem uma medida da consistência interna dos itens que compõem as escalas, indicando o quanto os itens de cada escala avaliam de forma consistente o mesmo constructo.

A escala *WHOQOL-BREF*, utilizada para medir a qualidade de vida dos docentes, apresentou um coeficiente de *Cronbach's α* de 0,71 e um coeficiente de *McDonald's ω* de 0,73, indicando uma confiabilidade aceitável, com consistência interna moderada dos itens.

Para a escala *Copenhagen Burnout Inventory* (CBI), que avalia o nível de *Burnout*, os coeficientes foram mais elevados, com um *Cronbach's α* de 0,81 e um *McDonald's ω* de 0,84, sugerindo uma boa consistência interna dos itens que compõem esta escala.

A escala *Coping Religioso-Espiritual* (CRE) apresentou os maiores coeficientes de confiabilidade, com *Cronbach's α* e *McDonald's ω* de 0,87, indicando uma consistência interna excelente, o que reforça a robustez dos itens em avaliar de forma consistente o *coping* espiritual dos docentes.

Esses resultados demonstram que todas as escalas apresentam níveis de confiabilidade adequados, observados por sua alta consistência interna.

Tabela 5 - Confiabilidade dos Itens avaliados nas escalas utilizadas no estudo.

	<i>Cronbach's α</i>	<i>McDonald's ω</i>
<i>WHOQOL-BREF</i>	0,71	0,73
<i>Copenhagen Burnout</i>	0,81	0,84
<i>Coping Religioso-Espiritual</i>	0,87	0,87

Os resultados das análises das correlações são apresentados nas figuras de mapa de calor, onde as correlações positivas são representadas pela cor laranja e as correlações negativas representadas pela cor azul. A correlação entre as dimensões do *Burnout* e os aspectos da qualidade de vida dos docentes de Enfermagem, ilustrada na Figura 1-A, revelou várias associações negativas estatisticamente significativas, evidenciando o impacto do *Burnout* na saúde e no bem-estar desses profissionais.

A "frequência de cansaço" apresentou uma correlação negativa significativa com "sentimentos negativos" ($r = -0.38$; $p < 0.001$), sugerindo que quanto mais frequente o cansaço

relatado pelos docentes, maior a presença de sentimentos negativos, o que pode afetar sua saúde mental e emocional. Além disso, essa variável mostrou uma correlação negativa com "tratamento médico necessário" ($r = -0.18$; $p = 0.07$), indicando uma tendência em que o cansaço frequente está associado à percepção de necessidade de cuidados médicos, embora essa relação não tenha atingido significância estatística estrita.

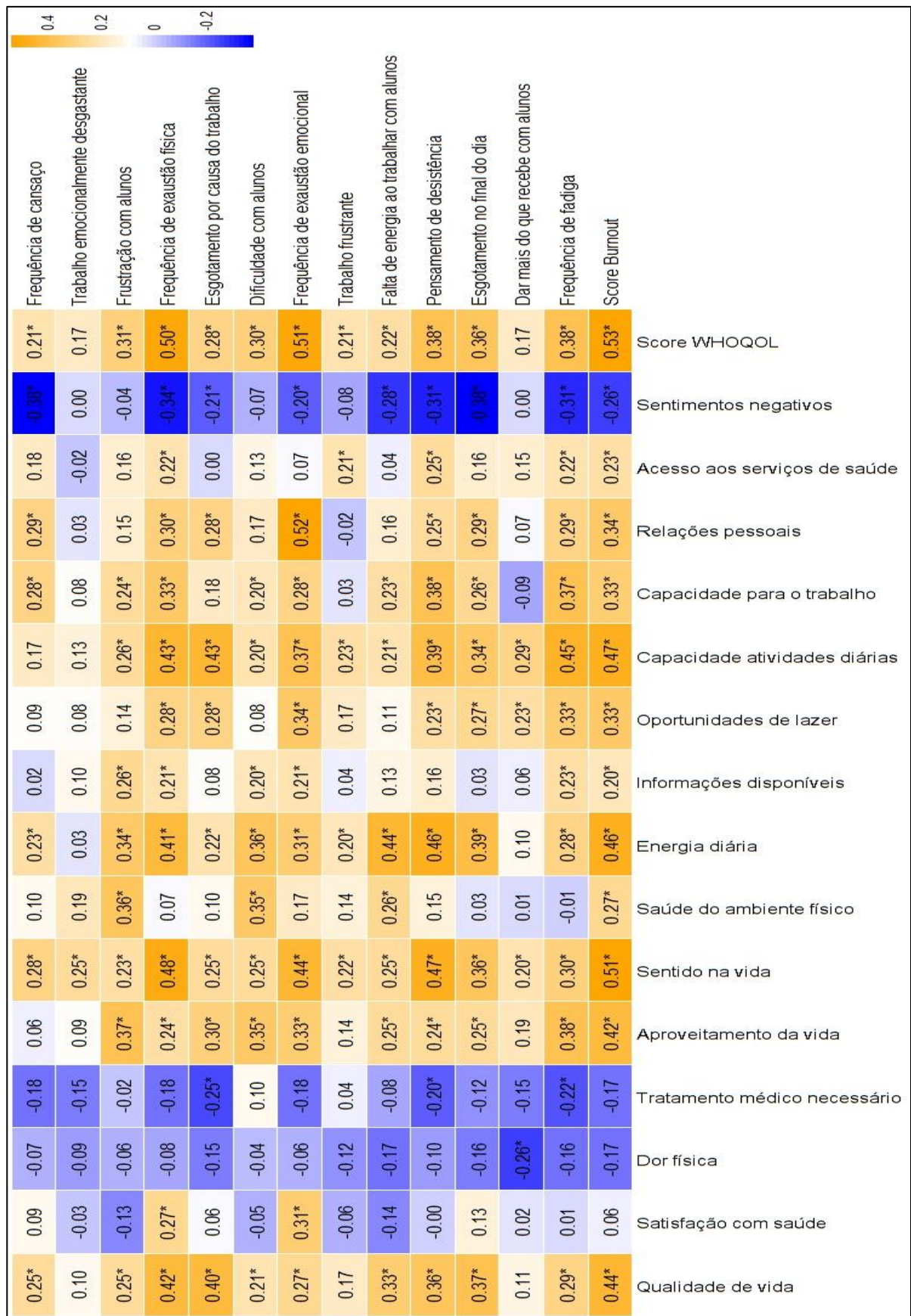
A "frequência de exaustão emocional" também apresentou correlações negativas relevantes. Ela se correlacionou negativamente com "dor física" ($r = -0.06$; $p > 0.05$) e "tratamento médico necessário" ($r = -0.18$; $p = 0.07$). Esses resultados sugerem que docentes com alta exaustão emocional pode apresentar uma percepção elevada de dor física e uma maior demanda por cuidados médicos, ainda que esses resultados não sejam totalmente significativos do ponto de vista estatístico, indicando uma possível tendência que merece atenção em estudos futuros.

Além disso, o "esgotamento por causa do trabalho" mostrou uma correlação negativa com "tratamento médico necessário" ($r = -0.25$; $p < 0.05$), reforçando que o esgotamento relacionado ao trabalho pode aumentar a percepção da necessidade de cuidados médicos. Esse achado é crucial, pois indica que o esgotamento laboral pode ter efeitos negativos diretos na saúde física e na busca por tratamentos.

Por fim, o "*score de Burnout*" apresentou uma forte correlação negativa com "sentimentos negativos" ($r = -0.26$; $p < 0.01$), confirmando que níveis elevados de *Burnout* estão associados a uma maior presença de emoções negativas, comprometendo significativamente a qualidade de vida dos docentes. Além disso, o "*score de Burnout*" teve uma correlação negativa com "dor física" ($r = -0.17$; $p > 0.05$), indicando que o *Burnout* pode estar ligado a um aumento na percepção da dor física, mesmo que essa relação não tenha atingido significância estatística.

Esses achados sugerem que o *Burnout* está associado negativamente a vários aspectos da qualidade de vida, incluindo saúde física, a necessidade percebida de tratamento médico, e o bem-estar emocional. Isso demonstra a importância de intervenções direcionadas para o manejo do *Burnout*, visando a melhoria da saúde física e mental dos docentes, além de prevenir consequências graves, como pensamentos suicidas e outros efeitos adversos do *Burnout*, promovendo assim um ambiente de trabalho mais saudável.

Figura 1-A – Correlações entre Dimensões do *Burnout* e Qualidade de Vida (WHOQOL-BREF) entre Docentes de Enfermagem.



	Frequência de cansaço	Trabalho emocionalmente desgastante	Frustração com alunos	Frequência de exaustão física	Esgotamento por causa do trabalho	Dificuldade com alunos	Frequência de exaustão emocional	Trabalho frustrante	Falta de energia ao trabalhar com alunos	Pensamento de desistência	Esgotamento no final do dia	Dar mais do que recebe com alunos	Frequência de fadiga	Score Burnout	
0.25*	0.21*	0.17	0.31*	0.50*	0.28*	0.30*	0.51*	0.21*	0.22*	0.38*	0.36*	0.17	0.38*	0.53*	Score WHOQOL
0.10	-0.38*	0.00	-0.04	-0.34*	-0.21*	-0.07	-0.20*	-0.08	-0.28*	-0.31*	0.38*	0.00	-0.31*	-0.26*	Sentimentos negativos
0.25*	0.18	-0.02	0.16	0.22*	0.00	0.13	0.07	0.21*	0.04	0.25*	0.16	0.15	0.22*	0.23*	Acesso aos serviços de saúde
0.42*	0.29*	0.03	0.15	0.30*	0.28*	0.17	0.52*	-0.02	0.16	0.25*	0.29*	0.07	0.29*	0.34*	Relações pessoais
0.40*	0.28*	0.08	0.24*	0.33*	0.18	0.20*	0.28*	0.03	0.23*	0.38*	0.26*	-0.09	0.37*	0.33*	Capacidade para o trabalho
0.21*	0.17	0.13	0.26*	0.43*	0.43*	0.20*	0.37*	0.23*	0.21*	0.39*	0.34*	0.29*	0.45*	0.47*	Capacidade atividades diárias
0.27*	0.09	0.08	0.14	0.28*	0.28*	0.08	0.34*	0.17	0.11	0.23*	0.27*	0.23*	0.33*	0.33*	Oportunidades de lazer
0.17	0.02	0.10	0.28*	0.21*	0.08	0.20*	0.21*	0.04	0.13	0.16	0.03	0.06	0.23*	0.20*	Informações disponíveis
0.33*	0.23*	0.03	0.34*	0.41*	0.22*	0.36*	0.31*	0.20*	0.44*	0.46*	0.39*	0.10	0.28*	0.46*	Energia diária
0.36*	0.10	0.19	0.36*	0.07	0.10	0.35*	0.17	0.14	0.26*	0.15	0.03	0.01	-0.01	0.27*	Saúde do ambiente físico
0.37*	0.28*	0.25*	0.23*	0.48*	0.25*	0.25*	0.44*	0.22*	0.25*	0.47*	0.36*	0.20*	0.30*	0.51*	Sentido na vida
0.11	0.06	0.09	0.37*	0.24*	0.30*	0.35*	0.33*	0.14	0.25*	0.24*	0.25*	0.19	0.38*	0.42*	Aproveitamento da vida
0.29*	-0.18	-0.15	-0.02	-0.18	-0.25*	0.10	-0.18	0.04	-0.08	-0.20*	-0.12	-0.15	-0.22*	-0.17	Tratamento médico necessário
0.44*	-0.07	-0.09	-0.06	-0.08	-0.15	-0.04	-0.06	-0.12	-0.17	-0.10	-0.16	-0.26*	-0.16	-0.17	Dor física
	0.09	-0.03	-0.13	0.27*	0.06	-0.05	0.31*	-0.06	-0.14	-0.00	0.13	0.02	0.01	0.06	Satisfação com saúde
	0.10	-0.03	-0.13	0.27*	0.06	-0.05	0.31*	-0.06	-0.14	-0.00	0.13	0.02	0.01	0.06	Qualidade de vida

A análise das correlações entre o *coping* espiritual (CRE) e os aspectos de qualidade de vida (WHOQOL-BREF), ilustrada nas Figuras 2-A e 2-B, abaixo, revela diversas associações estatisticamente significativas que contribuem para o entendimento do papel do *coping* espiritual na vida dos docentes de enfermagem. A correlação foi avaliada utilizando o coeficiente de *Spearman*, e valores significativos foram indicados com um asterisco.

O "bem-estar social" apresentou correlações importantes em diferentes aspectos. Ele correlacionou-se positivamente com "qualidade de vida" ($r = 0.26$; $p < 0.01$), sugerindo que um maior bem-estar social está associado a uma percepção mais positiva da qualidade de vida entre os docentes. Além disso, houve uma correlação positiva com "capacidade para atividades diárias" ($r = 0.27$; $p < 0.01$) e "energia diária" ($r = 0.30$; $p < 0.01$), reforçando a ideia de que o apoio social e a sensação de bem-estar em interações sociais contribuem para maior vitalidade e capacidade funcional. No entanto, o "bem-estar social" também apresentou uma correlação negativa significativa com "sentimentos negativos" ($r = -0.31$; $p < 0.01$), indicando que docentes com melhor bem-estar social tendem a apresentar menos emoções negativas, o que pode contribuir para uma melhor saúde mental.

A dimensão "força em Deus" mostrou correlações positivas em diversos domínios da qualidade de vida. Por exemplo, correlacionou-se positivamente com "satisfação com saúde" ($r = 0.22$; $p < 0.05$) e "capacidade para o trabalho" ($r = 0.19$; $p = 0.05$), sugerindo que a crença em uma força divina pode estar associada a uma percepção mais positiva da saúde e da capacidade para desempenhar atividades laborais.

A "entrega a Deus" também revelou correlações interessantes. Houve uma correlação positiva com "capacidade para o trabalho" ($r = 0.25$; $p < 0.05$) e "relações pessoais" ($r = 0.30$; $p < 0.01$), sugerindo que docentes que adotam uma postura de entrega a uma força divina tendem a perceber uma maior capacidade laboral e melhores relações interpessoais. Além disso, essa dimensão correlacionou-se negativamente com "sentimentos negativos" ($r = -0.23$; $p < 0.05$), indicando que a prática da entrega pode contribuir para a redução de emoções negativas.

Outra variável relevante foi "conforto espiritual para outros", que apresentou correlações positivas significativas com "relações pessoais" ($r = 0.23$; $p < 0.05$). Esse resultado sugere que proporcionar conforto espiritual a outras pessoas está associado a uma percepção mais positiva das próprias relações interpessoais.

Apesar de algumas correlações não atingirem significância estatística, é importante observar a tendência dos resultados. Por exemplo, "culpa divina pelos erros" mostrou uma correlação negativa com "satisfação com saúde" ($r = -0.20$; $p < 0.05$), indicando que sentimento

de culpa ligados à espiritualidade podem impactar negativamente a percepção da saúde dos docentes.

Uma correlação significativa foi observada entre "confiança em Deus" e "qualidade de vida" ($r = 0.17$; $p < 0.01$), sugerindo que a confiança em uma força superior pode estar associada a uma percepção mais positiva da qualidade de vida. Essa mesma dimensão também apresentou correlação positiva com "capacidade para o trabalho" ($r = 0.21$; $p < 0.05$), indicando que uma forte confiança em Deus pode contribuir para uma maior percepção da capacidade laboral dos docentes (Figura 2-B)

A variável "deixei nas mãos de Deus" também revelou correlações positivas importantes. Houve correlação positiva com "capacidade para o trabalho" ($r = 0.23$; $p < 0.05$) e "relações pessoais" ($r = 0.19$; $p = 0.06$), sugerindo que a prática de entregar as preocupações a uma força superior pode estar associada a um melhor desempenho no trabalho e a melhores relacionamentos interpessoais. Além disso, essa variável apresentou uma correlação positiva com "saúde do ambiente físico" ($r = 0.25$; $p < 0.05$), reforçando a ideia de que uma postura de entrega a uma força divina pode promover uma percepção mais positiva do ambiente ao redor.

Outro resultado interessante foi a correlação entre "confiança em Deus" e "saúde do ambiente físico" ($r = 0.26$; $p < 0.01$). Essa relação sugere que a crença e a confiança em uma força superior podem influenciar positivamente a percepção de saúde no ambiente de trabalho e na vida diária.

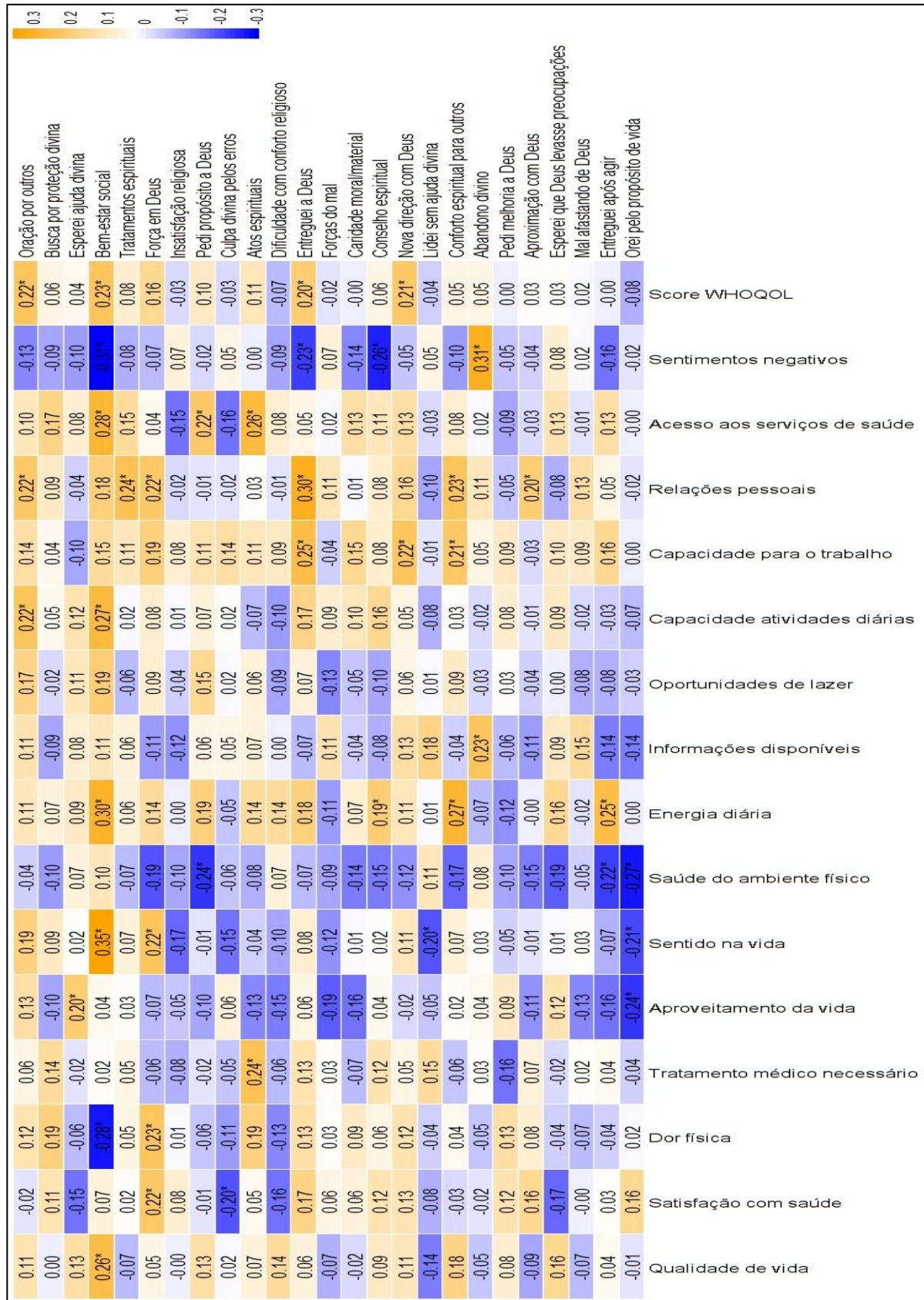
Por outro lado, algumas dimensões espirituais apresentaram correlações negativas com aspectos da qualidade de vida. Por exemplo, "re-despertar espiritual" mostrou uma correlação negativa com "aproveitamento da vida" ($r = -0.28$; $p < 0.01$) e "sentido na vida" ($r = -0.21$; $p < 0.05$). Esses achados indicam que, em alguns casos, o processo de redescoberta espiritual pode estar associado a uma percepção reduzida do aproveitamento e do sentido da vida, o que pode estar relacionado a momentos de crise ou busca espiritual.

Além disso, "culpa divina" apresentou correlações negativas que merecem destaque. Embora não tenha sido estatisticamente significativa em todas as dimensões, "culpa divina" correlacionou-se negativamente com "capacidade para o trabalho" ($r = -0.04$) e "saúde do ambiente físico" ($r = -0.14$). Apesar de a significância estatística não ser estrita, essa tendência pode indicar que sentimento de culpa associados à espiritualidade têm o potencial de impactar negativamente a percepção da qualidade de vida e do ambiente.

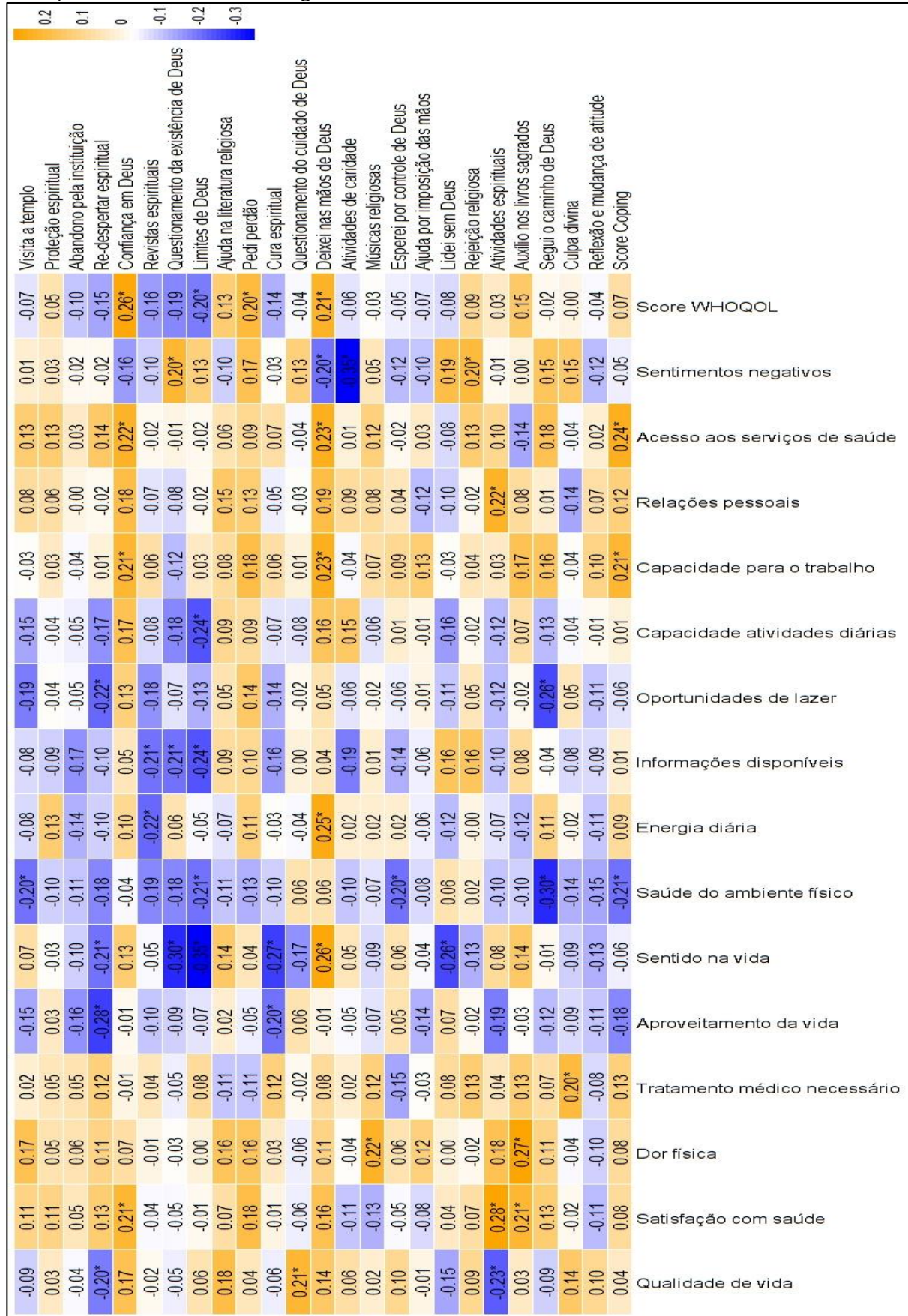
Esses resultados ressaltam a complexidade e a diversidade das estratégias de *coping* espiritual utilizadas pelos docentes de enfermagem e como essas estratégias se associam a diferentes aspectos da qualidade de vida. Os achados são consistentes com a hipótese do estudo

de que o *coping* espiritual pode ter um papel relevante na melhoria do bem-estar e na redução do impacto negativo do estresse e do *Burnout*. A identificação dessas correlações é fundamental para direcionar intervenções que promovam o bem-estar desses profissionais por meio do fortalecimento de práticas espirituais adaptativas.

Figuras 2-A – Correlações entre Dimensões do Coping Espiritual (CRE) e Qualidade de Vida (WHOQOL-BREF) entre Docentes de Enfermagem.



Figuras 2-B – Correlações entre Dimensões do *Coping* Espiritual (CRE) e Qualidade de Vida (WHOQOL-BREF) entre Docentes de Enfermagem.



As Figuras 3-A e 3-B, que seguem abaixo, ilustram as correlações entre as dimensões do *coping* espiritual (CRE) e os aspectos do *Burnout* (CBI) nos docentes de enfermagem. A análise dessas correlações fornece *insights* valiosos sobre como diferentes estratégias de *coping* espiritual se relacionam com as manifestações do *Burnout*, conforme avaliado pelo coeficiente de correlação de *Spearman*. Os valores com asterisco indicam correlações estatisticamente significativas ($p < 0,05$), destacando as associações mais relevantes no contexto do estudo.

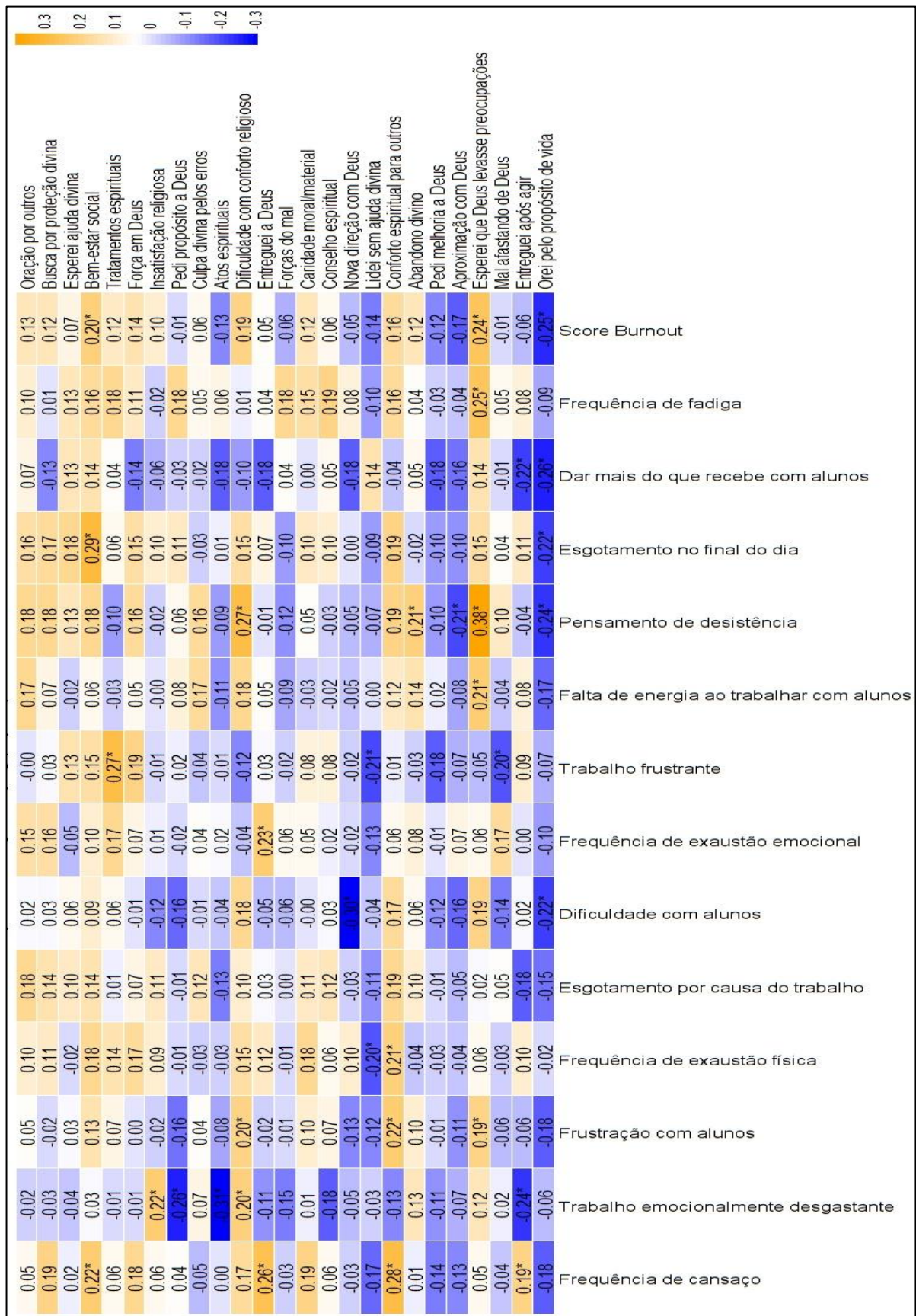
Entre os achados mais notáveis, a correlação entre 'Re-despertar espiritual' e 'Pensamento de desistência' ($r = -0,23$, $p < 0,05$) sugere que o fortalecimento da espiritualidade está relacionado a uma menor frequência de pensamentos de desistência, indicando um impacto positivo do reencontro com a fé em momentos de dificuldade emocional. Da mesma forma, houve uma correlação negativa significativa entre 'Frustração com alunos' e 'Atividades espirituais' ($r = -0,20$, $p < 0,05$), sugerindo que docentes que praticam mais atividades espirituais tendem a experimentar menor frustração ao lidar com os alunos.

Além disso, a correlação entre 'Orei pelo propósito de vida' e o score de *Burnout* ($r = -0,25$, $p < 0,05$) indica que docentes que oram pelo propósito de vida apresentam menores níveis de *Burnout*. Complementarmente, a correlação negativa entre 'Re-despertar espiritual' e o score de *Burnout* ($r = -0,20$, $p < 0,05$) reforça que o fortalecimento espiritual contribui para a redução dos níveis de *Burnout*.

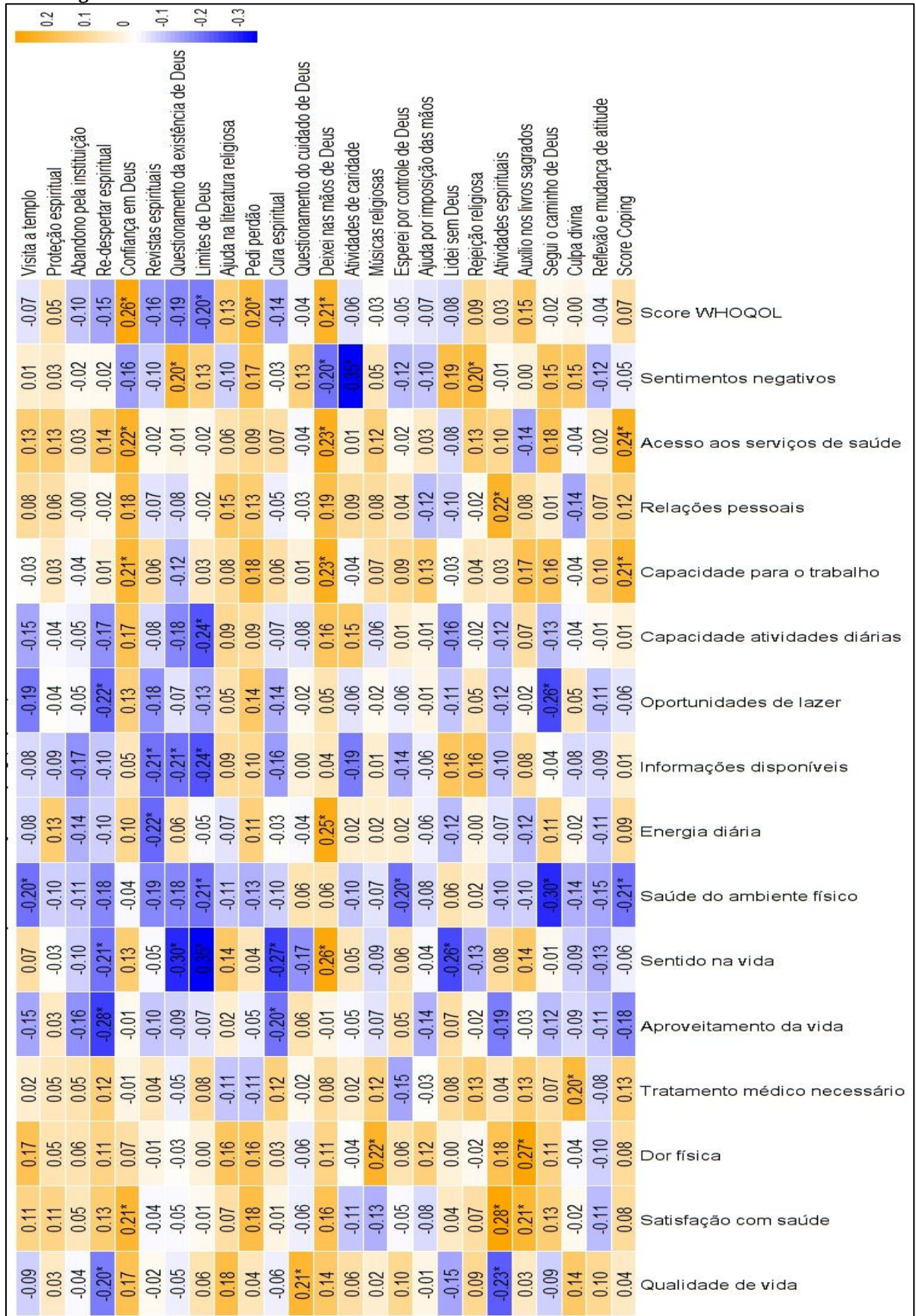
Em contrapartida, houve uma correlação positiva significativa entre 'Dificuldade com conforto religioso' e 'Pensamento de desistência' ($r = 0,27$, $p < 0,05$), sugerindo que docentes que enfrentam maior dificuldade em encontrar conforto religioso tendem a ter mais pensamentos de desistência. Além disso, a correlação negativa entre 'Re-despertar espiritual' e 'Dificuldade com os alunos' ($r = -0,31$, $p < 0,05$) indica que o re-despertar espiritual está associado a menores dificuldades ao lidar com os alunos. Finalmente, a correlação negativa significativa entre 'Cura espiritual' e 'Dificuldade com os alunos' ($r = -0,20$, $p < 0,05$) reforça que recorrer à cura espiritual ajuda os docentes a enfrentarem menos dificuldades nesse aspecto.

Os resultados das correlações evidenciam a importância do *coping* espiritual como uma estratégia eficaz para mitigar os efeitos do *Burnout* e as dificuldades enfrentadas por docentes de Enfermagem. As estratégias espirituais, como o re-despertar espiritual e a oração pelo propósito de vida, mostraram-se associadas a menores níveis de exaustão e frustração, enquanto a dificuldade em encontrar conforto religioso esteve relacionada a um maior risco de pensamentos de desistência, o que reforça a relevância de intervenções que promovam o fortalecimento espiritual como meio de melhorar a saúde mental e o bem-estar dos docentes.

Figuras 3-A – Correlações entre Dimensões do *Coping* Espiritual (CRE) e *Burnout* (CBI) entre Docentes de Enfermagem.



Figuras 3-B – Correlações entre Dimensões do Coping Espiritual (CRE) e Burnout (CBI) entre Docentes de Enfermagem.



Os resultados do primeiro modelo de regressão linear, que tem o escore total de *Burnout* (CBI) como variável dependente, revelam alguns achados importantes. O modelo global apresentou um R^2 ajustado de 0,445, indicando que aproximadamente (44,5%) da variabilidade no escore de *Burnout* é explicada pelas variáveis independentes incluídas no modelo. O teste F global foi significativo ($F = 3,90$; $p = <0,001$), sugerindo que o conjunto de preditores tem um efeito significativo sobre o *Burnout*.

Dentre as variáveis independentes, a percepção da própria saúde física e mental apresentou um resultado relevante. O contraste entre os docentes que percebem sua saúde como "Ruim" em comparação com aqueles que a percebem como "Boa" mostrou um coeficiente negativo significativo (Estimate = -0,4074; $p = 0,00724$). Este achado indica que, ao comparar com os docentes que consideram sua saúde física e mental como "Boa," aqueles que a percebem como "Ruim" apresentam uma diminuição significativa no escore de *Burnout*. Isso sugere que uma percepção negativa da saúde está fortemente associada ao aumento do esgotamento emocional e físico entre os docentes.

Outra variável significativa foi a carga horária de trabalho semanal. A comparação entre os docentes que trabalham de "31 a 40 horas" e aqueles que trabalham "Acima de 40 horas" apresentou um coeficiente negativo significativo (Estimate = -0,5374; $p = 0,00969$). Isso sugere que os docentes com carga horária semanal de 31 a 40 horas têm menores escores de *Burnout* em relação aos que trabalham mais de 40 horas por semana, evidenciando que uma carga horária excessiva pode contribuir para o aumento do *Burnout*.

Quanto às demais variáveis, embora algumas tenham apresentado coeficientes com sinais intuitivos (como o nível de satisfação com o ambiente de trabalho e a percepção da eficácia do *coping* espiritual), não alcançaram significância estatística ($p > 0,05$). Isso indica que, no contexto deste modelo, essas variáveis não tiveram um efeito significativo sobre o escore de *Burnout*.

Por fim, as verificações dos pressupostos do modelo sugerem que não há problemas substanciais de multicolinearidade, com os valores de VIF variando de 1,14 a 1,25, todos bem abaixo do limite crítico de 10. Além disso, o teste de normalidade de Shapiro-Wilk não indicou violação da normalidade dos resíduos ($p = 0,326$), apoiando a validade das inferências do modelo.

Esses resultados destacam a importância da percepção da saúde física e mental, bem como da carga horária de trabalho, como fatores significativos na compreensão dos níveis de *Burnout* entre os docentes de Enfermagem.

Tabela 6 – Resultados da Regressão Linear para o *Escore de Burnout (CBI)* entre Docentes de Enfermagem.

Variável	Score Burnout			
	Coefficiente estimado	Erro padrão	Teste t	p-valor
Tempo de trabalho na enfermagem				
de 10 a 19 anos	0,0882	0,123	0,716	0,47632
menos de 10 anos	0,0796	0,137	0,579	0,56406
Horário de trabalho				
Noturno – Diurno	0,1180	0,116	1,014	0,31416
Plantão – Diurno	-0,3944	0,304	-1,297	0,19859
Nível de satisfação com o ambiente de trabalho atual				
Muito insatisfeito – Insatisfeito	0,3831	0,322	1,188	0,23866
Muito satisfeito – Insatisfeito	0,1972	0,248	0,796	0,42890
Neutro – Insatisfeito	0,1130	0,232	0,488	0,62711
Satisfeito – Insatisfeito	0,2626	0,218	1,206	0,23170
Percepção da própria saúde física e mental				
Excelente – Boa	0,0311	0,258	0,121	0,90438
Regular – Boa	-0,2515	0,128	-1,970	0,05267
Ruim – Boa	-0,4074	0,147	-2,763	0,00724
Percepção da eficácia do Coping espiritual no manejo do estresse profissional				
Muito eficaz – Eficaz	-0,0777	0,131	-0,595	0,55349
Neutro – Eficaz	-0,1536	0,129	-1,193	0,23667
Pouco eficaz – Eficaz	0,1687	0,220	0,765	0,44658
Frequência que realiza práticas de cuidado pessoal relacionadas à saúde mental				
Nunca – Frequentemente	-0,0579	0,185	-0,313	0,75533
Ocasionalmente – Frequentemente	0,1655	0,153	1,085	0,28134
Raramente – Frequentemente	-0,0758	0,137	-0,552	0,58295
Sempre – Frequentemente	0,2432	0,160	1,516	0,13386
Como você classificaria a sua satisfação com o suporte emocional disponível no seu ambiente de trabalho?				
Muito insatisfeito(a) – Insatisfeito(a)	0,2454	0,197	1,246	0,21681
Muito satisfeito(a) – Insatisfeito(a)	-0,1946	0,395	-0,492	0,62388
Neutro – Insatisfeito(a)	-0,2139	0,139	-1,541	0,12767
Satisfeito(a) – Insatisfeito(a)	0,2145	0,150	1,427	0,15774
Carga horaria de trabalho semanal				
Até 30 horas – Acima de 40 horas	-0,2707	0,167	-1,623	0,10881
de 31 a 40 horas – Acima de 40 horas	-0,5374	0,202	-2,656	0,00969
Frequência de atividades de recuperação após o trabalho				
Nunca – Diariamente	-0,6009	0,538	-1,118	0,26728
Raramente – Diariamente	-0,1383	0,191	-0,726	0,47042
Semanalmente – Diariamente	0,0413	0,202	0,205	0,83821

Várias vezes por semana – Diariamente	0,0825	0,206	0,400	0,69024
---------------------------------------	--------	-------	-------	---------

O modelo de regressão linear para o escore de *coping* (Tabela 7, abaixo) apresentou um ajuste relativamente baixo, com um R^2 ajustado de 0,16, indicando que as variáveis preditoras explicam apenas 16,7% da variabilidade no escore de *coping*. O teste do modelo geral não foi significativo ($F(28, 73) = 1,06$, $p = 0,407$), sugerindo que, coletivamente, as variáveis preditoras não fornecem uma explicação significativa para o escore de *coping*.

Analisando os coeficientes das variáveis preditoras individualmente, destaca-se que a percepção da eficácia do *coping* espiritual no manejo do estresse profissional foi uma variável importante. Especificamente, aqueles que classificaram seu *coping* espiritual como "muito eficaz" apresentaram um coeficiente estimado de 0,31887 ($p = 0,0155$), indicando uma associação positiva e estatisticamente significativa com o escore de *coping*. Isso sugere que uma percepção de maior eficácia do coping espiritual pode estar associada a escores de *coping* mais elevados.

Outro resultado relevante foi a frequência de práticas de cuidado pessoal relacionadas à saúde mental. Embora a maioria das categorias não tenha apresentado significância estatística, a categoria "sempre" em relação a "frequentemente" mostrou um coeficiente estimado de 0,30924 ($p = 0,0545$), indicando uma tendência de associação positiva com o escore de *coping*, embora não atinja o nível convencional de significância ($p < 0,05$).

As demais variáveis, incluindo o tempo de trabalho na enfermagem, horário de trabalho, satisfação com o ambiente de trabalho, percepção da própria saúde física e mental, carga horária semanal de trabalho, frequência de atividades de recuperação após o trabalho e satisfação com o suporte emocional no ambiente de trabalho, não demonstraram associações estatisticamente significativas com o escore de coping no modelo.

Tabela 7 – Resultados da Regressão Linear para o Escore de Coping Espiritual (CRE) entre Docentes de Enfermagem.

Variável	Score Coping			
	Coeficiente estimado	Erro padrão	Teste t	p-valor
Tempo de trabalho na enfermagem				
de 10 a 19 anos	0.06240	0.121	0.51394	0.6088
menos de 10 anos	0.03231	0.135	0.23854	0.8121
Horário de trabalho				
Noturno – Diurno	0.02659	0.115	0.23162	0.8175

Plantão – Diurno	-0.18646	0.300	-0.62202	0.5359
Nível de satisfação com o ambiente de trabalho atual				
Muito insatisfeito – Insatisfeito	0.18749	0.318	0.58979	0.5572
Muito satisfeito – Insatisfeito	0.12464	0.244	0.50999	0.6116
Neutro – Insatisfeito	-0.00942	0.228	-0.04125	0.9672
Satisfeito – Insatisfeito	0.07244	0.215	0.33747	0.7367
Percepção da própria saúde física e mental				
Excelente – Boa	-0.05665	0.254	-0.22273	0.8244
Regular – Boa	-0.15558	0.126	-1.23594	0.2204
Ruim – Boa	-0.15222	0.145	-1.04702	0.2985
Percepção da eficácia do Coping espiritual no manejo do estresse profissional				
Muito eficaz – Eficaz	0.31887	0.129	2.47793	0.0155
Neutro – Eficaz	-0.09707	0.127	-0.76479	0.4469
Pouco eficaz – Eficaz	-0.20729	0.217	-0.95347	0.3435
Frequência que realiza práticas de cuidado pessoal relacionadas à saúde mental				
Nunca – Frequentemente	0.00178	0.182	0.00977	0.9922
Ocasionalmente – Frequentemente	0.19939	0.150	1.32589	0.1890
Raramente – Frequentemente	0.20723	0.136	1.52882	0.1306
Sempre – Frequentemente	0.30924	0.158	1.95454	0.0545
Como você classificaria a sua satisfação com o suporte emocional disponível no seu ambiente de trabalho?				
Muito insatisfeito(a) – Insatisfeito(a)	0.10272	0.194	0.52898	0.5984
Muito satisfeito(a) – Insatisfeito(a)	0.12735	0.390	0.32680	0.7448
Neutro – Insatisfeito(a)	0.17600	0.137	1.28593	0.2025
Satisfeito(a) – Insatisfeito(a)	7.68e-4	0.148	0.00518	0.9959
Carga horaria de trabalho semanal				
Até 30 horas	-0.04387	0.164	-0.26680	0.7904
de 31 a 40 horas	0.03488	0.199	0.17489	0.8617
Frequência de atividades de recuperação após o trabalho				
Nunca – Diariamente	-0.43480	0.530	-0.82037	0.4147
Raramente – Diariamente	-0.11088	0.188	-0.58997	0.5570
Semanalmente – Diariamente	-0.16360	0.199	-0.82321	0.4131
Várias vezes por semana – Diariamente	-0.28733	0.203	-1.41369	0.1617

No terceiro modelo de regressão linear, com o escore de qualidade de vida (*WHOQOL*) como variável dependente, o modelo apresentou um R^2 ajustado de 0,559, indicando que 55,9% da variabilidade do escore de qualidade de vida foi explicada pelas variáveis independentes consideradas no modelo. O teste geral do modelo foi significativo ($F = 5,58$, $p < 0,001$), sugerindo que, coletivamente, os preditores têm um efeito significativo na qualidade de vida.

Analisando os coeficientes estimados, destaca-se a variável "percepção da própria saúde física e mental: excelente em relação à boa", que apresentou uma estimativa positiva de 0,43835 ($p = 0,00356$), indicando que aqueles com percepção da saúde física e mental como excelente têm uma maior qualidade de vida em comparação com aqueles que a percebem como boa. Além disso, a "percepção da saúde física e mental: regular em relação à boa" apresentou uma estimativa negativa de -0,22970 ($p = 0,00210$), sugerindo que perceber a saúde física e mental como regular está associada a uma menor qualidade de vida.

Outra variável significativa foi "frequência que realiza práticas de cuidado pessoal relacionadas à saúde mental: sempre em relação a frequentemente", com uma estimativa de 0,27972 ($p = 0,00283$), indicando que realizar práticas de cuidado pessoal com maior frequência está associado a uma melhor qualidade de vida. Além disso, a "frequência de atividades de recuperação após o trabalho: raramente em relação a diariamente" apresentou um coeficiente negativo de -0,38791 ($p = 5,63e-4$), sugerindo que aqueles que raramente realizam atividades de recuperação após o trabalho têm menor qualidade de vida em comparação com aqueles que as realizam diariamente.

As demais variáveis, como "tempo de trabalho na enfermagem", "horário de trabalho", "nível de satisfação com o ambiente de trabalho atual", "percepção da eficácia do *coping* espiritual no manejo do estresse profissional" e "satisfação com o suporte emocional disponível", não foram estatisticamente significativas no modelo, com valores de p maiores que 0,05.

Os testes de colinearidade indicaram que não há problemas de multicolinearidade, com os VIFs variando entre 1,14 e 1,25, todos abaixo do valor crítico de 10. O teste de normalidade (*Shapiro-Wilk*) apresentou um valor de p de 0,265, indicando que os resíduos seguem uma distribuição normal, atendendo à suposição da regressão linear.

Tabela 8 - Análise de Regressão Linear para o Escore de Qualidade de Vida (WHOQOL) e Variáveis Sociodemográficas e de *Coping* Espiritual.

Variável	Score WHOQOL			
	Coeficiente estimado	Erro padrão	Teste t	p-valor
Tempo de trabalho na enfermagem				
de 10 a 19 anos	-0.07980	0.0695	-1.149	0.25439
menos de 10 anos	-0.12234	0.0775	-1.579	0.11867
Horário de trabalho				
Noturno – Diurno	0.00975	0.0657	0.148	0.88244
Plantão – Diurno	0.16080	0.1715	0.938	0.35153

Nível de satisfação com o ambiente de trabalho atual				
Muito insatisfeito – Insatisfeito	0.06161	0.1819	0.339	0.73579
Muito satisfeito – Insatisfeito	0.10149	0.1398	0.726	0.47024
Neutro – Insatisfeito	-0.02859	0.1307	-0.219	0.82744
Satisfeito – Insatisfeito	-0.09924	0.1228	-0.808	0.42168
Percepção da própria saúde física e mental				
Excelente – Boa	0.43835	0.1455	3.013	0.00356
Regular – Boa	-0.22970	0.0720	-3.189	0.00210
Ruim – Boa	-0.04271	0.0832	-0.513	0.60916
Percepção da eficácia do <i>Coping</i> espiritual no manejo do estresse profissional				
Muito eficaz – Eficaz	-0.06144	0.0736	-0.835	0.40670
Neutro – Eficaz	-0.01770	0.0726	-0.244	0.80807
Pouco eficaz – Eficaz	-0.04734	0.1244	-0.381	0.70463
Frequência que realiza práticas de cuidado pessoal relacionadas à saúde mental				
Nunca – Frequentemente	0.06667	0.1044	0.639	0.52512
Ocasionalmente – Frequentemente	0.10128	0.0860	1.177	0.24293
Raramente – Frequentemente	0.12080	0.0776	1.558	0.12362
Sempre – Frequentemente	0.27972	0.0905	3.090	0.00283
Como você classificaria a sua satisfação com o suporte emocional disponível no seu ambiente de trabalho?				
Muito insatisfeito(a) – Insatisfeito(a)	0.10948	0.1111	0.986	0.32762
Muito satisfeito(a) – Insatisfeito(a)	-0.13996	0.2229	-0.628	0.53211
Neutro – Insatisfeito(a)	0.02932	0.0783	0.375	0.70911
Satisfeito(a) – Insatisfeito(a)	0.11309	0.0848	1.334	0.18633
Carga horaria de trabalho semanal				
Até 30 horas	-0.04984	0.0941	-0.530	0.59786
de 31 a 40 horas	-0.15873	0.1141	-1.391	0.16844
Frequência de atividades de recuperação após o trabalho				
Nunca – Diariamente	-0.19200	0.3032	-0.633	0.52859
Raramente – Diariamente	-0.38791	0.1075	-3.608	5.63e0-4
Semanalmente – Diariamente	-0.04209	0.1137	-0.370	0.71230
Várias vezes por semana – Diariamente	0.11915	0.1163	1.025	0.30891

9.2 RESULTADOS QUALITATIVOS

A análise qualitativa deste estudo busca explorar as percepções, experiências e desafios enfrentados pelos docentes de enfermagem no contexto de suas atividades profissionais, considerando aspectos emocionais, ocupacionais e espirituais. Por meio dos relatos obtidos, foram identificados temas centrais que refletem as vivências individuais e coletivas desses profissionais, permitindo uma compreensão mais profunda das dinâmicas que influenciam sua saúde mental, qualidade de vida e enfrentamento de adversidades.

Os temas analisados incluem desde a sobrecarga de trabalho e suas implicações para o bem-estar até a importância da espiritualidade como mecanismo de resiliência, passando por questões como falta de controle e autonomia, ambientes de trabalho tóxicos e os desafios tecnológicos enfrentados no ensino remoto. Cada tema será abordado com base nos relatos dos participantes, discutindo-se suas conexões com a literatura científica e a relevância de tais achados para a prática docente e a saúde ocupacional.

Essa abordagem qualitativa complementa os achados quantitativos, fornecendo uma perspectiva mais rica e detalhada sobre os fenômenos estudados, contribuindo para um entendimento mais integrado das complexas relações entre *coping* espiritual, *Burnout* e qualidade de vida.

9.2.1 Sobrecarga e Pressão no Trabalho

A sobrecarga de trabalho e a pressão por desempenho foram temas recorrentes nos relatos dos docentes, evidenciando a alta demanda física e emocional que caracteriza a profissão. A necessidade de equilibrar múltiplas responsabilidades, como ensino, pesquisa e atividades administrativas, somada às exigências institucionais, contribuiu significativamente para o desenvolvimento de esgotamento físico e mental, corroborando a literatura que associa esses fatores ao *Burnout* (Maslach, 2001; Benevides-Pereira, 2002).

Viegas (2022) observa que essa realidade se estende para o espaço doméstico, especialmente para docentes, que levam o trabalho para casa. A tentativa de conciliar as responsabilidades escolares e domésticas eleva a intensidade em ambas as esferas, resultando em um cansaço acumulado que, como ressalto, leva ao adoecimento. Além disso, esse esgotamento pode ser interpretado como o alto custo do sucesso, decorrente da busca incessante individual por atingir os ideais de excelência prevalentes na sociedade contemporânea (Freudenberger; Richelson, 1991).

Alguns participantes descreveram o impacto direto da carga horária excessiva e das responsabilidades acumuladas. O **Docente 12 (F, 21-30 anos)** compartilhou: *“Cansaço físico e mental entre as aulas e os plantões, e no último domingo um plantão tumultuado com escala técnica reduzida.”* Esse relato reflete a dificuldade em conciliar atividades acadêmicas e práticas assistenciais, especialmente em contextos com limitações de recursos.

Além disso, a pressão para assumir tarefas fora da expertise ou por imposição foi apontada como fonte adicional de estresse. O **Docente 35 (F, 41-50 anos)** mencionou: *“Assumir uma disciplina que não estava no meu rol de estudos,”* enquanto o **Docente 44 (F, 31-40 anos)** destacou: *“Assumir disciplina sem gostar, por falta de opção e por solicitação da coordenação.”* Tais situações ressaltam a falta de autonomia nas decisões relacionadas ao trabalho docente, fator que, segundo Karasek (1979), pode amplificar os níveis de estresse ocupacional.

A pandemia de COVID-19 agravou ainda mais esses desafios, expondo docentes a demandas emocionais e técnicas sem precedentes. O **Docente 22 (M, 51-60 anos)** descreveu: *“Trabalhar na linha de frente na pandemia, vendo muitos óbitos,”* enquanto o **Docente 40 (F, 51-60 anos)** relatou: *“Trabalho durante a pandemia.”* Esses exemplos mostram como a sobrecarga se intensificou em um período de crise sanitária global, adicionando camadas de estresse relacionadas ao medo de contaminação e às perdas pessoais e profissionais.

As cobranças institucionais excessivas também apareceram como uma fonte significativa de tensão. O **Docente 89 (F, 41-50 anos)** afirmou: *“Cobranças exageradas,”* ecoando preocupações semelhantes trazidas pelo **Docente 101 (M, 31-40 anos)**: *“Agenda sobrecarregada.”* Esses relatos são consistentes com estudos que apontam a pressão por produtividade e desempenho como fatores que agravam o risco de *Burnout* entre profissionais da educação (Maslach *et al.*, 2001).

Essa omissão institucional em prover os recursos básicos de suporte e a manutenção de uma carga de trabalho excessiva extrapolam a dimensão da má gestão e adentram o domínio da injustiça social. O adoecimento, neste contexto, não é um acidente biológico ou um fracasso individual na gestão do estresse; ele se configura como o corpo adoecido da desigualdade, a materialização da falência das estruturas sociais e organizacionais que deveriam zelar pela saúde integral do trabalhador.

Ao negligenciar a necessidade de recursos, autonomia e amparo emocional para seus docentes, a instituição de ensino viola o imperativo da Ética da Alteridade, que exige a responsabilidade radical perante o sofrimento do Outro. Conforme Boff (1999) e a própria reflexão sobre a Alteridade (Levinas, 1982), o cuidado ético pressupõe a garantia de um *ethos*,

de uma morada segura para a vulnerabilidade. A sobrecarga e o baixo suporte, ao contrário, negam essa morada, impondo ao indivíduo a exclusividade na luta contra o esgotamento.

Desse modo, o *Burnout* entre docentes, mais do que uma síndrome ocupacional, torna-se uma denúncia ética: é a evidência de que a dignidade humana e a justiça social foram violadas no espaço laboral, sendo o sofrimento do profissional a consequência direta do colapso do contrato social entre o indivíduo e a organização. A intervenção, portanto, não pode se limitar ao âmbito clínico individual, mas deve exigir a transformação nas causas estruturais que geram o sofrimento, conforme o fundamento teórico que guia esta tese.

9.2.2 Impactos Emocionais do Trabalho Docente

Os impactos emocionais do trabalho docente são uma dimensão central ao se analisar o bem-estar dos profissionais da educação, especialmente em contextos de alta pressão e responsabilidades acumuladas. Os relatos coletados nesta pesquisa revelam uma gama de experiências emocionais, desde sentimentos de ansiedade e frustração até esgotamento emocional, frequentemente associados a situações adversas enfrentadas no cotidiano acadêmico e assistencial.

A exaustão emocional é uma das dimensões centrais do *Burnout*, e os desafios enfrentados pelos docentes são emblemáticos desse processo (Maslach; Schaufeli; Leiter, 2001). O **Docente 22 (M, 51-60 anos)** descreveu o impacto psicológico de atuar na linha de frente durante a pandemia: *“Trabalhar na linha de frente na pandemia, vendo muitos óbitos.”* Essa fala reflete o peso emocional de lidar com a morte em grande escala, agravado pelo medo constante de contaminação. Esse cenário está alinhado com estudos de Holmes *et al.* (2020), que destacam o impacto significativo de eventos críticos, como a pandemia de COVID-19, na saúde mental de profissionais de saúde e educação.

A ausência de suporte adequado, tanto institucional quanto emocional, também foi uma preocupação recorrente entre os participantes. O **Docente 8 (F, 41-50 anos)** relatou: *“Trabalhar na pandemia com um filho pequeno,”* ilustrando as dificuldades de conciliar demandas familiares e profissionais em um período de incertezas e limitações estruturais. Para Maslach e Leiter (1999), a incompatibilidade entre as demandas do trabalho e as necessidades pessoais é uma das principais causas de esgotamento.

Os conflitos interpessoais no ambiente educacional emergiram como outra fonte de desgaste emocional significativo. O **Docente 38 (F, 31-40 anos)** afirmou: *“Alunos que desrespeitam enquanto professor,”* e o **Docente 31 (F, 41-50 anos)** compartilhou: *“Atender*

estudante que tentou autoextermínio.” Essas situações não apenas ampliam a carga emocional dos docentes, mas também reforçam o sentimento de impotência, um fator associado ao aumento do estresse ocupacional (Einarsen *et al.*, 2011). O enfrentamento dessas situações exige não apenas competências técnicas, mas também suporte emocional, muitas vezes ausente nas instituições.

A frustração relacionada às condições de trabalho foi outro tema recorrente. O **Docente 6 (M, 21-30 anos)** relatou: “*Desvalorização profissional, desinteresse profissional, foi quando senti vontade de desistir de tudo.*” Esse sentimento de desânimo e falta de reconhecimento está amplamente documentado na literatura, que associa esses fatores à baixa satisfação profissional e ao aumento da incidência de transtornos emocionais (Karasek, 1979; Deci; Ryan, 1985).

Além disso, as cobranças institucionais e as agendas sobrecarregadas foram descritas como fatores de estresse contínuo. O **Docente 89 (F, 41-50 anos)** afirmou: “*Cobranças exageradas,*” enquanto o **Docente 101 (M, 31-40 anos)** destacou: “*Agenda sobrecarregada.*” Tais relatos corroboram estudos de Kniffin *et al.* (2021), que destacam como a combinação de altas exigências laborais e recursos limitados pode gerar um ambiente de trabalho tóxico, prejudicando tanto a saúde mental quanto a produtividade.

O isolamento social, intensificado durante a pandemia, também foi citado como um agravante. A perda de interações presenciais com alunos e colegas privou os docentes de importantes fontes de suporte emocional e social. Para Hobfoll (1989), a falta de recursos sociais, como apoio interpessoal, é um dos fatores que mais contribuem para o esgotamento mental, especialmente em contextos de alta demanda.

Diante desses achados, é evidente que os impactos emocionais do trabalho docente vão além da exaustão física, abrangendo aspectos de saúde mental que exigem atenção imediata. A necessidade de intervenções institucionais que promovam suporte psicológico, capacitação para o enfrentamento de conflitos e uma carga de trabalho mais equilibrada é evidente. Conforme Pargament *et al.* (1998), estratégias como o *coping* emocional positivo podem ser ferramentas eficazes para ajudar os docentes a lidarem com o estresse e encontrar resiliência diante de adversidades.

Os relatos aqui apresentados reforçam a necessidade de uma abordagem multidimensional para a saúde ocupacional dos docentes, com foco em políticas institucionais que mitiguem as fontes de estresse, fortaleçam as redes de apoio social e promovam um ambiente de trabalho mais acolhedor. Essas ações são fundamentais para garantir a saúde mental e a qualidade de vida dos professores, assegurando um desempenho profissional sustentável e satisfatório.

9.2.3 Relação entre Espiritualidade e Bem-Estar

A espiritualidade emergiu como um componente significativo no enfrentamento dos desafios emocionais enfrentados pelos docentes. Diversos participantes destacaram que práticas espirituais, como oração, meditação e reflexão, desempenharam um papel fundamental na manutenção do bem-estar durante momentos críticos. Esses relatos estão alinhados com a literatura, que reconhece a espiritualidade como um recurso protetor contra o estresse, promovendo resiliência e equilíbrio emocional (Koenig, 2020; Pargament *et al.*, 1998).

O **Docente 35 (F, 41-50 anos)** compartilhou: “*Confiei em Deus e senti que Ele me deu forças para continuar.*” Essa fala exemplifica como a fé pode atuar como um mecanismo de suporte emocional, ajudando os indivíduos a encontrar significado e propósito em meio a adversidades. De acordo com Koenig (2020), práticas espirituais têm o potencial de reduzir sintomas de depressão e ansiedade, fornecendo uma base de estabilidade emocional em momentos de crise.

Além disso, a espiritualidade foi associada à capacidade de enfrentar situações de extrema dificuldade no ambiente de trabalho. O **Docente 44 (F, 31-40 anos)** relatou: “*Orei pelo propósito de vida e encontrei forças para continuar, mesmo quando o trabalho parecia insuportável.*” Essa busca por significado através da espiritualidade está alinhada com os conceitos de coping religioso positivo discutidos por Pargament *et al.* (1998), que destacam como práticas construtivas de fé podem promover melhores resultados emocionais e psicológicos. Alinhando ao pensamento de Koenig (2020), onde a espiritualidade é entendida como a busca de sentido na vida, em um sentido mais restrito e pessoal.

Na forma positiva, a fé e a conexão com o sagrado oferecem conforto, esperança e propósito, permitindo que o sofrimento seja visto como uma chance de crescimento. Essa abordagem está ligada a melhores resultados na saúde mental e a um menor risco de suicídio.

No entanto, a espiritualidade também pode se tornar uma fonte de sofrimento. A ausência de práticas espirituais ou a dificuldade em encontrar conforto espiritual foi mencionada como um fator que intensificou sentimento de frustração e desânimo. Isso acontece, por exemplo, quando a pessoa adota um tipo de *coping* religioso negativo, culpando Deus por seus fracassos ou interpretando o sofrimento como uma punição divina. A rigidez de dogmas, os conflitos dentro das instituições religiosas e a substituição do tratamento médico pela fé são outros fatores que podem prejudicar a saúde mental.

Nesses casos, a espiritualidade, em vez de ser um refúgio, torna-se um fardo que pode aumentar a ansiedade e a depressão. O **Docente 89 (F, 41-50 anos)** comentou: *“Tive muita dificuldade em encontrar conforto espiritual, o que me fez pensar em desistir várias vezes.”* Esses relatos ilustram o impacto adverso da falta de suporte espiritual no bem-estar emocional, corroborando a ideia de que o *coping* religioso negativo pode exacerbar sentimentos de desesperança (Pargament *et al.*, 1998).

Práticas específicas de cura espiritual também foram destacadas como estratégias eficazes de enfrentamento. O **Docente 12 (F, 21-30 anos)** relatou: *“Recorri à cura espiritual para lidar com o estresse no trabalho, e isso me ajudou a manter a calma em situações difíceis.”* Essas experiências reforçam o argumento de Moreira-Almeida (2006), que propõe que a espiritualidade pode oferecer um senso de comunidade e apoio emocional, especialmente em momentos de alta exigência.

A conexão entre espiritualidade e bem-estar também foi evidente na forma como os docentes enfrentaram o isolamento social e as adversidades da pandemia. Para muitos, a espiritualidade forneceu um refúgio emocional que lhes permitiu continuar desempenhando suas funções com equilíbrio e resiliência. Conforme Koenig (2020), a prática de atividades espirituais regulares não só reduz o estresse, mas também promove um senso de propósito e pertencimento, que são cruciais para a saúde mental.

Desse modo, os dados qualitativos reforçam que a espiritualidade não é apenas uma prática individual, mas um recurso estratégico de enfrentamento que impacta positivamente o bem-estar emocional dos docentes. A inclusão de práticas espirituais nos contextos educacional e organizacional pode oferecer benefícios significativos, ajudando a construir resiliência frente às adversidades e promovendo um ambiente mais saudável e colaborativo. Além disso, as instituições devem considerar formas de integrar essas práticas em suas políticas de suporte emocional, reconhecendo o papel central da espiritualidade na promoção da saúde mental e no fortalecimento dos vínculos sociais no ambiente de trabalho.

9.2.4 Falta de Controle e Autonomia no Trabalho

A falta de controle e autonomia no ambiente profissional foi um tema recorrente nos relatos dos docentes, destacando o impacto emocional causado pela incapacidade de tomar decisões significativas relacionadas ao trabalho. De acordo com Karasek (1979), ambientes de trabalho com alta demanda e baixa autonomia estão associados a níveis elevados de estresse e,

em longo prazo, ao desenvolvimento de esgotamento emocional e *Burnout*. Esses efeitos foram evidenciados nos depoimentos dos participantes.

O **Docente 6 (M, 21-30 anos)** relatou: *“Desvalorização profissional, desinteresse profissional, foi quando senti vontade de desistir de tudo.”* Esse relato reflete como a falta de reconhecimento e controle sobre as próprias tarefas pode levar a sentimento de frustração e desmotivação, corroborando os achados de Deci e Ryan (1985), que apontam que a autonomia está diretamente relacionada ao bem-estar psicológico e à satisfação no trabalho.

Situações em que os docentes foram forçados a assumir responsabilidades fora de sua área de especialidade ou interesse foram frequentemente mencionadas. O **Docente 44 (F, 31-40 anos)** afirmou: *“Assumir disciplina sem gostar, por falta de opção e por solicitação da coordenação.”* Da mesma forma, o **Docente 35 (F, 41-50 anos)** comentou: *“Assumir uma disciplina que não estava no meu rol de estudos.”* Essas experiências ressaltam a sensação de impotência e a desconexão com o próprio trabalho, o que pode comprometer a motivação e aumentar os níveis de estresse.

A dificuldade em lidar com as exigências do trabalho e a sensação de sobrecarga também foram destacadas. O **Docente 43 (M, 21-30 anos)** compartilhou uma experiência traumática: *“A maior situação ocorreu em um plantão. Neste dia perdi uma paciente (pediátrica de 5 meses e 24 dias). Hospital lotado e não tinha recursos disponíveis para o atendimento de qualidade da mesma.”* Esse caso ilustra como a falta de controle sobre recursos essenciais pode exacerbar o impacto emocional em situações críticas, especialmente em profissões de alta demanda como o ensino e a assistência à saúde.

A falta de oportunidades profissionais também foi um fator mencionado como gerador de insatisfação e desmotivação. A **Docente 52 (F, 31-40 anos)** afirmou: *“Falta de oportunidade de emprego.”* Já a **Docente 53 (F, 21-30 anos)** relatou: *“Fiquei desempregada.”* Esses exemplos reforçam a ideia de que a ausência de opções ou alternativas profissionais limita a capacidade de decisão dos indivíduos, contribuindo para sentimento de insegurança e insatisfação.

Além disso, mudanças de emprego e a necessidade de se adaptar a novas funções sem preparação adequada também geraram desconforto. O **Docente 45 (M, 41-50 anos)** comentou: *“Mudança de emprego em outra linha de atuação.”* Esses relatos refletem o impacto da instabilidade profissional na saúde emocional dos docentes, alinhando-se aos estudos de Hobfoll (1989), que destacam como a perda de recursos profissionais e pessoais afeta negativamente o bem-estar.

Em síntese, a falta de controle e autonomia no trabalho não apenas contribui para o aumento do estresse e da frustração, mas também compromete o bem-estar psicológico dos docentes. Como discutido por Karasek (1979), ambientes que oferecem maior autonomia e envolvimento na tomada de decisões são mais propensos a promover a satisfação e a saúde mental. Assim, é essencial que as instituições considerem estratégias para aumentar a autonomia e o controle dos docentes sobre suas funções, minimizando os efeitos negativos dessa falta de poder decisório. Programas de suporte e capacitação, bem como oportunidades para participação ativa na organização do trabalho, podem ser instrumentos valiosos para mitigar os impactos negativos associados à falta de autonomia.

9.2.5 Ambientes de Trabalho Tóxicos

Ambientes de trabalho caracterizados por assédio moral, conflitos interpessoais e ausência de apoio social foram apontados como fatores significativos de desgaste emocional e mental pelos docentes participantes. Esses aspectos não apenas aumentam a vulnerabilidade ao estresse, mas também intensificam o risco de desenvolvimento de transtornos mentais, como *Burnout* e ansiedade, conforme evidenciado por (Einarsen *et al.* 2011).

Os relatos destacam a gravidade dessas situações. A **Docente 34 (F, 51-60 anos)** mencionou: *"Assédio no trabalho por parte de colegas da área de atuação."* Esse tipo de experiência pode levar à deterioração das relações profissionais e ao isolamento, comprometendo tanto o desempenho quanto o bem-estar emocional. De forma semelhante, a **Docente 38 (F, 31-40 anos)** relatou: *"Alunos que desrespeitam enquanto professor."* Esses casos revelam como a falta de respeito, seja entre colegas ou com os próprios alunos, contribui para a criação de um ambiente de trabalho hostil.

Conflitos interpessoais também foram frequentemente citados, destacando o impacto da falta de coesão e suporte no ambiente de trabalho. A **Docente 17 (F, 21-30 anos)** afirmou: *"Conflito entre os alunos,"* enquanto a **Docente 103 (F, 51-60 anos)** descreveu: *"Conflito com alguns membros da equipe de trabalho no início do ano."* Essas situações reforçam a ideia de que um ambiente de trabalho colaborativo e respeitoso é essencial para o bem-estar dos profissionais, conforme discutido por Hobfoll (1989), que destaca a importância de recursos sociais e interpessoais no enfrentamento do estresse.

A competitividade excessiva e a falta de suporte social também foram apontadas como fatores prejudiciais. A **Docente 98 (F, 31-40 anos)** relatou: *"Competitividade entre os colegas,"* o que reflete uma dinâmica profissional desgastante e contraproducente. Além disso, a ausência

de uma rede de apoio social no trabalho foi amplamente mencionada como um agravante para o estresse emocional.

A ausência de estratégias institucionais para lidar com essas questões agrava ainda mais a situação. A **Docente 31 (F, 41-50 anos)** compartilhou uma experiência particularmente angustiante: "*Atender estudante que tentou autoextermínio.*" Este tipo de evento sublinha a necessidade de suporte adequado e de um ambiente de trabalho que priorize o bem-estar psicológico dos professores.

Conforme apontado por Maslach e Leiter (1999), ambientes de trabalho tóxicos têm um impacto direto no esgotamento emocional, na despersonalização e na redução da eficácia profissional, que são as três dimensões centrais do *Burnout*. A literatura também evidencia que a falta de apoio social no ambiente de trabalho está associada a níveis mais altos de estresse e insatisfação, destacando a importância de redes de suporte e políticas institucionais que favoreçam a saúde emocional (Hobfoll, 1989; Einarsen *et al.*, 2011).

Dessa forma, para minimizar os impactos de ambientes de trabalho tóxicos, é crucial que as instituições adotem práticas que promovam o respeito, a comunicação clara e o suporte interpessoal. A criação de programas de prevenção e combate ao assédio, além de estratégias para fomentar a colaboração e o apoio entre colegas, pode reduzir significativamente os fatores de risco associados a esses ambientes. Além disso, o fortalecimento de redes de apoio social e a implementação de políticas institucionais voltadas para o bem-estar emocional dos docentes são fundamentais para transformar o ambiente de trabalho em um espaço mais acolhedor e saudável.

9.2.6 Desafios Tecnológicos e Ensino Remoto

A transição abrupta para o ensino remoto, causada pela pandemia de COVID-19, trouxe desafios tecnológicos significativos para os docentes, impactando tanto sua prática pedagógica quanto seu bem-estar emocional. A necessidade de adaptação rápida às novas ferramentas digitais e a ausência de suporte técnico adequado geraram níveis elevados de estresse, ansiedade e frustração. Esses fatores são amplamente documentados na literatura, como destacado por Hodges *et al.* (2020), que diferenciam o ensino remoto emergencial do ensino online estruturado, enfatizando as lacunas tecnológicas e de suporte em contextos de crise.

Relatos dos participantes refletem essa realidade. A **Docente 14 (M, 31-40 anos)** descreveu: "*Trabalho durante a pandemia, dificuldade de acesso dos estudantes aos acessos virtuais.*" Essa fala evidencia as barreiras enfrentadas não apenas pelos professores, mas

também pelos estudantes, agravando o estresse dos docentes ao tentarem garantir a continuidade do ensino em condições adversas. De forma semelhante, a **Docente 24 (F, 21-30 anos)** relatou: *"Elaboração de aulas durante o final da pandemia,"* destacando a carga adicional de trabalho associada à adaptação pedagógica às plataformas digitais.

Além disso, os desafios tecnológicos muitas vezes se somaram a outros fatores de pressão, como a necessidade de equilibrar responsabilidades profissionais e pessoais. A **Docente 60 (F, 31-40 anos)** afirmou: *"Trabalho em sala de aula e projetos financiados ao mesmo tempo,"* ilustrando o acúmulo de demandas durante o período de ensino remoto. Essas experiências reforçam o argumento de Holmes *et al.* (2020), que apontam para o aumento do esgotamento emocional entre os profissionais de educação devido à sobrecarga de trabalho e à incerteza durante a pandemia.

A falta de suporte técnico e institucional foi outro ponto amplamente mencionado. A **Docente 27 (F, 41-50 anos)** declarou: *"Sobrecarga de trabalho,"* enquanto a **Docente 54 (F, 21-30 anos)** mencionou: *"Carga horária grande."* Esses relatos são consistentes com os achados de Galanti *et al.* (2021), que identificaram que a ausência de suporte técnico adequado e a pressão para manter altos padrões de desempenho aumentaram os níveis de estresse entre os educadores.

A autonomia e o suporte técnico são fatores fundamentais para o bem-estar no ambiente de trabalho (Deci; Ryan, 1985). No contexto do ensino remoto, a ausência desses elementos agravou a sensação de desamparo e impotência entre os docentes, que enfrentaram dificuldades para adaptar suas metodologias de ensino às ferramentas digitais e para atender às necessidades dos estudantes em um ambiente virtual.

Portanto, os desafios tecnológicos enfrentados pelos docentes durante a transição para o ensino remoto evidenciam a necessidade de investimentos em infraestrutura digital e suporte técnico por parte das instituições de ensino. Além disso, é crucial que sejam implementadas políticas de capacitação contínua para preparar os professores para o uso eficiente das tecnologias educacionais. A criação de redes de suporte técnico e emocional, aliada a estratégias institucionais que promovam a redução da sobrecarga de trabalho, pode contribuir significativamente para melhorar a experiência dos docentes no ensino remoto e fortalecer sua resiliência frente a futuras crises.

10 DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS

A análise conjunta dos dados qualitativos e quantitativos desta pesquisa destaca a complexa relação entre *coping* espiritual, síndrome de *Burnout* e qualidade de vida entre docentes de enfermagem. Os desafios enfrentados no ambiente de trabalho, somados às adversidades exacerbadas pela pandemia, evidenciaram a importância das práticas espirituais como estratégia de enfrentamento, com implicações diretas na saúde mental e no bem-estar geral dos docentes.

Os dados qualitativos revelaram que práticas como oração, meditação e busca por conforto espiritual foram frequentemente utilizadas pelos participantes como mecanismos de enfrentamento. Essas práticas ajudaram os docentes a lidar com as pressões intensas do trabalho, como destacado no relato de um participante: "*Confiei em Deus e senti que Ele me deu forças para continuar*". Este tipo de *coping* espiritual é amplamente reconhecido na literatura como uma forma eficaz de reduzir o impacto emocional de situações adversas, promovendo um senso de significado e propósito (Pargament *et al.*, 1998). No entanto, a ausência de práticas espirituais ou de conforto espiritual, conforme relatado por alguns docentes, foi associada a uma maior vulnerabilidade emocional, incluindo sofrimento causado pela preocupação com ideias de tentativas e eventos suicidas, reforçando a importância de redes de apoio e suporte espiritual.

No âmbito quantitativo, a limitada interação entre os gêneros masculino e feminino no contexto docente foi um aspecto observado. Essa constatação, baseada em experiência profissional, sugere uma correlação com a reduzida proporção de docentes do sexo masculino no ensino, diferentemente do que se verifica na prática assistencial. No entanto, a relevância dessa questão, particularmente no que concerne à participação de profissionais do sexo masculino e à historicidade do gênero, justificou um aprofundamento em seção específica para uma análise abrangente do fenômeno.

Apesar dos desafios relacionados às dinâmicas de gênero na docência, um fator protetivo significativo para o bem-estar dos profissionais foi identificado. Os resultados corroboram a relação entre altos níveis de *coping* espiritual e menores índices de *Burnout*. Conforme observado, docentes que relataram maior envolvimento em práticas espirituais apresentaram menor exaustão emocional e despersonalização, dimensões centrais do *Burnout*, além de uma percepção significativamente melhor de sua qualidade de vida, particularmente nas dimensões psicológica e social. Essa relação é consistente com os achados de estudos

anteriores, como os de Koenig (2020) e Moreira-Almeida (2006), que apontam a espiritualidade como um fator de proteção contra estressores ocupacionais.

A qualidade de vida, medida em múltiplas dimensões, apresentou uma relação inversa com o *Burnout* nos resultados quantitativos. Docentes com maiores níveis de *Burnout* relataram pior qualidade de vida, especialmente em aspectos psicológicos e de relações interpessoais. Essa deterioração é consistente com a literatura, que aponta que o esgotamento emocional, típico da síndrome de *Burnout*, impacta negativamente a capacidade de engajamento social e a percepção de bem-estar (Maslach; Leiter, 2016). Entretanto, o *coping* espiritual emergiu como uma variável moderadora nesta relação, mitigando os efeitos negativos do *Burnout* e promovendo resiliência emocional. Esse achado reflete o potencial das práticas espirituais não apenas para aliviar o estresse, mas também para proporcionar uma perspectiva mais positiva em situações adversas.

Os achados qualitativos reforçam essa interação ao destacar como o coping espiritual foi utilizado para lidar com desafios específicos no ambiente de trabalho. Por exemplo, um docente relatou: "*Orei pelo propósito de vida e encontrei forças para continuar, mesmo quando o trabalho parecia insuportável.*" Este depoimento evidencia a conexão entre a espiritualidade e a capacidade de resiliência frente às demandas emocionais intensas, conforme destacado por Sonnentag e Fritz (2015), que enfatizam a importância de práticas restauradoras para reduzir o impacto do estresse crônico.

Outro aspecto relevante abordado tanto qualitativa quanto quantitativamente é o papel do suporte social no enfrentamento do *Burnout*. Participantes que relataram envolvimento em comunidades religiosas ou grupos espirituais demonstraram maior capacidade de lidar com as adversidades, alinhando-se à literatura que associa redes de apoio a menores níveis de estresse e *Burnout* (Moreira-Almeida, 2006; Pargament *et al.*, 1998). Este suporte foi especialmente importante no contexto da pandemia, quando o isolamento social limitou as interações presenciais, exacerbando sentimentos de solidão e desconexão.

Ademais, os desafios tecnológicos e as dificuldades na transição para o ensino remoto, frequentemente mencionados nos dados qualitativos, também impactaram negativamente a saúde mental dos docentes. Essas dificuldades foram amplamente discutidas em estudos recentes de Kniffin *et al.*, (2021) e de Holmes *et al.*, (2020), os quais destacam como a sobrecarga de trabalho e a falta de suporte técnico podem amplificar os níveis de estresse e *Burnout*. O *coping* espiritual, nesse contexto, serviu como uma ferramenta essencial para ajudar os docentes a lidar com essas demandas adicionais, proporcionando um senso de controle e calma em meio ao caos.

Os relatos de docentes também evidenciaram como ambientes de trabalho tóxicos, caracterizados por assédio moral, conflitos interpessoais e falta de apoio social, exacerbam o esgotamento emocional e comprometem a qualidade de vida. No entanto, práticas espirituais foram descritas como uma forma de atenuar o impacto dessas experiências negativas, reforçando sua relevância como estratégia de enfrentamento.

Adicionalmente, os relatos qualitativos trouxeram à tona casos de extremo sofrimento emocional entre os docentes, com menções a pensamentos de desistência da profissão e, em situações mais graves, à ideação em tentativas de eventos suicidas. Essa realidade reflete o impacto profundo do *Burnout* e a urgência de intervenções eficazes para lidar com as consequências psicológicas dessa síndrome. A literatura reforça que a espiritualidade pode atuar como um fator protetor em situações de crise, proporcionando esperança e um senso de propósito, mesmo diante de adversidades extremas (Koenig *et al.*, 2012; Moreira-Almeida *et al.*, 2006). Contudo, é essencial que práticas espirituais sejam complementadas por estratégias institucionais de suporte, como políticas de saúde mental e ambientes de trabalho mais acolhedores, para prevenir desfechos mais graves.

A integração desses achados destaca a necessidade de políticas institucionais que incorporem práticas espirituais e suporte emocional no ambiente de trabalho, particularmente no contexto educacional e de saúde. Programas de bem-estar que promovam momentos de reflexão, meditação e atividades espirituais podem contribuir significativamente para a redução do *Burnout* e a melhoria da qualidade de vida dos docentes. Além disso, a criação de redes de apoio comunitário, como grupos de discussão e espaços para compartilhar experiências, pode fortalecer o senso de pertencimento e resiliência emocional entre os profissionais.

Finalmente, este estudo enfatiza que o *coping* espiritual deve ser considerado como um componente essencial em estratégias de promoção de saúde mental. Sua integração em programas institucionais pode não apenas aliviar os efeitos negativos do *Burnout*, mas também criar uma cultura organizacional mais saudável e acolhedora, capaz de promover o bem-estar psicológico e social de seus colaboradores.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo explorou de forma integrada as dimensões do *coping* espiritual, da síndrome de *Burnout* e a qualidade de vida entre docentes de Enfermagem, combinando análises qualitativas e quantitativas para oferecer uma visão abrangente sobre os desafios enfrentados por esses profissionais. Os resultados destacaram a complexidade das interações entre fatores emocionais, espirituais e ocupacionais, apontando tanto para os fatores de risco quanto para os mecanismos de proteção no enfrentamento das adversidades.

A análise qualitativa revelou relatos contundentes de sobrecarga de trabalho, ambientes de trabalho tóxicos e falta de controle e autonomia, associados a altos níveis de estresse e esgotamento emocional. Ao mesmo tempo, práticas espirituais emergiram como estratégias centrais de enfrentamento, proporcionando um alívio emocional significativo e promovendo a resiliência em momentos de crise. Esses achados foram corroborados pelos resultados quantitativos, que demonstraram a relação inversa entre o *coping* espiritual e os níveis de *Burnout*, bem como sua influência positiva na qualidade de vida.

Os desafios tecnológicos enfrentados durante a transição para o ensino remoto, amplificados pela pandemia de COVID-19, também foram um tema recorrente, evidenciando a necessidade de suporte técnico e emocional mais robusto. Neste contexto, a espiritualidade se destacou como um fator protetor, ajudando os docentes a encontrar significado e equilíbrio mesmo em circunstâncias desafiadoras.

Essa complexidade se manifesta diretamente na Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), que, conforme discutido, é um conceito multidimensional afetado por aspectos físicos, psicológicos e sociais. A dualidade do trabalho docente de Enfermagem – em que a satisfação em ensinar contrasta com a sobrecarga de trabalho e a remuneração inadequada – intensifica a percepção de desgaste e a incidência de "fadiga imprópria". Os achados deste estudo demonstram que uma QVT sustentável depende da mitigação de fatores higiênicos negativos (como o ambiente tóxico e a falta de recursos) e do fortalecimento de fatores motivacionais (como o reconhecimento e a autonomia).

A sobrecarga de trabalho e a dificuldade em conciliar responsabilidades escolares e domésticas, por exemplo, não afetam os docentes de forma neutra, mas são exacerbadas pelas normas sociais e culturais de gênero que historicamente impõem maior responsabilidade de cuidado e desempenho multitarefas às mulheres (maioria na docência de Enfermagem). A análise de gênero, portanto, é uma ferramenta fundamental para desvendar como as

desigualdades influenciam a saúde mental e o bem-estar no cotidiano laboral, demandando a desconstrução desses padrões para a criação de ambientes mais justos e equitativos.

Ao integrar os achados qualitativos e quantitativos, este estudo reforça a importância de estratégias institucionais voltadas à promoção de um ambiente de trabalho mais saudável. É essencial que gestores educacionais e de saúde reconheçam os impactos do *Burnout* e implementem políticas que valorizem o suporte emocional e espiritual. Tais ações incluem a criação de programas que incentivem a reflexão, a meditação e outras práticas restauradoras, além de promover uma cultura organizacional de apoio e reconhecimento.

Ademais, este estudo contribui para a literatura ao destacar a relevância do *coping* espiritual como ferramenta não apenas para lidar com estressores ocupacionais, mas também para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar psicológico e social. Essa abordagem integrada pode servir de base para intervenções futuras, com foco em estratégias personalizadas que atendam às necessidades específicas de profissionais que enfrentam desafios emocionais e ocupacionais semelhantes.

Por fim, as limitações desta pesquisa devem ser reconhecidas, incluindo o recorte populacional e a metodologia utilizada, que podem restringir a generalização dos achados. Contudo, os resultados oferecem insights valiosos e abrem caminhos para estudos futuros que aprofundem as interações entre espiritualidade, saúde mental e desempenho ocupacional, contribuindo para o desenvolvimento de intervenções mais eficazes no contexto educacional e de saúde.

REFERÊNCIAS

- ALVARADO-GARCÍA, Alejandra. Espiritualidad en el cuidado de enfermería. **Aquichan**, Chía, v. 4, n. 4, p. 1-13, 2004. Disponível em: www.unifil.br. Acesso em: 11 abr. 2025.
- ACKLEY, Betty J.; LADWIG, Gail B. **Manual de diagnóstico de enfermagem**: um guia para planejamento de cuidados. 7. ed. Tradução: R. S. S. McCarthy. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
- ALENCAR, C. G. A decolonização do poder, do ser e do saber através das práticas integrativas e complementares. In: CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, 25., 2023, João Pessoa, **Anais do 25. Congresso Brasileiro dos conselhos de Enfermagem**, Brasília, DF: COFEN, 2023. Disponível em: <http://biblioteca.cofen.gov.br>. Acesso em: 10 mar. 2025.
- ALLIGOOD, M. R.; TOMEY, A. M. Introdução à teoria de enfermagem: história, terminologia e análise. In: ALLIGOOD, M. R.; TOMEY, A. M. (org.) **Teoria de enfermagem e a sua obra**: modelos e teorias de enfermagem. 5. ed. Loures: Lusociência, 2004. p. 3-14.
- ALMEIDA, Ana Rita Rios *et al.* A importância da espiritualidade e da religiosidade na prática dos cuidados paliativos. **Tempus**: actas de saúde coletiva, Brasília, DF, v. 14, n. 4, p. 27-45, 2020. Disponível em: doi.org. Acesso em: 2 mar. 2025.
- ALVAREZ, E.; FERNANDEZ, L. El síndrome de Burnout o el desgaste profesional (I): revisión de estudios. **Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatria**. La Coruña, v. 11, n. 39, p. 257-65, 1991.
- AMARO, Elisangela de Assis; PIMENTA, Sheron Hellen da Silva; RODRIGUES, Leiner Resende. A compreensão da espiritualidade, religião e religiosidade frente aos enfrentamentos de pessoas vivendo com HIV. **Contribuciones a las ciencias sociales**, São José dos Pinhais, v.16, n.11, p. 29061-29088, 2023.
- ANANDARAJAH, G.; HIGHT, E. Spirituality and medical practice: using the HOPE questions as a practical tool for spiritual assessment. **American Family Physician**, [s. l.], v. 63, n. 1, p. 81-89, 2001.
- ANDO, Michiyo; TSUDA, Akira; MORITA, Tatsuya. Entrevistas de revisão de vida sobre o bem-estar espiritual de pacientes terminais com câncer. **Supportive Care in Cancer**, [s. l.], v. 15, p. 225-231, 2007. [cited 2023 Jul 8]; 15(2): 225-31. Disponível em: <http://www.springerlink.com/content/81551572452u20nm> . Acesso em: 15 jul. 2025.
- ANDRADE, Luciana *et al.* Espiritualidade e saúde em tempos de pandemia: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, São José dos Pinhais, v. 5, n. 2, p. 5418-5439, 2022. Acesso em: 14 jul. 2025.
- ANDRADE, Giovana Frazon *et al.* Burnout syndrome and consumption of alcohol and illicit substances in university students. **Paidéia**, Ribeirão Preto, v. 31, p. e3134, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-4327e3134> . Acesso em: 20 ago. 2025.
- ANGELINI, Rossana Aparecida Vieira Maia. Burnout: a doença da alma na educação e sua prevenção. **Revista Psicopedagogia**, São Paulo, v. 28, n. 87, p. 262-272, 2011. Disponível em: pepsic.bvsalud.org. Acesso em: 7 jun. 2025.

ANO, Gene G.; VASCONCELLES, Erin B. Religious coping and psychological adjustment to stress: A meta-analysis. **Journal of clinical psychology**, [s. l.], v. 61, n. 4, p. 461-480, 2005.

ANTONOVSKY, Aaron. The salutogenic model as a theory to guide health promotion. **Health promotion international**, [s. l.], v. 11, n. 1, p. 11-18, 1996.

AQUINO, Thiago Antonio Avellar. Religião, espiritualidade e saúde: um olhar da logoterapia. **Horizonte: revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião**, Belo Horizonte, v. 19, n. 60, p. 1041-1065, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5752/p.2175-5841.2021v19n60p1041>. Acesso em: 10 ago. 2025.

ARMSTRONG, Karen. **Uma história de Deus: A busca de 4.000 anos do judaísmo, cristianismo e islamismo**. Ballantine Books, 2011.

ARNOLD, Sara *et al.* Spiritual well-being, emotional distress, and perception of health after a myocardial infarction. **Internet Journal of Advanced Nursing Practice**, [s. l.], v. 9, n. 1, 2007.

ARRIEIRA, Isabel Cristina de Oliveira *et al.* Spirituality in palliative care: experiences of an interdisciplinary team. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 52, e03312, 2018. Disponível em: doi.org. Acesso em: 5 set. 2025.

ARRIEIRA, Isabel Cristina de Oliveira; THOFEHRN, Maira Buss; PORTO, Adrize Rutz; MOURA, Pedro Márlon Martter; MARTINS, Caroline Lemos; JACONDINO, Michelle Barboza. Espiritualidade nos cuidados paliativos: experiência vivida de uma equipe interdisciplinar. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, Brasil, v. 52, p. e03312, 2018. Disponível em: <https://revistas.usp.br/reeusp/article/view/145278>. Acesso em: 15 ago. 2025.

ARRUDA CAMPOS, R. C.; OLIVEIRA, R. A. A percepção da saúde, espiritualidade, e religiosidade em enfermeiros de um hospital escola. **Revista de Ciências Médicas**, Campinas, v. 31, e224855, p. 1-10, 2022. Disponível em: periodicos.puc-campinas.edu.br. Acesso em: 6 mai. 2025.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CUIDADOS PALIATIVOS. **Formação de enfermeiros em cuidados paliativos: recomendações**. Lisboa: APCP, 2006. p. 6-23.

ASTROW, Alan B. *et al.* Is failure to meet spiritual needs associated with cancer patients' perceptions of quality of care and their satisfaction with care?. **Journal of Clinical Oncology**, v. 25, n. 36, p. 5753-5757, 2007.

ASTROW, Alan B.; PUCHALSKI, Christina M.; SULMASY, Daniel P. Religion, spirituality, and health care: social, ethical, and practical considerations. **American Journal of Medicine**, [s. l.], v. 110, n. 4, 2001. Disponível em: <http://online.sagepub.com>. Acesso em: 24 ago. 2025.

BALDACCHINO, Donia R. Nursing competencies for spiritual care. **Journal of Clinical Nursing**, [s. l.], v. 15, n. 7, p. 885-896, 2006.

BALDACCHINO, Donia R. Spiritual care: is it the nurse's role?. **Spirituality and Health International**, [s. l.], v. 9, n. 4, p. 270-284, 2008.

BALDACCHINO, Donia; DRAPER, Peter. Spiritual coping strategies: a review of the nursing research literature. **Journal of Advanced Nursing**, [s. l.], v. 34, n. 6, p. 833-841, 2001.

BALBONI, Michael J. *et al.* “It depends”: viewpoints of patients, physicians, and nurses on patient-practitioner prayer in the setting of advanced cancer. **Journal of Pain and Symptom Management**, [s. l.], v. 41, n. 5, p. 836-847, May 2011.

BALBONI, Michael J. *et al.* Why is spiritual care infrequent at the end of life? Spiritual care perceptions among patients, nurses, and physicians and the role of training. **Journal of Clinical Oncology**, [s. l.], v. 31, n. 4, p. 461-467, 2013.

BALBONI, T. A. *et al.* Religiousness and spiritual support among advanced cancer patients and associations with end-of-life treatment preferences and quality of life. **Journal of Clinical Oncology**, [s. l.], v. 28, n. 4, p. 445-453, 2010.

BALBONI, Tracy A. *et al.* Religiousness and spiritual support among advanced cancer patients and associations with end-of-life treatment preferences and quality of life. **Journal of Clinical Oncology**, [s. l.], v. 25, n. 5, p. 555-560, 2007.

BALBONI, Tracy *et al.* Support of cancer patients’ spiritual needs and associations with medical care costs at the end of life. **Cancer**, [s. l.], v. 117, n. 23, p. 5383-5391, 2011.

BALDWIN, Carol M. *et al.* Influence of intestinal stoma on spiritual quality of life of US veterans. **Journal of Holistic Nursing**, [s. l.], v. 26, n. 3, p. 185-194, 2008.

BALLARIN, Maria Luisa Gazabim Simões *et al.* Espiritualidade e saúde no contexto da Terapia Ocupacional. **Revista de Ciências Médicas**, Campinas, v. 25, n. 3, p. 135-144, 2016. Disponível em: periodicos.puc-campinas.edu.br. Acesso em: 25 ago. 2025.

BARBOZA, J. I.; BERESIN, R. Síndrome de Burnout em enfermeiros. **Einstein**, São Paulo, v. 5, n. 3, p. 225-229, 2007.

BEERY, Theresa A. *et al.* Espiritualidade em pessoas com insuficiência cardíaca. **Journal of Holistic Nursing**, [s. l.], v. 20, n. 1, p. 5-25, 2002.

BENNER, Patrícia. **De iniciado a perito: excelência e poder na prática clínica de enfermagem**. 2. ed. Coimbra: Quarteto, 2005.

BERLIN, Isaiah. **The roots of romanticism**. Princeton: Princeton University Press, 1999.

BERMEJO J. **A Relação de ajuda no encontro com os idosos: testemunhos, reflexões e propostas**. Lisboa: Edições Paulinas, 2010.

BÍBLIA. N. T. Hebreus. In: BÍBLIA. **Bíblia sagrada**. Tradução de Difusora Bíblica. Lisboa: Difusora Bíblica, 1995. Disponível em: <http://www.paroquias.org>. Acesso em: 5 set. 2025.

BJARNASON, Dana. Análise conceitual de religiosidade. **Home Health Care Management & Practice**, [s. l.], v. 19, n. 5, p. 350-355, 2007.

BOFF, L. **Saber cuidar: ética do humano - compaixão pela terra**. Petrópolis: Vozes, 1999.

BOFF, Leonardo. **O Senhor é meu pastor: esperança e libertação na prática da fé**. Petrópolis: Vozes, 2006.

BOFF, Leonardo. **Cuidar da casa comum: pistas para protelar o fim do mundo**. Vozes, 2024.

BOFF, Leonardo. **Espiritualidade: um caminho de transformação**. Rio de Janeiro: Sextante, 2001.

BORGES, Diego Carter *et al.* Saúde, espiritualidade e religiosidade na visão dos estudantes de medicina. **Revista Brasileira de Clínica Médica**, São Paulo, v. 11, n. 1, p. 6-11, 2013.

BOSWELL, Gracie EH; BOSWELL-FORD, Kirstin C. Testando um modelo SEM de dois conceitos religiosos e espiritualidade experiencial. **Journal of Religion and Health**, [s. l.], v. 49, p. 200-211, 2010.

BOURDIEU, Pierre. **A dominação masculina: a condição feminina e a violência simbólica**. 19. ed. Tradução: Maria Helena Kühner. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de Ação **Estratégica de Combate a Doenças Crônicas e Doenças Não Transmissíveis no Brasil, 2021-2023**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)**: TabNet. Brasília, DF: DATASUS, 2023. Disponível em: tabnet.datasus.gov.br. Acesso em: 5 mar. 2026.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social. **I Levantamento Nacional sobre o Uso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas entre Universitários das 27 Capitais Brasileiras**. Brasília: SENAD, 2010. Disponível em: www.mds.gov.br. Acesso em: 23 fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Boletim Epidemiológico Especial: Doença pelo Coronavírus COVID-19**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: portalarquivos2.saude.gov.br. Acesso em: 22 abr. 2021.

BRASIL. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. **I levantamento nacional sobre o uso de álcool, tabaco e outras drogas entre universitários das 27 capitais brasileiras**. Organizadores: Arthur Guerra de Andrade et al. Brasília, DF: SENAD, 2010. 284 p.

BRASIL. **Lei nº 13.776**, de 20 de dezembro de 2018.

BRITO M. J. Fé filosófica. In: **LOGOS**, Enciclopédia Luso Brasileira de Filosofia. Lisboa: Verbo, 1990, v.2, p. 459-463.

BROWN V. M. Modelo del sistema comportamental. In: TOMEY, A. M.; ALLIGOOD, M. R. **Teóricas de enfermería y su obra**. Modelos y teorías de enfermería. 7. ed. Madrid: Elsevier; p. 279-300, 2010.

BURCKHARDT L, Hogan N. An experiential theory of spiritual care in nursing practice. **Qualitative Health Research**, [s. l.], v. 18, n. 7, p. 928-938, 2008.

BÜSSING, Arndt; BALZAT, Hans-Joachim; HEUSSER, Peter. Spiritual needs of patients with chronic pain diseases and cancer-validation of the spiritual needs questionnaire. **European Journal of Medical Research**, [s. l.], v. 15, p. 266-273, 2010.

BÜSSING, Arndt; OSTERMANN, Thomas; MATTHIESSEN, Peter F. Search for meaningful support and the meaning of illness in German cancer patients. **Anticancer Research**, v. 25, n. 2B, p. 1449-1455, 2005.

BUTLER, Judith. **Quadros de guerra**: quando a vida é passível de luto? 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.

CAETANO, Luciana Maria *et al.* A saúde mental dos professores: a espiritualidade como estratégia protetiva em tempos de pandemia. **Saúde e Pesquisa**, Maringá, v. 15, n. 2, e10457, 2022. Disponível em: periodicos.unicesumar.edu.br. Acesso em: 20 jul. 2025.

CAIRES, Elon. Saúde - Uma Relação Fundamental: Religião, Espiritualidade e Saúde. **Unitas**, Revista Eletrônica de Teologia e Ciências Das Religiões, Vitória, v.4, n. 2, 2016. Disponível em: <https://revista.unida.br>. Acesso em: 16 ago. 2025.

CALDEIRA, S.; CASTELO BRANCO, Z.; VIEIRA, M. A espiritualidade nos cuidados de enfermagem: revisão da divulgação científica em Portugal. **Revista de Enfermagem Referência**, Coimbra, série 3, n. 3, p. 145-152, 2011.

CAMPBELL, Heidi A. (ed.). **Digital religion**: understanding religious practice in digital media. London: Routledge, 2013.

CARRETTE, Jeremy. King, Richard. **Selling Spirituality**: The Silent Takeover of Religion. London: Routledge, 2005.

CASALETTI, Camilla *et al.* Espiritualidade, saúde e suas aplicações práticas: desenvolvimento do Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade. **HU Revista**, Juiz de Fora, v. 44 n. 4, 507–514, 2018. Disponível em: periodicos.ufjf.br. Acesso em: 14 ago. 2025.

CASTELO BRANCO, M. Z.; BRITO, D.; LONGARITO, C. Necessidades espirituais da pessoa doente hospitalizada: revisão integrativa. **Católica Saúde**, Porto, v. 4, n. 1, p. 100-108, 2015. Disponível em: revistas.ucp.pt. Acesso em: 12 ago. 2025.

CAVALCANTI, Fernanda Pinheiro. Ciências das Religiões no campo da espiritualidade e saúde. **Revista Encontros Teológicos**, Florianópolis, v. 32, n. 3, 2017. Disponível em: facasc.emnuvens.com.br. Acesso em: 11 set. 2025.

CAVER, C.S.; SCHEIER, M. F. Situational coping and coping dispositions in a stressful transaction. **Journal of Personality and Social Psychology**, [s. l.], v. 66, n. 1 p. 184-195, 1994.

CHAVES, F. S. Religião, religiosidade ou espiritualidade? A importância da definição dos termos no contexto de saúde física e psíquica. **Humanas Sociais & Aplicadas**, Curitiba, v. 5, n. 14, 2015. Disponível em: uninter.emnuvens.com.br. Acesso em: 12 set. 2025.

CHIDA, Yoichi; STEPTOE, Andrew; POWELL, Lynda H. Religiosidade/espiritualidade e mortalidade: uma revisão quantitativa sistemática. **Psychotherapy and psychosomatics**, [s. l.], v. 78, n. 2, p. 81-90, 2009.

CLARK, Paul Alexander; DRAIN, Maxwell; MALONE, Mary P. Abordando as necessidades emocionais e espirituais dos pacientes. **The Joint Commission Journal on Quality and Safety**, [s. l.], v. 29, n. 12, p. 659-670, 2003.

COELHO, E. A. C. **Enfermeiras que cuidam de mulheres**: conhecendo a prática sob o olhar de gênero. 2001. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.

COELHO, Humberto Schubert. As duas alternativas da pesquisa em espiritualidade e saúde. **Horizonte: revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião**, Belo Horizonte, v. 19, n. 60, p. 5, 2021.

COLLIÈRE, Marie-Françoise; VENTURA, Sílvia. **Cuidar... a primeira arte da vida**. Lisboa: Lusodidacta; 2003.

CONDE, Simone Regina Souza *et al.* Religiosidade e espiritualidade dos residentes de medicina e impactos na sua saúde mental. **Seven Editora**, [s. l.], p. 1212–1219, 2023. Disponível em: <https://sevenpubl.com.br/editora/article/view/1520>. Acesso em: 5 ago. 2025.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Resolução COFEN nº 564/2017**. Aprova o novo Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Brasília, DF: COFEN, 2017. Disponível em: www.cofen.gov.br. Acesso em: 22 abr. 2025.

CORRÊA, C. V. *Coping religioso/espiritual (CRE): revisão da produção em periódicos brasileiros e a sua utilização em profissionais da atenção à saúde mental do litoral do Paraná*. Dissertação de Mestrado em Psicologia defendida na Universidade Federal do Paraná, (2014).

COSTA, Milena Silva *et al.* Spirituality and religiosity: knowledge of medical students. **Revista Bioética**, Brasília, DF, v. 27, n. 2, p. 350-358, 2019. Disponível em: [doi.org](https://doi.org/10.1590/1981-2317190003). Acesso em: 6 mar. 2025.

COUTO, J. M. *et al.* A Influência da Espiritualidade na Saúde Mental de Jovens e Adultos: uma Revisão Sistemática. **Revista PsicoFAE: Pluralidades em Saúde Mental**, Curitiba, v. 12, n. 1, p. 52-64, 2023. Disponível em: <https://revistapsicofae.fae.edu>. Acesso em: 6 ago. 2025.

CREEL, E.; TILLMAN, K. Meaning of spirituality among nonreligious persons with chronic illness [O significado da espiritualidade entre pessoas não religiosas com doenças crônicas]. **Holistic Nursing Practice**, [s. l.], v. 22, n. 6, p. 303-309, 2008. Disponível em: [doi.org](https://doi.org/10.1177/0898010108315555). Acesso em: 10 ago. 2025.

CROSBY, Alex E.; SACKS, Jeffrey J. Exposure to suicide: Incidence and association with suicidal ideation and behavior: United States, 1994. **Suicide and Life-Threatening Behavior**, v. 32, n. 3, p. 321-328, 2002.

CUNHA, Vivian Fukumasu da; SCORSOLINI-COMIN, Fabio. The Religiousness/Spirituality Dimension in Clinical Practice: An Integrative Review of the Scientific Literature. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, Brasília, DF, v. 35, e35419, 2019. Disponível em: [doi.org](https://doi.org/10.1191/0033290906pr0001a). Acesso em: 6 ago. 2025.

CURTIS, J. R.; PATRICK, D. L. The assessment of health status among patients with COPD [A avaliação do estado de saúde entre pacientes com DPOC]. **European Respiratory Journal**, [s. l.], v. 21, supl. 41, p. 36s-45s, 2003. Disponível em: [doi.org](https://doi.org/10.1183/0954679303000041036s). Acesso em: 6 ago. 2025.

DA PAZ, Ayana Cavalcante *et al.* Associação entre o uso de substâncias psicoativas e transtornos de ansiedade e depressão. **Brazilian Journal of Health Review**, São José dos Pinhais, v. 7, n. 2, e67726, 2024. Disponível em: [doi.org](https://doi.org/10.1590/bjhr.v7n2.20240001). Acesso em: 11 ago. 2025.

DALMOLIN, Bárbara Brezolin *et al.* Significados do conceito de saúde na perspectiva de professores da área da saúde. **Escola Anna Nery**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 2, p. 389-394, 2011. Disponível em: doi.org. Acesso em: 7 ago. 2025.

DAMASIO, Antonio R. **Descartes' error**: Emotion, reason, and the human brain. New York: G.P. Grosset/Putnam, 1994.

DECI, Edward L.; RYAN, Richard M. **Intrinsic motivation and self-determination in human behavior**. New York: Springer Science & Business Media, 2013.

DEJOURS, C. **A loucura do trabalho**: estudo de psicopatologia do trabalho. 5. ed. São Paulo: Cortez: Oboré, 1992.

DELANEY, Colleen. The spirituality scale: Development and psychometric testing of a holistic instrument to assess the human spiritual dimension. **Journal of Holistic Nursing**, [s. l.], v. 23, n. 2, p. 145-167, 2005.

DEWA, Carolyn S. *et al.* The relationship between resident burnout and safety-related and acceptability-related quality of healthcare: a systematic literature review. **BMC Medical Education**, [s. l.], v. 17, n. 1, e108, 2017. Disponível em: doi.org. Acesso em: 6 mar. 2026.

DIENER, Ed *et al.* Subjective well-being: Three decades of progress. **Psychological bulletin**, Washington, DC, v. 125, n. 2, p. 276-302, 1999. Disponível em: doi.org. Acesso em: 11 mar. 2025.

DIX, Steffen. As esferas seculares e religiosas na sociedade portuguesa. **Análise Social**, Lisboa, v. 45, n. 194, p. 5-27, 2010. Disponível em: www.jstor.org. Acesso em: 10 abr. 2025.

DOSSEY, Barbara M. Florence Nightingale's vision for health and healing [A visão de Florence Nightingale para saúde e cura]. **Journal of Holistic Nursing**, [s. l.], v. 28, n. 4, p. 221-224, 2010. Disponível em: doi.org. Acesso em: 11 mar. 2025.

DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. Tradução: Raquel Andrade Weiss. **Debates do NER**, Porto Alegre, v. 13, n. 22, p. 95-119, jul./dez. 2012. Disponível em: doi.org. Acesso em: 6 mar. 2026.

DURKHEIM, Émile. **O suicídio**: estudo de sociologia. Tradução: Mônica Stahel. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 518 p. (Clássicos).

DUROZOI Gérard, Roussel André. **Dicionário de Filosofia**. Porto: Porto Editora; 1997.

DYRBYE, Liselotte N. *et al.* Burnout and suicidal ideation among US medical students [Burnout e ideação suicida entre estudantes de medicina dos EUA]. **Annals of Internal Medicine**, [s. l.], v. 149, n. 5, p. 334-341, 2008. Disponível em: doi.org. Acesso em: 6 mar. 2026.

EDLIN, Gordon; GOLANTY, Eric. Health & wellness. In: EDLIN, Gordon; GOLANTY, Eric. **Health and wellness**. 10. ed. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers, 2010. p. 4-6.

EINARSEN, S. *et al.* The concept of bullying and harassment at work: the European tradition. In: EINARSEN, S. *et al.* (ed.). **Bullying and harassment in the workplace: developments in theory, research, and practice**. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2011. p. 3-40.

ELIADE, Mircea. **Shamanism: archaic techniques of ecstasy**. Translated by Willard R. Trask. Princeton: Princeton University Press, 2024. 648 p. (Bollingen Series, LXXVI).

ELIADE, Mircea. **O sagrado e o profano: a essência das religiões**. Tradução: Rogério Fernandes. Martins Fontes, 1992. 187 p. (Tópicos).

ELIAS, M. A.; NAVARRO, V. L. A relação entre o trabalho, a saúde e as condições de vida: negatividade e positividade no trabalho das profissionais de enfermagem de um hospital escola. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 14, n. 4, p. 517-525, jul./ago. 2006. Disponível em: doi.org. Acesso em: 11 mar. 2025.

ELKINS, David N. *et al.* Toward a humanistic-phenomenological spirituality: definition, description, and measurement. **Journal of Humanistic Psychology**, [s. l.], v. 28, n. 4, p. 5-18, 1988. Disponível em: doi.org. Acesso em: 13 abr. 2025.

EMBLEM, Julia; PESUT, Barbara. Strengthening transcendent meaning: A model for the spiritual nursing care of patients experiencing suffering. **Journal of Holistic Nursing**, [s. l.], v. 19, n. 1, p. 42-56, 2001. Disponível em: doi.org. Acesso em: 11 mar. 2025.

ESPERANDIO, Mary Rute Gomes. Teologia e a pesquisa sobre espiritualidade e saúde: um estudo piloto entre profissionais da saúde e pastoralistas. **Horizonte: revista de estudos de teologia e ciências da religião**, Belo Horizonte, v. 12, n. 35, p. 805-832, 2014. Disponível em: doi.org. Acesso em: 12 mar. 2025.

ESPERANDIO, Mary Rute Gomes. Teologia e saúde: a espiritualidade como recurso no cuidado. **Estudos Teológicos**, São Leopoldo, v. 57, n. 2, p. 278-295, jul./dez. 2017. Acesso em: 11 mar. 2024.

ESPÍRITO SANTO, Moisés. **Inter-religious dialogue: meeting of the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly (EMPA) Committee on the Promotion of the Quality of Life, Human Exchanges and Culture**. Lisboa: Assembleia da República Portuguesa, 2012. Disponível em: <http://www.empacult.parlamento.pt/ing/documentos/DCMoisesEspiritoSanto060808Lusoen>. Acesso em: 11 abr. 2025.

ESPIRITUALIDADE e bioética. Curitiba: **Uniedusul**, 2022. 216 p. Disponível em: www.uniedusul.com.br. Acesso em: 7 mar. 2025.

ESPOSITO, John L. **Islam: The Straight Path**. New York: Oxford University Press, 2005.

ESPOSITO, John L. **What everyone needs to know about Islam**. New York: Oxford University Press, 2011. Disponível em: pages.uoregon.edu. Acesso em: 15 mar. 2025.

FALCÃO, V. T. F. L. Os desafios da enfermagem no enfrentamento à Covid-19. **Revista Enfermagem Digital Cuidado e Promoção da Saúde**, Curitiba, v. 5, n. 1, p. 1-2, jan./jun. 2020. Editorial. Disponível em: www.redcps.com.br. Acesso em: 11 mai. 2025.

FARIA, Juliana Bernardes de; SEIDL, Eliane Maria Fleury. Religiosidade e enfrentamento em contextos de saúde e doença: revisão da literatura. **Psicologia: reflexão e crítica**, Porto Alegre, v. 18, n. 3, p. 381-389, 2005. Disponível em: doi.org. Acesso em: 12 abr. 2025.

FARIÑAS, G. A. *et al.* Eficiencia de la actividad de enfermería en los consultorios del médico de familia y la enfermera [Eficiência da atividade de enfermagem nos consultórios do médico de família e da enfermeira]. **Revista Cubana de Enfermería**, La Habana, v. 34, n. 2, e1440, 2018. Disponível em: revenfermeria.sld.cu. Acesso em: 11 abr. 2025.

FERNANDES, C.; MONTEIRO, C.; ALVES, J. Espiritualidade no cuidar. **Informar**: revista da Ordem dos Enfermeiros, Lisboa, n. 36, p. 10-21, 2006.

FERNANDES, Laura Ferreira *et al.* A influência da espiritualidade e da religiosidade na aceitação da doença e no tratamento de pacientes oncológicos: revisão integrativa da literatura. **Revista Brasileira de Cancerologia**, Rio de Janeiro, v. 66, n. 2, e-03914, 2020. Disponível em: rbc.inca.gov.br. Acesso em: 11 mar. 2025.

FERREIRA, Alberto Gorayeb de Carvalho *et al.* Concepções de espiritualidade e religiosidade e a prática multiprofissional em cuidados paliativos. **Kairós**: Revista da Faculdade de Ciências Humanas e Saúde, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 227-244, 2015. Disponível em: revistas.pucsp.br. Acesso em: 12 fev. 2025.

FERREIRA, P. L.; FERREIRA, L. N.; PEREIRA, L. N. Medidas sumário física e mental de estado de saúde para a população portuguesa. **Revista Portuguesa de Saúde Pública**, Lisboa, v. 30, n. 2, p. 163-171, 2012. Disponível em: doi.org. Acesso em: 10 mar. 2025.

FERREIRA, P. L.; SANTANA, A. Percepção de estado de saúde e de qualidade de vida da população ativa: contributo para a definição de normas portuguesas. **Revista Portuguesa de Saúde Pública**, Lisboa, v. 21, n. 2, p. 15-30, 2003. Disponível em: <https://www.ensp.unl.pt>. Acesso em: 12 mar. 2025.

FERREIRA, P. L. Criação da versão portuguesa do MOS SF-36: parte I – adaptação cultural e linguística portuguesa. **Acta Médica Portuguesa**, Lisboa, v. 13, n. 1-2, p. 55-66, 2000. Disponível em: <https://www.actamedicaportuguesa.com>. Acesso em: 12 abr. 2025.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Novo dicionário da língua portuguesa**. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.

FERREIRA, Elizabete Cazzolato; PEZUK, Julia Alejandra. Síndrome de Burnout: um olhar para o esgotamento profissional do docente universitário. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior**, Campinas; Sorocaba v. 26, n. 2, p. 483-502, 2021.

FERREIRA, Mariana Angelica *et al.* A segurança do paciente e os impactos da resistência bacteriana na atenção hospitalar. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, Santarém, v. 23, n. 7, p. e13462, 2023. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e13462.2023>. Disponível em: acervomais.com.br. Acesso em: 6 mar. 2026.

FERREIRA, Pedro Lopes; FERREIRA, Lara Noronha; PEREIRA, Luis Nobre. Medidas sumário física e mental de estado de saúde para a população portuguesa. **Revista Portuguesa de Saúde Pública**, v. 30, n. 2, p. 163-171, 2012.

FERREIRA, Pedro Lopes; FERREIRA, Lara Noronha; PEREIRA, Luis Nobre. Medidas sumárias física e mental de estado de saúde para a população portuguesa. **Revista Portuguesa de Saúde Pública**, Lisboa, v. 30, n. 2, p. 163-171, 2012. Disponível em: www.elsevier.pt. Acesso em: 17 abr. 2025.

FERREIRA, Thaís Da Silva *et al.* Implicações e contingências da espiritualidade e religiosidade na velhice bem-sucedida. **Estudos de religião**, São Bernardo do Campo, v. 36, n. 2, p. 101-125, 2022.

FLECK, Marcelo *et al.* Aplicação da versão em português do instrumento abreviado de avaliação da qualidade de vida "WHOQOL-bref". **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 34, n. 2, p. 178-183, abr. 2000. DOI: doi.org. Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 8 mar. 2025

FLOOD, Gavin. **An introduction to Hinduism**. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

FONSECA, Rosa Maria Godoy Serpa da. **Gênero, saúde e enfermagem**: uma abordagem epistemológica. 1998. Tese (Livre-Docência) – Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.

FOWLER, James W. Faith development at 30: Naming the challenges of faith in a new millennium. **Religious Education**, New Haven, v. 99, n. 4, p. 405-421, 2004. DOI: doi.org. Disponível em: www.tandfonline.com. Acesso em: 10 abr. 2025

FOWLER, James W. **Stages of faith**: The psychology of human development and the quest for meaning. San Francisco: Happer & Row, 1995.

FRANÇA, Thaís Lorena Barbosa de *et al.* Síndrome de Burnout: características, diagnóstico, fatores de risco e prevenção. **Revista de enfermagem UFPE on line**, v. 8, n. 10, p. 3539-3546, 2014. Recife, v. 8, n. 10, p. 3539-3546, 2014. Disponível em: doi.org. Acesso em: 7 jun. 2025.

FRANCISCO, Papa. **Carta Encíclica Laudato Si'**: sobre o cuidado da casa comum. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2015. Disponível em: http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html. Acesso em: 22 set. 2025.

FRANKL, Viktor E. **Em busca de sentido**: um psicólogo no campo de concentração. Tradução: Walter O. Schlupp e Carlos C. Aveline. 39. ed. São Paulo: Vozes, 2015. 184 p.

FRANKL, Viktor E. **Psicoterapia e sentido da vida**. São Paulo: Quadrante, 1989.

FREESE, Becky. Betty Neuman: modelo de sistemas. In: ALLIGOOD, Martha Raile. **Modelos y teorías de enfermería**. 7. ed. Barcelona: Elsevier, 2011. p. 335-376.

FREIRE, José Célio. Ética e técnica no cuidado do outro. **Revista Bioética**, Brasília, v. 27, n. 2, p. 231-239, 2019. Acesso em: 12 mar. 2025.

FREIRE, José Célio. A psicologia a serviço do outro: ética e cidadania na prática psicológica. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília, v. 23, n. 4, p. 12-15, 2003. DOI: doi.org. Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 17 mar. 2025.

FREIRE, J. C. **O lugar do outro na modernidade tardia**. São Paulo: Anablume, 2002.

FREITAS, Marta Helena de. Apresentação do dossiê: espiritualidade e saúde. **Interações: Cultura e Comunidade**, Belo Horizonte, v. 11, n. 20, p. 3-8, 2016. Disponível em: periodicos.pucminas.br. Acesso em: 11 fev. 2025.

FREUDENBERG, H.J. Staff Burn-Out. **Journal of Social Issues**, [s. l.], v. 30, n. 1, p. 159 – 165, 1974. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x> . Acesso em: 15 abr. 2025.

FREUDENBERGER, Herbert J. The staff burn-out syndrome in alternative institutions. **Psychotherapy: Theory, Research & Practice**, Chicago, v. 12, n. 1, p. 73-82, 1975. DOI: doi.org. Disponível em: psycnet.apa.org. Acesso em: 6 mar. 2026

FRIEDMANN, Georges; NAVILLE, Pierre. Introduction et méthodologie. In: FRIEDMANN, Georges; NAVILLE, Pierre (org.). **Traité de sociologie du travail**. Paris: Armand Colin, 1962. v. 1, p. 11-64.

FUENTES, Vivian Marina *et al.* Avaliação da qualidade de vida e religiosidade/espiritualidade em mulheres após câncer de mama: estudo transversal. **RECIMA21: Revista Científica Multidisciplinar**, São Paulo, v. 4, n. 8, p. e483604, 2023. DOI: doi.org. Disponível em: recima21.com.br. Acesso em: 12 mai. 2025.

FULLER, Robert C. **Spiritual, but not religious: understanding unchurched America**. Oxford: University Press, 2001.

FUNG, Yu-lan. **A short history of Chinese philosophy**. New York: Free Press, 1997. 368 p.

GALEK, Kathleen *et al.* Assessing a patient's spiritual needs: a comprehensive instrument. **Holistic Nursing Practice**, Philadelphia, v. 19, n. 2, p. 62-69, 2005. DOI: doi.org. Disponível em: journals.lww.com. Acesso em: 7 mar. 2025.

GALVÃO, Nathalia Soares *et al.* Cuidado espiritual na prática de enfermagem oncológica ao paciente adulto. **Revista REMECS: revista multidisciplinar de estudos científicos em saúde**, São Paulo, v. 6, n. 10, p. 9-17, 2021. Disponível em: revistaremeccs.com.br. Acesso em: 2 abr. 2025.

GARCIA Pacheco Avezum, S., Figueiredo Teixeira, M. E., Menezes Couceiro, S. L., Meneses, P., & Avezum. A qualidade de vida, *Burnout* e espiritualidade. **Revista Da Sociedade de Cardiologia Do Estado de São Paulo**, São Paulo v.33(2), p. 289-293, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.29381/0103-8559/20233302289-93> . Acesso em: 21 abr. 2025.

GAY, Peter. **The Enlightenment: An Interpretation**. New York: Alfred A. Knopf, 1966. v.1, 555 p.

GERONE, Lucas Guilherme Teztlafl de. A espiritualidade no contexto da ciência da saúde. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, São Paulo, ano 5, n. 9, v. 1, p. 121-136, 2020. Disponível em: www.nucleodoconhecimento.com.br. Acesso em: 11 ago. 2024.

GERONE, Lucas Guilherme Teztlafl de. A espiritualidade no contexto da ciência da Saúde. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. Ano 5, 9. ed. v. 1, p. 121-136. 2020.

GERONE, Lucas Guilherme Teztlafl de. A espiritualidade no contexto da ciência da saúde. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, São Paulo, ano 5, n. 9, v. 1, p. 121-136, set. 2020. Disponível em: www.nucleodoconhecimento.com.br. Acesso em: 3 mai. 2025.

GERONE, Lucas Guilherme Teztlafl de. A religiosidade/espiritualidade na prática do cuidado entre profissionais da saúde. **Interações: Cultura e Comunidade**, Belo Horizonte, v. 11, n. 20, p. 129-151, 2016. Disponível em: periodicos.pucminas.br. Acesso em: 16 mar. 2025.

GETHIN, Rupert. **The foundations of Buddhism**. Oxford: Oxford University Press, 1998.

GIDDENS, Anthony. **Sociologia**. Tradução de Sandra Neves. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008. 764 p.

GILLIGAN, C. **Uma voz diferente**: psicologia da diferença entre homens e mulheres da infância à idade adulta. Rio de Janeiro, RJ: Rosa dos Tempos. 1982.

GIL-MONTE, P. R. Influencia del género sobre el proceso de desarrollo del síndrome de quemarse por el trabajo (burnout) em profesionales de enfermería. **Psicologia em Estudo**, Maringá, v. 7, n. 1, p. 3-10, 2002.

GLEISER, Ann. **American dharma**: Buddhism beyond modernity. New Haven: Yale University Press, 2019.

GOMES, Antonio Marcos Tosoli *et al.* Espiritualidade e religiosidade para mulheres Umbandistas e Candomblecistas: representação social e implicações na saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 9, p. e220335, 2023. DOI: [doi.org](https://doi.org/10.1590/1413-812320230220335). Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 20 jul. 2025.

GOMEZ, Rapson; FISHER, John W. Domains of spiritual well-being and development and validation of the Spiritual Well-Being Questionnaire. **Personality and individual differences**, v. 35, n. 8, p. 1975-1991, 2003.

GOMEZ, Rapson; FISHER, John W. Domains of spiritual well-being and development and validation of the Spiritual Well-Being Questionnaire. **Personality and Individual Differences**, Oxford, v. 35, n. 8, p. 1975-1991, 2003. DOI: [doi.org](https://doi.org/10.1016/S0191-8869(03)00111-1). Disponível em: www.sciencedirect.com. Acesso em: 17 fev. 2025.

GOMIDE, Marcia; MOREIRA-ALMEIDA, Alexander. Religiosidade/Espiritualidade na produção científica da Saúde Coletiva brasileira: panorama e perspectivas. **Research, Society and Development**, Vargem Grande Paulista, v. 11, n. 11, p. e131111133485, 2022. DOI: [doi.org](https://doi.org/10.24051/RSO.V11N11.133485). Disponível em: rsdjournal.org. Acesso em: 17 mar. 2025.

GONZALEZ-SANZ, J. D.; FERNÁNDEZ-BERROCAL, P.; PÉREZ-GONZÁLEZ, J. C. The Role of Emotional Intelligence in the Maintenance of Healthful Aging among Older Adults. **Aging and Mental Health**, Abingdon, v. 23, n. 5, p. 674-679, 2019. DOI: [doi.org](https://doi.org/10.1080/13607863.2019.1644444). Disponível em: www.tandfonline.com. Acesso em: 15 fev. 2025.

GOVIER, Ian. Spiritual care in nursing: a systematic approach. **Nursing Standard**, London, v. 14, n. 17, p. 32-36, 2000. DOI: doi.org. Disponível em: journals.rcni.com. Acesso em: 6 mai. 2025.

GRANT, Elizabeth *et al.* Spiritual issues and needs: perspectives from patients with advanced cancer and nonmalignant disease. A qualitative study. **Palliative & Supportive Care**, New York, v. 2, n. 4, p. 371-378, 2004. DOI: doi.org. Disponível em: www.cambridge.org. Acesso em: 15 jan. 2025.

GRIFFIN, Mary T. Quinn *et al.* Spirituality and well being among elders: differences between elders with heart failure and those without heart failure. **Clinical interventions in aging**, Auckland, v. 2, n. 4, p. 669-675, 2007. DOI: doi.org. Disponível em: www.ncbi.nlm.nih.gov. Acesso em: 17 abr. 2025.

HAMDAN, Sami; PETERSEIL-YAUL, Temima. Exploring the psychiatric and social risk factors contributing to suicidal behaviors in religious young adults. **Psychiatry Research**, Oxford, v. 287, p. 112449, 2020. DOI: doi.org. Disponível em: www.sciencedirect.com. Acesso em: 10 mar. 2025.

HAMPTON, Diane M. *et al.* Spiritual needs of persons with advanced cancer. **American Journal of Hospice and Palliative Medicine**, Thousand Oaks, v. 24, n. 1, p. 42-48, 2007. Disponível em: journals.sagepub.com. Acesso em: 15 abr. 2025.

HANEGRAAFF, Wouter J. **New Age religion and Western culture: esotericism in the mirror of secular thought**. Leiden: E. J. Brill, 1998.

HARRAD, Rachael; RICKETTS, Tom; BOARD, Mary. Spirituality and the nurse's role: a systematic review. **Journal of Clinical Nursing**, [s. l.], v. 32, n. 15-16, p. 4443-4458, 2023. Disponível em: doi.org. Acesso em: 15 ago. 2025.

HARRIS, Alex H. S.; THORESEN, Carl E.; MCCULLOUGH, Michael E.; LARSON, David B. Spirituality and religion: the role of spirituality and religion in mental and physical health. **Current Directions in Psychological Science**, Thousand Oaks, v. 17, n. 3, p. 183-187, jun. 2008. DOI: doi.org. Acesso em: 12 mai. 2025.

HARRIS, Alex H. S.; THORESEN, Carl E.; MCCULLOUGH, Michael E.; LARSON, David B. Spirituality and religion: the role of spirituality and religion in mental and physical health. **Current Directions in Psychological Science**, Thousand Oaks, v. 17, n. 3, p. 183-187, 2008. DOI: doi.org. Disponível em: journals.sagepub.com. Acesso em: 21 jun. 2025.

HARRISON, Robert. Pathways to spirituality: connection, wholeness, and possibility for those in recovery from mental illness. **Journal of Spirituality in Mental Health**, Philadelphia, v. 19, n. 3, p. 187-199, 2017. DOI: doi.org. Disponível em: www.tandfonline.com. Acesso em: 11 mai. 2025.

HAWTON, Keith; SAUNDERS, Kate EA; O'CONNOR, Rory C. Self-harm and suicide in adolescents. **The Lancet**, London, v. 379, n. 9834, p. 2373-2382, 2012. Disponível em: www.thelancet.com. Acesso em: 11 jun. 2025.

HECKERT, Uriel; ZIMPEL, Rogério R. Relações entre espiritualidade/religiosidade e psiquiatria no Brasil. **HU Revista**, Juiz de Fora, v. 44, n. 4, p. 425-429, 2018. DOI: doi.org. Acesso em: 14 fev. 2025.

HECKERT, Uriel; ZIMPEL, Rogério R. Relações entre espiritualidade/religiosidade e psiquiatria no Brasil. **HU Revista**, Juiz de Fora, v. 44, n. 4, p. 425-429, 2018. Disponível em: periodicos.ufjf.br. Acesso em: 14 mar. 2025.

HEELAS, Paul. **The New Age Movement**: religion, culture and society in the Age of Postmodernity. Oxford: John Wiley & Sons, 1996. 288 p.

HODGES, S. C. et al. Spiritual care: a review of the literature. **Nursing Standard**, London, v. 19, n. 32, p. 33-39, abr. 2005. Disponível em: www.ncbi.nlm.nih.gov. Acesso em: 11 set. 2025.

HENDERSON, V. **La naturaleza de la Enfermería**: reflexiones 25 años después. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 1994.

HERMANN, Carla P. The degree to which spiritual needs of patients near the end of life are met. In: **Oncology nursing forum**, Pittsburgh, v. 34, n. 1, p. 70-78, 2007. DOI: doi.org. Disponível em: ons.org. Acesso em: 13 abr. 2025.

HERMANN, Carlo Penrod. Spiritual needs of dying patients: a qualitative study. In: **Oncology nursing forum**, Pittsburgh, v. 28, n. 1, p. 67-72, 2001. Disponível em: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Acesso em: 12 mar. 2025.

HERRERA SÁNCHEZ, Beatriz. Bienestar espiritual en personas con y sin discapacidad. **Aquichan**, Chía, v. 9, n. 1, p. 8-22, 2009. Disponível em: www.scielo.org.co. Acesso em: 14 abr. 2025.

HILL, Peter C.; PARGAMENT, Kenneth I. Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality: implications for physical and mental health research. **American Psychologist**, Washington, DC, v. 58, n. 1, p. 64-74, 2003. DOI: doi.org. Disponível em: psycnet.apa.org. Acesso em: 12 mar. 2025.

HILL, Peter C. *et al.* Conceptualizing religion and spirituality: Points of commonality, points of departure. **Journal for the theory of social behaviour**, Oxford, v. 30, n. 1, p. 51-77, 2000. Disponível em: onlinelibrary.wiley.com. Acesso em: 13 fev. 2025.

HOBFOLL, Stevan E. Conservation of resources: a new attempt at conceptualizing stress. **American Psychologist**, Washington, DC, v. 44, n. 3, p. 513-524, 1989. DOI: doi.org. Disponível em: psycnet.apa.org. Acesso em: 11 mar. 2025.

HOLANDA, Adriano Furtado; PEREIRA, Karine Costa Lima. Religião e espiritualidade no campo da saúde: questões para a educação superior. **Paralellus**, Revista de Estudos de Religião-UNICAP, v.11, n. 28, p. 619-640, 2020.

HOLLYWELL, Claire; WALKER, Jan. Private prayer as a suitable intervention for hospitalised patients: a critical review of the literature. **Journal of Clinical Nursing**, Oxford, v. 18, n. 5, p. 637-651, 2009. Disponível em: onlinelibrary.wiley.com. Acesso em: 12 jan. 2025.

HOLMES, Emily A. *et al.* Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic: a call for action for mental health science. **The lancet psychiatry**, London, v. 7, n. 6, p. 547-560, 2020. Disponível em: www.thelancet.com. Acesso em: 21 fev. 2025.

HOUAISS, Antônio. **Dicionário Houaiss da língua portuguesa**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

HUMMER, Robert A. *et al.* Religious involvement and adult mortality in the United States: Review and perspective. **Southern medical journal**, [s. l.], v. 97, n. 12, p. 1223-1231, 2004.

HUMMER, Robert A. *et al.* Religious involvement and US adult mortality. **Demography**, [s. l.], v. 36, n. 2, p. 273-285, 1999.

INOUE, Thais Martins; VECINA, Marion Vecina Arcuri. Spirituality and/or religiosity and health: a literature review. **Journal of the Health Sciences Institute**, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 127-30, 2017.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (Portugal); INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE. **Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006**. Lisboa: INE: INSA, 2009. Disponível em: <https://www.ine.pt>. Acesso em: 6 mar. 2026.

INTERNATIONAL COUNCIL NURSES. Promoting mental health: the work of the International Council of Nurses. **Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services**, Thorofare, v. 51, n. 8, p. 3-4, 2013. DOI: doi.org. Acesso em: 13 fev. 2025.

ISLA PERA, Pilar; LÓPEZ MATHEU, Carmen; INSA SORIA, Roser. ¿Qué es la salud?. **Revista ROL de Enfermería**, Barcelona, v. 31, n. 12, p. 18-26, 2008. Disponível em: www.e-rol.es. Acesso em: 11 fev. 2025.

JARRUCHE, Layla Thamm; MUCCI, Samantha. Síndrome de burnout en profesionales sanitarios: revisión integradora. **Revista Bioética**, v. 29, p. 162-173, 2021.

JENKINS, Mary Lou et al. Nursing the spirit. **Nursing Management**, Ambler, v. 40, n. 8, p. 29-36, 2009. DOI: doi.org. Disponível em: journals.lww.com. Acesso em: 12 mar. 2025.

KANDASAMY, Arun; CHATURVEDI, S. K.; DESAI, G. Spirituality, distress, depression, anxiety, and quality of life in patients with advanced cancer. **Indian Journal of Cancer**, Mumbai, v. 48, n. 1, p. 55-59, 2011. DOI: doi.org. Disponível em: www.indianjcancer.com. Acesso em: 12 mai. 2025.

KAPUSCINSKI, Afton N.; MASTERS, Kevin S. The current status of measures of spirituality: a critical review of scale development. **Psychology of Religion and Spirituality**, Washington, DC, v. 2, n. 4, p. 191-205, 2010. Disponível em: psycnet.apa.org. Acesso em: 12 mar. 2025.

KARASEK JR, Robert A. Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. **Administrative science quarterly**, Ithaca, v. 24, n. 2, p. 285-308, 1979. Disponível em: www.jstor.org. Acesso em: 21 abr. 2025.

KARASEK JUNIOR, Robert A. Job demands, job decision latitude, and mental strain: implications for job redesign. **Administrative Science Quarterly**, Ithaca, v. 24, n. 2, p. 285-308, 1979. DOI: doi.org. Disponível em: www.jstor.org. Acesso em: 16 fev. 2025.

KARIMOLLAHI, Mansooreh; ABEDI, Heidar Ali; YOUSEFY, Alireza. Spiritual needs as experienced by Muslim patients in Iran: A qualitative study. **Annals of General Psychiatry**, London, v. 7, supl. 1, p. S147, 2008. DOI: doi.org. Disponível em: annals-general-psychiatry.biomedcentral.com. Acesso em: 12 mar. 2025.

KAUT, Kevin P. Religion, spirituality, and existentialism near the end of life: Implications for assessment and application. **American Behavioral Scientist**, v. 46, n. 2, p. 220-234, 2002.

KAUT, Kevin P. Religion, spirituality, and existentialism near the end of life: implications for assessment and application. **American Behavioral Scientist**, Thousand Oaks, v. 46, n. 2, p. 220-234, 2002. Disponível em: journals.sagepub.com. Acesso em: 12 ago. 2024.

KELCOURSE Felicity. **Human development and faith: life-cycle stages of body, mind, and soul**. St. Louis, Missouri: Chalice Press; 2004.

KING, Michael; SPECK, Peter; THOMAS, Angela. The Royal Free Interview for spiritual and religious beliefs: development and validation of a self-report version. **Psychological Medicine**, Cambridge, v. 31, n. 6, p. 1015-1023, 2001. Disponível em: www.cambridge.org. Acesso em: 12 fev. 2025.

KNITTER, Paul F. **Introducing Theologies of Religions**. Maryknoll: Orbis Books. 2002.

KOENIG, Harold G.; LARSON, David B. Religion and mental health: evidence for an association. **International Review of Psychiatry**, Abingdon, v. 13, n. 2, p. 67-78, 2001. DOI: doi.org. Disponível em: www.tandfonline.com. Acesso em: 8 mai. 2025.

KOENIG, Harold G. **Espiritualidade no cuidado com o paciente: por que, como, quando, e o quê**. Tradução: João Cabral e Rita de Cássia S. Cabral. São Paulo: Feeditora, 2005.

KOENIG, Harold G.; KING, Dana E.; CARSON, Verna Benner. **Handbook de religião e saúde**. Tradução: Geraldo José de Paiva. São Paulo: Editora Unifesp, 2012. 1104 p.

KOENIG, Harold G. Concerns about measuring "spirituality" in research. **The Journal of Nervous and Mental Disease**, Baltimore, v. 196, n. 5, p. 349-355, 2008. DOI: doi.org. Disponível em: journals.lww.com. Acesso em: 11 jan. 2025.

KOENIG, Harold G. Maintaining health and well-being by putting faith into action during the COVID-19 pandemic. **Journal of Religion and Health**, New York, v. 59, n. 5, p. 2205-2214, 2020. Disponível em: link.springer.com. Acesso em: 11 fev. 2025.

KOENIG, Harold G. The Influence of Religion on Health: A Conceptual and Research Review. **Journal of Religion and Health**, New York, v. 51, n. 2, p.338-350, 2012. Disponível em: link.springer.com. Acesso em: 11 mai. 2025.

KOENIG, Harold G.; KING, Dana E.; CARSON, Verna Benner. **Handbook de religião e saúde**. Tradução: Geraldo José de Paiva. São Paulo: Editora Unifesp, 2012. 1104 p.

KOENIG, Harold G. *et al.* Religion, spirituality, and health service use by older hospitalized patients. **Journal of Religion and Health**, New York, v. 42, p. 301-314, 2003. Disponível em: link.springer.com. Acesso em: 12 fev. 2025.

KOENIG, Harold G. *et al.* Religion, spirituality, and medicine: research findings and implications for clinical practice. **Southern Medical Journal**, Birmingham, v. 97, n. 12, p. 1194-1200, 2004. DOI: doi.org. Disponível em: sma.org. Acesso em: 16 mai. 2025.

KOENIG, Harold G.; LEVIN, Jeffrey S.; CHATTERS, Linda M. Research on religion and mental health: an overview of empirical findings and theoretical issues. In: KOENIG, Harold G. (org.). **Handbook of religion and mental health**. San Diego: Academic Press, 1998. p. 33-50. Acesso em: 7 out. 2024.

KOENIG, Harold G. Religião, espiritualidade e psiquiatria: uma nova era na atenção à saúde mental. **Archives of Clinical Psychiatry**, São Paulo, v. 34, supl. 1, p. 5-7, 2007. Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 12 mai. 2025.

KOENIG, Harold G. Religion and medicine IV: religion, physical health, and clinical implications. **The International Journal of Psychiatry in Medicine**, Farmingdale, v. 31, n. 3, p. 321-336, 2001. Disponível em: journals.sagepub.com. Acesso em: 1 fev. 2025.

KOENIG, Harold G. Religion, spirituality, and health: The research and clinical implications. **International Scholarly Research Notices**, v. 2012, n. 1, p. 278730, 2012.

KOENIG, Harold G. Research on religion, spirituality, and mental health: A review. **The Canadian Journal of Psychiatry**, v. 54, n. 5, p. 283-291, 2009.

KOENIG, Harold G. **Medicina, religião e saúde: o encontro da ciência e da espiritualidade**. L&PM, Editores, 2012.

KOENIG, Harold G. **Medicina, religião e saúde: onde a ciência e a espiritualidade se encontram**. Templeton Press, 2008.

KOENIG, Harold George; KING, Dana; CARSON, Verna B. **Handbook of religion and health**. Oup Usa, 2012.

KOLCABA, K. **Comfort theory and practice: A Vision for Holistic Health Care and Research**. Springer Publishing Co, 2003.

KOLCABA, Katharine. Evolution of the mid range theory of comfort for outcomes research. **Nursing outlook**, [s. l.], v. 49, n. 2, p. 86-92, 2001.

KOSLANDER, Tiburtius; ARVIDSSON, Barbro. Patients' conceptions of how the spiritual dimension is addressed in mental health care: a qualitative study. **Journal of advanced nursing**, [s. l.], v. 57, n. 6, p. 597-604, 2007.

KOTROTSIOU-BARBOUTA, E. *et al.* The meaning of spirituality as perceived by hospitalized elderly people in a small city of Greece. **ICUs & Nursing Web Journal**, [s. l.], v. 28, p. 1-7, 2006.

KREITZER, Mary Jo. Spirituality and well-being: Focusing on what matters. **Western Journal of Nursing Research**, [s. l.], v. 34, n. 6, p. 707-711, 2012.

KRISTENSEN, Tage S. *et al.* The Copenhagen Burnout Inventory: a new tool for the assessment of burnout. **Work & Stress**, Abingdon, v. 19, n. 3, p. 192-207, 2005. DOI: doi.org. Disponível em: www.tandfonline.com. Acesso em: 7 mar. 2026

KRUSE, Barbara G.; RUDER, Shirley; MARTIN, Linda. Spirituality and coping at the end of life. **Journal of Hospice & Palliative Nursing**, [s. l.], v. 9, n. 6, p. 296-304, 2007.

KUCHINISKI, G. T. *et al.* A espiritualidade e a saúde mental: uma revisão sobre psiquiatria e espiritualidade/religiosa. In: BARBOSA, Frederico Celestino (org.). **A psicologia como ciência e seu(s) objeto(s) de estudo**. Ponta Grossa: Atena Editora, 2022. v. 2, p. 135-145. DOI: doi.org. Acesso em: 21 fev. 2025.

KUCZEWSKI, Mark G. Talking about spirituality in the clinical setting: Can being professional require being personal?. **The American Journal of Bioethics**, [s. l.], v. 7, n. 7, p. 4-11, 2007.

LATTANZIO, Fellipe de Figueiredo; RIBEIRO, Paulo de Carvalho. Nascimento e primeiros desenvolvimentos do conceito de gênero. **Psicologia Clínica**, Rio de Janeiro, v. 30, n. 3, p. 409-425, 2018. DOI: doi.org. Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 12 fev. 2025.

LAUTERT, L. O desgaste profissional: uma revisão da literatura e implicações para a enfermeira. **Revista Gaúcha de Enfermagem**. Porto Alegre, v. 18, n. 2, p. 83-93, 1997.

LAZARUS R. S. FOLKMAN, S. **Stress, appraisal, and coping**. New York: Springer, 1984.

LE Goff, Jacques. **Medieval Civilization 400-1500**. New York: Blackwell Publishers, 1993.

LEININGER, Madeleine M. Culture care diversity and universality theory and evolution of the ethnonursing method. In: LEININGER, Madeleine M.; MCFARLAND, Marilyn R. (org.). **Culture care diversity and universality: a worldwide nursing theory**. 2. ed. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers, 2006. p. 361-375

LEITE, Ana Luísa Prosperi; STERN, Fabio L.; GUERRIERO, Silas. Espiritualidade e saúde: polissemia, fragilidades e riscos do conceito. **Horizonte: revista de Estudos de teologia e ciências da religião**, v. 19, n. 60, p. 8, 2021.

LEITE, Imelidiane Silva; SEMINOTTI, Elisa Pinto. A influência da espiritualidade na prática clínica em saúde mental: uma revisão sistemática. **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**, João Pessoa, v. 17, n. 2, p. 189-196, 2013. Disponível em: periodicos.ufpb.br. Acesso em: 13 mai. 2025.

LEITER, Michael P.; SCHAUFELI, Wilmar B. Consistência do constructo de *Burnout* entre ocupações. In: BENAVIDES, Fernando G.; DA SILVA, Maria João (org.). **Ansiedade e estresse**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996. p. 229-243

LEMMER, Corinne M. Recognizing and caring for spiritual needs of clients. **Journal of Holistic Nursing**, [s. l.], v. 23, n. 3, p. 310-322, 2005.

LE MOS, Carolina Teles; RICHTER REIMER, Ivoni. Apresentação do dossiê: religião, espiritualidade e saúde. **Caminhos: Revista de Ciências da Religião**, Goiânia, v. 18, n. 1, p. 4-12, 2020. DOI: doi.org. Disponível em: journals.pucgoias.edu.br. Acesso em: 13 fev. 2025.

LEMOS, Carolina Teles. Espiritualidade, religiosidade e saúde: uma análise literária. **Caminhos**: Revista de Ciências da Religião, Goiânia, v. 17, p. 688-708, 2019. Disponível em: journals.pucgoias.edu.br. Acesso em: 11 fev. 2025.

LEUNG, Kai-Kuen; CHIU, Tai-Yuan; CHEN, Ching-Yu. The influence of awareness of terminal condition on spiritual well-being in terminal cancer patients. **Journal of pain and symptom management**, New York, v. 31, n. 5, p. 449-456, 2006. Disponível em: www.jpmsjournal.com. Acesso em: 24 fev. 2025.

LEVENTHAL, Howard; SCHERER, Klaus. The relationship of emotion to cognition: A functional approach to a semantic controversy. **Cognition and Emotion**, Abingdon, v. 1, n. 1, p. 3-28, 1987. Disponível em: www.tandfonline.com. Acesso em: 21 abr. 2024.

LEVINAS, Emmanuel. **Ética e infinito**. Tradução: João Gama. Lisboa: Edições 70, 1982.

LIM, Jung-won. The effects of religiosity, spirituality, and social support on quality of life: a comparison between Korean American and Korean breast and gynecologic cancer survivors. **Oncology Nursing Forum**, Pittsburgh, v. 36, n. 6, p. 699-708, 2009. DOI: [doi.org](https://doi.org/10.1188/09ON.699-708). Disponível em: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Acesso em: 12 fev. 2024.

LITTLEWOOD, Roland. Religion, Agency, and Restitution. In: LITTLEWOOD, Roland. **The Variation of Animals and Plants Under Domestication**. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. p. 441-454. DOI: [doi.org](https://doi.org/10.1017/9780521876223.014). Acesso em: 21 set. 2025.

LO, Bernard *et al.* Discussing religious and spiritual issues at the end of life: a practical guide for physicians. **JAMA**, Chicago, v. 287, n. 6, p. 749-754, 2002. DOI: [doi.org](https://doi.org/10.1001/jama.287.6.749). Disponível em: jamanetwork.com. Acesso em: 14 fev. 2025.

LOPES M.J.M. O sexo do hospital. In: LOPES, M. J. M.; MEYER; WALDOW, V. R. (org). **Gênero & saúde**, Porto Alegre: Artes Médicas; 1996. p. 76-105.

LOPES M. J. M.; MEYER, D. E.; WALDOW, V. R. Apresentação. (org). **Marcas da diversidade**: saberes e fazeres da enfermagem contemporânea. Porto Alegre: Artmed; 1998. p. 7-8.

LOPES, M. J. M.; LEAL, S. M. C. A feminização persistente na qualificação profissional da enfermagem brasileira. **Cadernos Pagu**, Campinas, v. 24, p. 105- 125, jan-jun. 2005.

LUCCHETTI, Giancarlo; BASSI, Rodrigo M.; LUCCHETTI, Alessandra L. G. Providing spiritual care to patients: should it be based on religion or on spirituality?. **Journal of Religion and Health**, New York, v. 51, n. 3, p. 685-693, 2012. Disponível em: link.springer.com. Acesso em: 24 fev. 2025.

LUCCHETTI, Giancarlo. “Saúde e Espiritualidade”: das evidências científicas para a prática clínica. **HORIZONTE**: Revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião, Belo Horizonte, v. 20, n. 62, p. e206202, 2023. DOI: 10.5752/P.2175-5841.2022v20n62e206202. Disponível em: <https://periodicos.pucminas.br/horizonte/article/view/30816>. Acesso em: 22 set. 2025.

LUCCHETTI, Giancarlo; LUCCHETTI, Alessandra Lamas; AVEZUM JÚNIOR, Álvaro. Religiosidade, espiritualidade e doenças cardiovasculares. **Revista Brasileira de Cardiologia**,

Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, p. 55-57, 2011. Disponível em: www.onlineijcp.org. Acesso em: 12 abr. 2025.

LUCCHETTI, Giancarlo; LUCCHETTI, Alessandra Lamas Granero; KOENIG, Harold G. Impact of spirituality/religiosity on mortality: comparison with other health interventions. **Explore: The Journal of Science and Healing**, New York, v. 7, n. 4, p. 234-238, 2011. Disponível em: www.explorejournal.com. Acesso em: 12 fev. 2025.

LYNN, Kathleen; YOUNGER, Janet. Theobiology: an analysis of spirituality, cardiovascular responses, stress, mood, and physical health. **Journal of Religion and Health**, New York, v. 41, n. 4, p. 347-362, 2002. DOI: doi.org. Disponível em: link.springer.com. Acesso em: 13 mar. 2025.

MACCULLOCH, Diarmaid. **The Reformation: a history**. New York: Viking Penguin, 2004.

MACHADO, Maria Helena *et al.* **Perfil da enfermagem no Brasil: relatório final**. Rio de Janeiro: FIOCRUZ: COFEN, 2017. v. 1. Disponível em: www.cofen.gov.br. Acesso em: 5 fev. 2025.

MALHEIRO, Rafaela Frota *et al.* Saúde, espiritualidade e religiosidade na visão dos estudantes de medicina. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, Santarém, v. 15, n. 2, p. e9779, 2022. Disponível em: acervomais.com.br. Acesso em: 7 mar. 2026.

MALINSKI, Violet M. Developing a nursing perspective on spirituality and healing. **Nursing Science Quarterly**, [s. l.], v. 15, n. 4, p. 281-287, 2002.

MARIA, T., Duarte, D. M., Fernandes, A., & Bezerra, M. DE CARVALHO FERREIRA, Alberto Gorayeb *et al.* Concepções de espiritualidade e religiosidade e a prática multiprofissional em cuidados paliativos. **Revista Kairós-Gerontologia**, v. 18, n. 3, p. 227-244, 2015.

MARQUES, Luciana Fernandes; RIGO, R. M. A produção científica atual (2008–2014) em Psicologia da Religião e da Espiritualidade no Brasil. **Psicologia, religião e espiritualidade: estudos contemporâneos no contexto brasileiro**. Curitiba: Juruá, 2016.

MARQUES, Luciana Fernandes; AGUIAR, Ana Paula Arruda. Instrumentos de mensuração da religiosidade/espiritualidade (R/E) e seus construtos. **Revista Pistis & Praxis: Teologia e Pastoral**, Curitiba, v. 6, n. 1, p. 107-126, 2014.

MARTINS, Luciana Soares. **Espiritualidade e saúde mental em estudantes universitários**. 2015. Tese (Doutorado em Psicologia) – Faculdade de Educação e Psicologia, Universidade Católica Portuguesa, Porto, 2015. Disponível em: repositorio.ucp.pt. Acesso em: 23 set. 2024.

MARTINEZ, Izabel. M. M.; PINTO, Alexandra Marques; SILVA, Adelino L. da. Burnout em estudantes do ensino superior. **Revista portuguesa de psicologia**, Lisboa, v. 35, p. 151-167, 2000. Disponível em: revista.fpce.ul.pt. Acesso em: 11 abr. 2025.

MASLACH, Christina. Burn-Out. **Human Behavior**, Los Angeles, v. 5, n. 9, p. 16-22, 1976.

MASLACH, Christina. **Understanding burnout**: workload, stress, and burnout among professionals. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2009.

MASLACH, Christina; JACKSON, Susan E. The measurement of experienced burnout. **Journal of Occupational Behaviour**, New York, New York, v. 2, n. 2, p. 99-113, 1981. DOI: doi.org. Disponível em: onlinelibrary.wiley.com. Acesso em: 11 jul. 2025.

MASLACH, Christina. Udbændtheds-syndromet. **Psykolognyt**, København, v. 33, p. 138-144, 1979.

MASLACH, Cristina; JACKSON, Susan E. Esgotamento Inventor e manual. **Consultoria Psicólogos Imprensa** 2. ed. Paul Alto, CA, 1986.

MASLACH, Christina; LEITER, Michael P. Teacher Burnout: a research agenda. In: VANDENBERGHE, Roland; HUBERMAN, A. Michael (org.). **Understanding and preventing teacher burnout**: a sourcebook of international research and practice. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. p. 295-303

MASLACH, Cristina; Leitor, M. P. A verdade sobre carrapicho nada. São Francisco: **Jossey-Baixo Editoras**. 1997.

MASLACH, Christina; SCHAUFELI, Wilmar B.; LEITER, Michael P. Job burnout. **Annual review of psychology**, v. 52, n. 1, p. 397-422, 2001.

MATOS, A. A. O filho é da mãe, o pai abre a carteira: um estudo sobre os significados da maternidade sob a ótica das relações de gênero. **OIKOS: Revista Brasileira de Economia Doméstica**, Viçosa, v. 14, n. 1, p. 65-77, 2003b.

MATOS, A. A. Representações sociais do corpo na Revista Trip Para Mulher. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia Doméstica). Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2003.

MCCLAIN, Colleen S.; ROSENFELD, Barry; BREITBART, William. Effect of spiritual well-being on end-of-life despair in terminally-ill cancer patients. **The Lancet**, London, v. 361, n. 9369, p. 1603-1607, 2003. Disponível em: www.thelancet.com. Acesso em: 2 fev. 2025.

MCLEOD, D, L. **Espiritualidade e doença na literatura profissional**: espiritualidade, sofrimento e doença. Coimbra: Ariadne Editora; 2005.

MCSHERRY, Wilfred; ROSS, Linda. Dilemmas of spiritual assessment: considerations for nursing practice. **Journal of Advanced Nursing**, Oxford, v. 38, n. 5, p. 479-488, 2002. DOI: doi.org. Disponível em: onlinelibrary.wiley.com. Acesso em: 12 mai. 2025.

MCSHERRY W. The principal components model: a model for advancing spirituality and spiritual care within nursing and health care practice. **Journal of Clinical Nursing**, Oxford, v. 15, n. 7, p. 905-917, 2006. Disponível em: onlinelibrary.wiley.com. Acesso em: 21 abr. 2025.

MCSHERRY, Wilfred. **Making sense of spirituality in nursing and health care practice**: An interactive approach. 2.ed. London: Jessica Kingsley Publishers, 2006. 192 p.

MELEIS AI. **Theoretical nursing**: development & progress. 3. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.

MELO, Cynthia de Freitas *et al.* Correlation between religiousness, spirituality and quality of life: a review of literature. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 2, p. 447-464, 2015. Disponível em: pepsic.bvsalud.org. Acesso em: 12 fev. 2025.

MEMBRIVE-JIMÉNEZ, María José *et al.* Burnout in nursing managers: a systematic review and meta-analysis of related factors, levels and prevalence. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, Basel, v. 17, n. 11, p. 3983, jun. 2020. DOI: [doi.org](https://doi.org/10.3390/ijerph17113983). Disponível em: www.mdpi.com. Acesso em: 11 abr. 2025.

MERAVIGLIA, Martha Gene. The effects of spirituality on well-being of people with lung cancer. In: **Oncology Nursing Forum**, Pittsburgh, v. 31, n. 1, p. 89-94, jan. 2004. Disponível em: ons.org. Acesso em: 11 fev. 2025.

MIGUEL, Roberto Pereira. Espiritualidade e saúde: possíveis repercussões para a Teologia e as Ciências da Religião. **Horizonte**: Revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião, Belo Horizonte, v. 19, n. 60, p. 946-950, set./dez. 2021.

MINAYO-GOMEZ, Carlos; THEDIM-COSTA, Sonia Maria da Fonseca. A construção do campo da saúde do trabalhador: percurso e dilemas. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 13, supl. 2, p. S21-S32, 1997. Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 21 abr. 2025.

MINER-WILLIAMS, Denise. Putting a puzzle together: making spirituality meaningful for nursing using an evolving theoretical framework. **Journal of Clinical Nursing**, Oxford, v. 15, n. 7, p. 811-821, jul. 2006. Disponível em: onlinelibrary.wiley.com. Acesso em: 21 mai. 2025.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 4.218, de 20 de dezembro de 2022**. Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 35 - Trabalho em Altura. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 21 dez. 2022. Disponível em: <https://doe.to.gov.br/diario/4218/download>. Acesso em: 10 set. 2025.

MITCHEL GJ. Tornar-se humano In: Tomey AM, Alligood MR. Teóricas de enfermagem y su obra. Modelos y teorías de enfermería. 7. ed. Barcelona: **Elsevier**; p. 593-628, 2011.

MOBERG, David O. Assessing and measuring spirituality: Confronting dilemmas of universal and evaluative criteria. **Journal of Adult Development**, [s. l.], v. 9, n. 1, p. 47-60, 2002.

MOK, Esther; WONG, Frances; WONG, Daniel. The meaning of spirituality and spiritual care among the Hong Kong Chinese terminally ill. **Journal of Advanced Nursing**, [s. l.], v. 66, n. 2, p. 360-370, 2010.

MONEY, J.; TUCKER, P. **Os papéis sexuais**. São Paulo: Brasiliense, 1981.

MÓNICO, Lisete. Religião, espiritualidade e saúde: funções, convivências e implicações. **Horizonte: revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião**, v. 19, n. 60, p. 14, 2021.

MOREIRA, Wanderson Carneiro *et al.* Effects of the association between spirituality, religiosity and physical activity on health/mental health: a systematic review. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 54, p. e03631, 2020.

MONOD, Stefanie *et al.* The spiritual needs model: spirituality assessment in the geriatric hospital setting. **Journal of Religion, Spirituality & Aging**, Philadelphia, v. 22, n. 4, p. 271-282, 2010. DOI: doi.org.

MONTEIRO, Daiane Daitx *et al.* Espiritualidade/religiosidade e saúde mental no Brasil: uma revisão. **Boletim: Academia Paulista de Psicologia**, São Paulo, v. 40, n. 98, p. 129-139, jan./jun. 2020. Disponível em: pepsic.bvsalud.org. Acesso em: 21 mai. 2025.

SILVEIRA, Fabiano Moreira da. Espiritualidade e psiquiatria: atenção à saúde mental na dimensão psicossocial e espiritual. **COGNITIONIS Scientific Journal**, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 1-12, jul./dez. 2021. DOI: doi.org.

MOREIRA, Wanderson Carneiro *et al.* Effects of the association between spirituality, religiosity and physical activity on health/mental health: a systematic review. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 54, p. e03631, 2020. DOI: doi.org.

MOREIRA-ALMEIDA, Alexander. Espiritualidade e saúde mental: uma revisão do estado da arte e agenda de pesquisa. **Archives of Clinical Psychiatry**, São Paulo, v. 33, n. 1, p. 176-183, 2006.

MOREIRA-ALMEIDA, Alexander. Espiritualidade e saúde: passado e futuro de uma relação controversa e desafiadora. **Archives of Clinical Psychiatry**, São Paulo, v. 34, supl. 1, p. 3-4, 2007.

MOREIRA-ALMEIDA, Alexander. Implicações dos estudos brasileiros em psiquiatria e espiritualidade. **Archives of Clinical Psychiatry**, São Paulo, v. 39, n. 5, p. 181, 2012.

MOREIRA-ALMEIDA, Alexander. O crescente impacto das publicações em espiritualidade e saúde e o papel da Revista de Psiquiatria Clínica. **Archives of Clinical Psychiatry**, São Paulo, v. 37, n. 1, p. 41-42, 2010.

MOREIRA-ALMEIDA, Alexander; CORDEIRO, Quirino; KOENIG, Harold G. Ethical considerations regarding religion/spirituality in psychiatric research. **Archives of Clinical Psychiatry**, São Paulo, v. 45, n. 1, p. 1-2, 2018. DOI: doi.org.

MOREIRA-ALMEIDA, Alexander; LOTUFO NETO, Francisco; KOENIG, Harold G. Religiousness and mental health: a review. **Brazilian Journal of Psychiatry**, São Paulo, v. 28, n. 3, p. 242-250, set. 2006.

MORRISON, D. Well-being and spirituality. In: ESCA OPEN DAY PROGRAMME, 2005, Geneva. **Proceedings**, Geneva: ESCA, 2005.

MOUNT, Balfour M.; BOSTON, Patricia H.; COHEN, S. Robin. Healing connections: on moving from suffering to a sense of well-being. **Journal of Pain and Symptom Management**, New York, v. 33, n. 4, p. 372-388, apr. 2007. DOI: doi.org.

MURRAY, Scott A. *et al.* Exploring the spiritual needs of people dying of lung cancer or heart failure: a prospective qualitative interview study of patients and their carers. **Palliative Medicine**, London, v. 18, n. 1, p. 39-45, jan. 2004. DOI: doi.org.

MYSTAKIDOU, Kyriaki *et al.* Spiritual indicators in the dying. **Canadian Family Physician**, Mississauga, v. 54, n. 12, p. 1720-1726, dec. 2008.

NAHAS, M. A. *et al.* Recent use of illicit drugs among psychiatric patients in Brazil: a national representative study. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 51, p. 74, 2017. DOI: doi.org.

NARAYANASAMY, Aru; GATES, Bob; SWINTON, John. Spirituality and learning disabilities: a qualitative study. **British Journal of Nursing**, London, v. 11, n. 14, p. 948-957, jul. 2002.

NEGRO-Dellacqua, M., Sá-Junior, A. R. de, Sousa, I. F. de, & Lima, K. de M. Panorama sobre espiritualidade e saúde: o que literatura científica aponta sobre o tema nos últimos 5 anos? **Research, Society and Development**, v. 8, n. 7, e1087-1103, 2019.

NELSON, Christian J. *et al.* Spirituality, religion, and depression in the terminally ill. **Psychosomatics**, v. 43, n. 3, p. 213-220, 2002.

NETO, Francisco dos Santos. Ernani Francisco; GUIMARÃES, Carolina de Carvalho Duarte. Pesquisas em espiritualidade e saúde. **Sacrilegens**, v. 15, n. 2, 2018.

NEUSNER, Jacob. **Judaism and Christianity in the age of Constantine**: History, Messiah, Israel, and the initial confrontation. Chicago: University of Chicago Press, 2008.

NEUSNER, Jacob. **The documentary history of Judaism**. London: Routledge, 1991.

NEVES, Magda. Gênero, mercado de trabalho e qualificação. **Revista de Administração da FEAD-Minas**, Belo Horizonte, v. 1, n. 2, p. 71-82, jul./dez. 2004. Disponível em: fead.com.br. Acesso em: 21 mar. 2025.

NIGHTINGALE, Florence. **Notas sobre enfermagem**: o que é e o que não é. Tradução: Amália Corrêa de Carvalho. São Paulo: Cortez, 1989.

OBANA, João Enzio Gomes *et al.* A positivação na formação de profissionais da área da saúde: curadores de doenças ou cuidadores de pessoas?. **Research, Society and Development**, Vargem Grande Paulista, v. 10, n. 11, p. e574101119721, 2021. DOI: doi.org.

O'BRIEN, Mary Elizabeth. **Spirituality in nursing**: standing on holy ground. 7. ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2021. 418 p.

OLIVEIRA, Márcia Regina de; JUNGES, José Roque. Mental health and spirituality/religiosity: psychologists' understandings. **Estudos de Psicologia**, Natal, v. 17, p. 469-476, 2012.

OLIVEIRA, R. C. Religiões Afro-Brasileiras: Resistência e Transculturação. **Religião & Sociedade**, 2004.

OLIVEIRA, V. A. *et al.* **Saúde: Conectando Corpo, Mente e Espírito**. v. 1. Jader Luís da Silveira (org.). Formiga, MG: Editora Uniesmero, 2024. 94 p. : il.

OMAIS, Sálua; DOS SANTOS, Manoel Antônio. Religiosidade/Espiritualidade: interrelações com o bem-estar e saúde mental à luz da Psicologia Positiva. **Memorandum: Memória e História em Psicologia**, v. 39, 2022.

OMAN, D.; THORESEN, C. E. Does Religion Cause Health?: Distinguishing the Effects of Religious Behavior from Religious Community. **Journal for the Scientific Study of Religion**, [s. l.], v. 44, n. 3, p. 367-384, 2005.

O'MATHÚNA, Dónal P. The place of dignity in everyday ethics. **Journal of Christian Nursing**, [s. l.], v. 28, n. 1, p. 12-18, 2011.

ORTEGA GALÁN, Ángela María. Validación de una escala valorativa del diagnóstico enfermero "sufrimiento espiritual" en los enfermos oncológicos en fase terminal. **Documentos de Enfermería**, Almería, n. 28, p. 22-27, 2007. Disponível em: dialnet.unirioja.es.

OTTO, Rudolf. **The idea of the holy**: An inquiry into the non-rational factor in the idea of the divine and its relation to the rational. H. Milford: Oxford University Press, 1926.

PAIVA, Geraldo José de *et al.* Psicologia da Religião no Brasil: a produção em periódicos e livros. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, Brasília, v. 25, n. 3, p. 441-446, jul./set. 2009. DOI: doi.org.

PAIVA, Geraldo José de *et al.* Religiosidade clássica, espiritualidade contemporânea e qualidade de vida: discussões psicológicas. **Relegens Thréskeia: Estudos e pesquisa em religião**, Curitiba, v. 4, n. 1, p. 1-13, jan./jun. 2015. DOI: doi.org.

PALOUTZIAN, Raymond F.; PARK, Crystal L. (org.). **Handbook of the psychology of religion and spirituality**. 2. ed. New York: Guilford Press, 2013. 674 p.

PALOUTZIAN, Raymond F.; ELLISON, Craig W. Loneliness, spiritual well-being and the quality of life. In: PEPLAU, Letitia Anne; PERLMAN, Daniel (org.). **Loneliness: a sourcebook of current theory, research and therapy**. New York: John Wiley & Sons, 1982. p. 224-237.

PANAGIOTI, Maria *et al.* Association between physician burnout and patient safety, professionalism, and patient satisfaction: a systematic review and meta-analysis. **JAMA internal medicine**, v. 178, n. 10, p. 1317-1331, 2018.

PANDYA, S. P. Spirituality, happiness, and psychological well-being in 13- to 15-year-olds: a longitudinal study on ECR. **Journal of Pastoral Care & Counseling**, Philadelphia, v. 71, n. 1, p. 12-26, mar. 2017. DOI: doi.org.

PANZINI, Raquel Gehrke; BANDEIRA, Denise Ruschel. Coping (enfrentamento) religioso/espiritual. **Archives of Clinical Psychiatry**, São Paulo, v. 34, supl. 1, p. 126-135, 2007. DOI: doi.org. Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 21 mar. 2024.

PANZINI, Raquel Gehrke; BANDEIRA, Denise Ruschel. Escala de coping religioso-espiritual (Escala CRE): elaboração e validação de construto. **Psicologia em Estudo**, Maringá, v. 10, n. 3, p. 507-516, set./dez. 2007. DOI: doi.org.

PARGAMENT, Kenneth I. *et al.* Patterns of positive and negative religious coping with major life stressors. **Journal for the Scientific Study of Religion**, [S. l.], v. 37, n. 4, p. 710-724, dec. 1998. DOI: doi.org.

PARGAMENT, Kenneth I. The bitter and the sweet: an evaluation of the costs and benefits of religiousness. **Psychological Inquiry**, Philadelphia, v. 13, n. 3, p. 168-181, 2002. DOI: doi.org.

PARGAMENT, Kenneth I. The psychology of religion and coping: theory, research, practice. New York: Guilford Press, 2001. 548 p.

PARGAMENT, Kenneth I.; KOENIG, Harold G.; PEREZ, Lisa M. The many methods of religious coping: development and initial validation of the RCOPE. **Journal of Clinical Psychology**, Hoboken, v. 56, n. 4, p. 519-543, apr. 2000. DOI: doi.org<519::AID-JCLP6>3.0.CO;2-1.

PARK, Crystal L. Religion and meaning. In: PALOUTZIAN, Raymond F.; PARK, Crystal L. (org.). **Handbook of the psychology of religion and spirituality**. New York: Guilford Press, 2005. p. 295-314.

PARK, Crystal L. *et al.* Positive and negative religious/spiritual coping and adjustment to bereavement. **Psychology of Religion and Spirituality**, Washington, DC, v. 5, n. 4, p. 243-253, nov. 2013. DOI: doi.org.

PARK, Crystal L.; FOLKMAN, Susan. Meaning in the context of stress and coping. **Review of General Psychology**, Washington, DC, v. 1, n. 2, p. 115-144, jun. 1997. DOI: doi.org.

PARSONS, Ethel. A enfermagem moderna no Brasil. **Escola Anna Nery: Revista de Enfermagem**, Rio de Janeiro, n. esp., p. 10-24, 1997.

PASQUALUCCI, Paula Lage *et al.* Prevalence and correlates of depression, anxiety, and stress in medical residents of a Brazilian academic health system. **BMC medical education**, v. 19, p. 1-5, 2019.

PAZ, de P., Denise Barcelos *et al.* A espiritualidade e religiosidade de pessoas em tratamento hemodialítico: revisão integrativa. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 11, n. 16, p. e459111638511-e459111638511, 2022.

PECK, M. S. **O caminho menos percorrido e mais além**. Lisboa: Sinais de Fogo, 2005.

PERLMAN, Baron; HARTMAN, E. Alan. Burnout: summary and future research. **Human Relations**, London, v. 35, n. 4, p. 283-305, apr. 1982. DOI: doi.org.

PESSANHA, Priscila Paes; ANDRADE, Edson Ribeiro de. Religiosidade e prática clínica: um olhar fenomenológico-existencial. **Perspectivas Online: Biológicas & Saúde**, Campos dos Goytacazes, v. 3, n. 10, p. 55-68, 2009.

PESUT, Barbara *et al.* Particularizing spirituality in points of tension: enriching the discourse. **Nursing Inquiry**, Oxford, v. 16, n. 4, p. 337-346, dec. 2009. DOI: doi.org.

PETERMAN, Amy H. *et al.* Measuring spiritual well-being in people with cancer: the functional assessment of chronic illness therapy—Spiritual Well-being Scale (FACIT-Sp). **Annals of Behavioral Medicine**, Washington, DC, v. 24, n. 1, p. 49-58, feb. 2002.

PETERSEN, Douglas. **Not by might nor by power**: the emergence of Pentecostal theology in the early twentieth century. Oxford: Regnum Books, 1996. 261 p.

PHANEUF, Margot. **Planificação de cuidados**: um sistema integrado e personalizado. Coimbra: Quarteto, 2001.

PHILLIPS, K. **Irmã Callista Roy**: modelo de adaptación In: Tomey A. M.; Alligood M. R. Teóricas de enfermagem y su obra. Modelos y teorías de enfermagem. 7. ed. Barcelona: Elsevier; p. 301- 33, 2011.

PHILLIPS, C. Robert. Spiritual Care: A Role for Religion in Nursing. **Holistic Nursing Practice**, Philadelphia, v. 19, n. 5, p. 235-237, 2005. Disponível em: hnc.sagepub.com. Acesso em: 11 ago. 2024.

PINTO, Cândida; RIBEIRO, José Luís Pais. Avaliação da espiritualidade dos sobreviventes de cancro: implicações na qualidade de vida. **Revista Portuguesa de Saúde Pública**, Lisboa, p. 49-56, 2010.

PIPE, Teri Britt *et al.* A prospective descriptive study exploring hope, spiritual well-being, and quality of life in hospitalized patients. **Medsurg Nursing**, [s. l.], v. 17, n. 4, p. 247-253, 2008.

PITTA, A. **Hospital**: dor e morte como ofício. São Paulo: Hucitec, 1999.

PLAUTO, Monique Sá e Benevides de Carvalho *et al.* Espiritualidade e qualidade de vida em médicos que convivem com a finitude da vida. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Brasília, v. 46, n. 1, p. e043, 2022. DOI: doi.org.

PORTUGAL. Ministério da Saúde. Direção-Geral da Saúde. **Direitos dos doentes internados**. Lisboa: DGS, 2005. Disponível em: <https://www.dgs.pt>. Acesso em: 11 mar. 2025.

POST, Stephen G. Spirituality and Health: What Should Physicians Say to Their Patients? **JAMA**, Chicago, v. 291, n. 23, p. 2884-2884, 2004. Disponível em: jama.ama-assn.org. Acesso em: 12 out. 2024.

POTTER, Patricia Ann; PERRY, Anne Griffin. **Fundamentos de enfermagem**. Tradução de Maria Inês Corrêa Nascimento. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 1568 p.

POWELL, Lynda H.; SHAHABI, Leila; THORESEN, Carl E. Religion and spirituality: linkages to physical health. **American Psychologist**, Washington, DC, v. 58, n. 1, p. 36-52, jan. 2003.

PRECOMA, Dalton Bertolim *et al.* Updated cardiovascular prevention guideline of the Brazilian Society of Cardiology-2019. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, São Paulo, v. 113, n. 4, p. 787-891, 2019.

PUCHALSKI, Christina M.; FERRELL, Betty. Spirituality and the physician-patient relationship. **Journal of Clinical Oncology**, Alexandria, v. 25, n. 36, p. 5753-5757, dec. 2007.. Disponível em: ascopubs.org.

PUCHALSKI, Christina M. Integrating spirituality into patient care: an introduction. **Spirituality in Clinical Practice**, Washington, DC, v. 1, n. 1, p. 1-7, 2014.

PUCHALSKI, Christina M. *et al.* Spirituality and health: the role of spirituality in health care. **Baylor University Medical Center Proceedings**, Dallas, v. 27, n. 4, p. 352-357, 2014.

PUCHALSKI, Christina M. *et al.* Improving the spiritual dimension of whole person care: reaching national and international consensus. **Journal of Palliative Medicine**, Larchmont, v. 17, n. 6, p. 642-656, jun. 2014.

PUCHALSKI, Christina M. The FICA spiritual history tool #274. **Journal of Palliative Medicine**, Larchmont, v. 17, n. 1, p. 105-106, jan. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1089/jpm.2013.9458>. Acesso em : 12 fev. 2025.

PUCHALSKI, Christina M. The role of spirituality in health care. **Baylor University Medical Center Proceedings**, Dallas, v. 14, n. 4, p. 352-357, oct. 2001.

PUCHALSKI, Christina M.; DORFF, Elliot N.; HENDI, Yahya. Spirituality, religion, and healing in palliative care. **Clinics in Geriatric Medicine**, Philadelphia, v. 20, n. 4, p. 689-714, nov. 2004.

PUCHALSKI, Christina; FERRELL, Betty. **Making health care whole: integrating spirituality into patient care**. West Conshohocken: Templeton Press, 2010.

PUCHALSKI, Christina M. Spirituality and medicine: Curricula in United States medical schools. **Journal of General Internal Medicine**, [S. l.], v. 21, n. S5, p. S14-S18, 2006. Disponível em: www.ncbi.nlm.nih.gov. Acesso em: 2 nov. 2024.

QUINN GRIFFIN, Mary T. *et al.* Spirituality and well being among elders: differences between elders with heart failure and those without heart failure. **Clinical Interventions in Aging**, Auckland, v. 2, n. 4, p. 669-675, dec. 2007. DOI: doi.org. Disponível em: www.ncbi.nlm.nih.gov. Acesso em: 21 mai. 2025.

QUIJANO, Aníbal. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. In: LANDER, Edgardo (org.). **A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais**. Buenos Aires: CLACSO, 2005. p. 107-130.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder e classificação social. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (org.). **Epistemologias do Sul**. São Paulo: Cortez, 2010. p. 84-130.

RAMAZZINI, Bernardino. **As doenças dos trabalhadores**. Tradução: Raimundo Estrela. 4. ed. São Paulo: Fundacentro, 2016. 321 p.

RAMOS, Maria Júlia Oliveira et al. Espiritualidade e religiosidade no tratamento de pacientes com infarto agudo do miocárdio: revisão integrativa. **Research, Society and Development**, Vargem Grande Paulista, v. 10, n. 14, p. e194101421760, 2021.

OLIVEIRA, Maria Regina de; JUNGES, José Roque. Saúde mental e espiritualidade/religiosidade: a visão de psicólogos. **Estudos de Psicologia**, Natal, v. 17, n. 3, p. 469-476, set./dez. 2012. DOI: doi.org.

REGINATO, Valdir; BENEDETTO, Marco Antonio de; GALLIAN, Dante Marcello Claramunt. Espiritualidade e saúde: uma experiência na graduação em medicina e enfermagem. **Trabalho, Educação e Saúde**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 237-255, jan./abr. 2016.

REGO, Ana Cristina Caramelo. O processo de avaliação dos níveis de bem-estar espiritual: um contributo para a sua validação. **Cadernos de Saúde**, Lisboa, v. 1, n. 2, p. 199-204, jul. 2008. Disponível em: revistas.ucp.pt.

REINALDO, Amanda Márcia dos Santos; SANTOS, Raquel Lana Fernandes dos. Religião e transtornos mentais na perspectiva de profissionais de saúde, pacientes psiquiátricos e seus familiares. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 40, n. 110, p. 162-171, jul./set. 2016.

RENAUD, Michel. Do espírito à espiritualidade. In: BISCAIA, Jorge (org.). **A que pais os filhos têm direito?**. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 2008. p. 152-168.

REY, Alain (org.). **Dictionnaire historique de la langue française**. Paris: Dictionnaires Le Robert, 1993. 2 v.

RIBEIRO, Antônio Lopes; COUTO, Pablo Luiz Santos; SILVA, Sandra Célio Coelho Gomes da. Espiritualidade, religião e suas interfaces com a saúde. **Fragmentos de Cultura**, Goiânia, v. 29, n. 4, p. 585-587, out./dez. 2019.

SLOAN, Richard P. **Blind faith: the unholy alliance of religion and medicine**. New York: St. Martin's Press, 2006. 320 p.

RICHARDS, P. Scott; BERGIN, Allen E. **A spiritual strategy for counseling and psychotherapy**. 2. ed. Washington, DC: American Psychological Association, 2005. 434 p.

RICHARDS, P. Scott; BERGIN, Allen E. (org.). **Handbook of psychotherapy and religious diversity**. Washington, DC: American Psychological Association, 2000. 518 p.

RILEY, Barth B. et al. Types of spiritual well-being among persons with chronic illness: their relation to various forms of quality of life. **Archives of Physical Medicine and Rehabilitation**, Chicago, v. 79, n. 3, p. 258-264, mar. 1998.

RODRIGUES, Beatriz Gonçalves et al. Saúde mental do idoso em tempos de COVID-19. **New Trends in Qualitative Research**, Aveiro, v. 18, p. e834, 2023. DOI: doi.org.

RODRIGUES, Deisiane Duarte et al. Religiosidade e espiritualidade na prática clínica em saúde mental. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, Santarém, v. 12, n. 7, p. e3327, 2020.

RONCON, J. *et al.* Estresse em pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, Brasília, v. 26, n. 3, p. 485-492, jul./set. 2010.

ROSENSTOCK, Irwin M.; STRECHER, Victor J.; BECKER, Marshall H. Social learning theory and the health belief model. **Health Education Quarterly**, [s. l.], v. 15, n. 2, p. 175-183, jun. 1988.

ROSS, Linda. Spiritual care in nursing: an overview of the research to date. **Journal of Clinical Nursing, Oxford**, [s. l.], v. 15, n. 7, p. 852-862, jul. 2006.

ROSSATO, Karine *et al.* Religiosidade/espiritualidade: análise das tendências em teses e dissertações da enfermagem brasileira. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, Rio de Janeiro, v. 97, n. 4, p. e023239, 2023.

ROTEGÅRD, Ann Kristin *et al.* Health assets: a concept analysis. **International Journal of Nursing Studies**, Oxford, v. 47, n. 4, p. 513-525, 2010.

SAAD, Marcelo; MASIERO, Anamaria; BATTISTELLA, Linamara. Spirituality in clinical practice: a psychodynamic perspective. **Clinical Social Work Journal**, New York, v. 29, n. 3, p. 297-309, 2001.

SACCOMANN, Izabel Cristina Ribeiro; DE SOUZA OLIVEIRA, Arleti; BRANTS, Maria Paula Camargo. Fatores estressores e estratégias de enfrentamento dos profissionais de enfermagem na COVID-19: uma revisão integrativa. **Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba**, Sorocaba, v. 24, n. 1/4, p. 135-140, 2022.

SAFFIOTI, Heleieth I. B. **O poder do macho**. São Paulo: Moderna, 1987.

SAFFIOTI, Heleieth; ALMEIDA, Suely Souza de. **Violência de gênero: Poder e Impotência**. Rio de Janeiro: Revinter, 1995.

SAKRAIDA TJ. Modelo del promoción de la salud. In: Tomey A.M., Alligood M. R. **Teóricas de enfermería y su obra. Modelos y teorías de enfermería**. 7. ed. Barcelona: Elsevier, p. 699-715, 2010.

SALUD De E. Y., GROESCHEL, Kimberlly *et al.* Espiritualidade e saúde mental em pacientes no pós-cirúrgico oncológico em hospital do nordeste brasileiro. **Interações**, v. 18, n. 2, p. 1-21, 2023.

SANTOS, Maria Aparecida *et al.* Espiritualidade no processo de cuidar em enfermagem: revisão integrativa. **Uninter**, Curitiba, v. 4, n. 2, p. 45-60, 2022. DOI: doi.org. Acesso em: 16 mar. 2025.

SARRIERA, Jorge Castellá. Saúde, bem-estar espiritual e qualidade de vida: pressupostos teóricos e pesquisas atuais. In: FLECK, Marcelo Pio de Almeida (org.). **Espiritualidade e qualidade de vida**. Porto Alegre: Artmed, 2004. p. 79-90.

SARTORI, Penny. Spirituality 1: should spiritual and religious beliefs be part of patient care?. **Nursing Times**, London, v. 106, n. 28, p. 14-17, jul. 2010. Disponível em: <https://www.nursingtimes.net>. Acesso em 12 mai. 2025.

SAWATZKY, Richard; PESUT, Barbara. Attributes of spiritual care in nursing practice. **Journal of Holistic Nursing**, Thousand Oaks, v. 23, n. 1, p. 19-33, mar. 2005. DOI: doi.org.

SCHAEFER, Karen M. Modelo de conservación. In: MARRINER TOMEY, Ann; ALLIGOOD, Martha Raile (org.). **Modelos y teorías en enfermería**. 7. ed. Barcelona: Elsevier, 2010. p. 237-25

SESSANNA, Lorelee; FINNELL, Deborah; JEZEWSKI, Mary Ann. Spirituality in nursing and health-related literature: A concept analysis. **Journal of Holistic Nursing**, [s. l.], v. 25, n. 4, p. 252-262, 2007.

SEYBOLD, Kevin S.; HILL, Peter C. The role of religion and spirituality in mental and physical health. **Current Directions in Psychological Science**, Washington, DC, v. 10, n. 1, p. 21-24, feb. 2001.

SHANAFELT, Tait D. *et al.* Burnout and satisfaction with work-life balance among US physicians relative to the general US population. **Archives of Internal Medicine**, Chicago, v. 172, n. 18, p. 1377-1385, oct. 2012. DOI: doi.org.

SHAPIN, Steven. **The scientific revolution**. Chicago: University of Chicago Press, 1996. 218 p.

SHERMAN, Deborah Witt *et al.* Recruitment and retention in a longitudinal palliative care study. **Applied Nursing Research**, Philadelphia, v. 18, n. 3, p. 167-177, 2005.

SHIH, Fu-Jin. Spiritual needs of Taiwan's older patients with terminal cancer. **Oncology Nursing Forum**, Pittsburgh, v. 36, n. 1, p. E31-E38, jan. 2009.

SILVA, João *et al.* O impacto da espiritualidade na saúde mental de idosos: uma revisão. **Saúde e Pesquisa**, Maringá, v. 15, n. 2, p. e10334, 2022. Acesso em: 16 set. 2025.

SILVA, R. G. L. B.; BEZERRA, W. C.; QUEIROZ, S. B. Os impactos das identidades transgêneros na sociabilidade de travestis e mulheres transexuais. **Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo**, São Paulo, v. 26, n. 3, p. 364-372, set./dez. 2015.

SILVA, I. M. da; DOURADO, W. M.; LOPES, W. A. Espiritualidade e psicologia: um estudo sobre as implicações na saúde mental do indivíduo. **Revista FIMCA**, Porto Velho, v. 10, n. 2, p. 34-45, 2023.

SILVA, Cirlene Francisca Sales da; CORREIA JÚNIOR, João Luiz. Espiritualidade e saúde da pessoa idosa. **Paralellus: Revista de Estudos de Religião**, Recife, v. 14, n. 34, p. 345-361, jan./abr. 2023.

SILVA, Luana da Cruz da *et al.* Percepção de pessoas idosas sobre a influência da espiritualidade em sua saúde e qualidade de vida. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, Santarém, v. 13, n. 6, p. e7472, 2021.

SILVA, Taís Oliveira da. *et al.* Percepção de docentes brasileiros sobre as relações entre saúde, religião, espiritualidade e seu ensino. **Horizonte**: revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião, Belo Horizonte v. 19, n. 60, p. 7, 2021.

SILVA, M. B. B. Atenção psicossocial e gestão de populações: sobre os discursos e as práticas em torno da responsabilidade no campo da saúde mental. **Physis**: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p. 127-150, jan./jun. 2005.

SILVA, Maria Beatriz Andrade Marques *et al.* Espiritualidade e saúde: estudo caso-controle. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**, Três Corações, v. 14, n. 2, p. 1201-1209, ago./dez. 2016.

SILVA, R. M. S.; SOUZA, M. R.; ANDRADE, P. M. Condições de trabalho e saúde na enfermagem: desafios evidenciados pela pandemia de COVID-19. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 73, supl. 2, p. e20190531, 2020.

SILVA, Rogério Rodrigues da; SIQUEIRA, Deis. Espiritualidade, religião e trabalho no contexto organizacional. **Psicologia em Estudo**, Maringá, v. 14, n. 3, p. 557-564, jul./set. 2009.

SILVA, Wendel Johnson da *et al.* Análise da interface entre espiritualidade e saúde mental no contexto profissional-usuário: um estudo qualitativo. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, Itaboraí, v. 6, n. 1, p. 1608-1621, jan. 2024.

SILVEIRA, Francis Moreira da. Espiritualidade e psiquiatria: atenção à saúde mental na dimensão psicossocial e espiritual. *CPAH Science Journal of Health*, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 340-350, 2022.

SILVEIRA, Jader Luís da (org.). **Saúde**: conectando corpo, mente e espírito. Formiga: Editora Uniesmero, 2024. v. 1. 215 p.

SKEVINGTON, Suzanne M.; LOTFY, Mahmoud; O'CONNELL, Kathryn A. The World Health Organization's WHOQOL-BREF quality of life assessment: psychometric properties and results of the international field trial. A report from the WHOQOL group. **Quality of Life Research**, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 299-310, mar. 2004.

SMITH, Timothy B.; MCCULLOUGH, Michael E.; POLL, Justin. Religiousness and depression: evidence for a main effect and the moderating influence of stressful life events. **Psychological Bulletin**, Washington, DC, v. 129, n. 4, p. 614-636, jul. 2003.

SOBRAL, Vera Regina Salles. **A purgação do desejo**: memórias de enfermeiras. 1995. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1995.

SOLARI-TWADELL, A.; BURKHART, L. Disposición para mejorar el bienestar espiritual. In: ACKLEY, Betty J.; LADWIG, Gail B. (org.). **Manual de diagnósticos de enfermería**: guía para la planificación de los cuidados. 7. ed. Madrid: Elsevier, 2007. p. 339-347.

SONNENTAG, Sabine; FRITZ, Charlotte. Recovery from job stress: the stressor-detachment model as an integrative framework. **Journal of Organizational Behavior**, Hoboken, v. 36, supl. 1, p. S72-S103, jan. 2015.

SOUSA, A. de. Da ética para a justiça através do direito: entre a responsabilidade ilimitada e a reciprocamente constituída em uma ordem de validade. **Revista de Argumentação e Hermenêutica Jurídica**, Brasília, v. 4, n. 2, p. 1-20, jul./dez. 2018.

SOUSA, Clementina Fernandes; BRITO, Dalila Cunha; BRANCO, Maria Zita Pires Castelo. Depois da colostomia... vivências das pessoas portadoras. **Enfermagem em Foco**, Brasília, v. 3, n. 1, p. 12-15, fev. 2012.

SOUSA, Joab Gomes da Silva *et al.* Espiritualidade e religiosidade: saberes e práticas de profissionais da saúde mental. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, Santarém, v. 23, n. 7, p. e13261, 2023.

SOUSA, José Francisco de. Freudenberger, H. J. Staff burnout. *Journal of Social Issues*, 30(1), 159-165. Boletim: **Academia Paulista de Psicologia**, São Paulo, v. 42, n. 102, p. 96, jul./dez. 2022.

SOUTO, Gisleule Maria Menezes; SOUTO, Luana Matias. **Paridade de gênero**. In: MAGALHÃES, José Luiz Quadros de *et al.* (org.). *Dicionário de direitos humanos*. Porto Alegre: Fi, 2021. p. 337-341.

SOUZA, Enio Waldir da Silva; PERES, Maria Julia Paes. Espiritualidade e religiosidade na formação médica. **Revista de Medicina**, São Paulo, v. 31, n. 2, p. e2022a5221, 2022. DOI: doi.org. Acesso em: 7 fev. 2025.

SOUZA H. S. *et al.* The Brazilian nursing workforce faced with the international trends: na analysis in the internacional year of Nursing. *Physis*. 2021; 31(01):1-22. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312021310111> . Acesso em: 20 ago. 2025.

SOUZA, Airle Miranda de; AITA, K. M. S. C.; CORRÊA, Victor Augusto Cavaleiro. A compreensão da pessoa biopsicossocial e espiritual como recurso aos cuidados integrais: direitos humanos assegurados no planejamento e ações em saúde coletiva. In: SOUZA, Airle Miranda de (org.). **Saúde coletiva: avanços e desafios para a integralidade do cuidado**. Belém: Editora RFB, 2021. p. 208-223

SOUZA, D. G. D. *et al.* **Teorias de enfermagem**: Relevância para a prática profissional na atualidade. Campo Grande: Inovar, 2021.

SOUZA, Érica Nestor *et al.* Relação entre a esperança e a espiritualidade de idosos cuidadores. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 26, p. e6780015, 2017.

SOUZA, Karen Luisa Chaves; DA SILVA, Sandra Célia Coelho Gomes. Religiosidade, espiritualidade e saúde: uma incursão nos trabalhos acadêmicos das áreas das ciências humanas e da saúde nas universidades públicas da região Sul do Brasil. **Revista Educação, Psicologia e Interfaces**, v. 4, n. 3, 2020.

SOUZA-LOBO, E. **A classe operária tem dois sexos**. São Paulo: Brasiliense, 1991.

SOUZA, Vitor Chaves de. A espiritualidade e a medicina integrativa no contexto da saúde integral do ser humano. **Estudos Teológicos**, São Leopoldo, v. 57, n. 2, p. 343-358, jul./dez. 2017. Disponível em: [dx.doi.org](https://doi.org/10.1590/0013-768X201700001). Acesso em: 7 mar. 2025.

SOUZA, Vitor Chaves de; PAULA, Blanches de. Espiritualidade e saúde: contribuições da filosofia da religião. **Poliética**, revista de ética e filosofia política, São Paulo, v. 9, n. 2, p. 391-414, 2021. Disponível em: revistas.pucsp.br. Acesso em: 10 mar. 2025.

SPECK, Peter; HIGGINSON, Irene; ADDINGTON-HALL, Julia. Spiritual needs in health care. **BMJ: British Medical Journal**, London, v. 329, n. 7458, p. 123-124, jul. 2004.

STARK, Rodney. **The rise of Christianity**: a sociologist reconsiders history. Princeton: Princeton University Press, 1996. 272 p.

STEINHAUSER, Karen E. *et al.* Factors considered important at the end of life by patients, family, physicians, and other care providers. **JAMA**, Chicago, v. 284, n. 19, p. 2476-2482, nov. 2000.

STOLLER, Robert. Uma nova contribuição para o estudo da identidade de gênero. **The International Journal of Psychoanalysis**, London, v. 49, n. 2-3, p. 220-226, 1968.

STROPPIA, André; MOREIRA-ALMEIDA, Alexander. **Religiosidade e saúde**: Saúde e espiritualidade - uma nova visão da medicina. Belo Horizonte: Inede, p. 427-443, 2008.

SULMASY, Daniel P. A biopsychosocial-spiritual model for the care of patients at the end of life. **The gerontologist**, v. 42, n. 3, p. 24-33, 2002.

SULMASY, Daniel P. Spiritual issues in the care of dying patients: "... it's okay between me and god". **JAMA**, [s. l.], v. 296, n. 11, p. 1385-1392, 2006.

SULMASY, Daniel P. Spirituality, religion, and clinical care. **Chest**, [s. l.], v. 135, n. 6, p. 1634-1642, 2009.

TAM, Ekman PC. Faith development theory and spiritual direction. **Pastoral psychology**, [s. l.], v. 44, n. 4, p. 251-263, 1996.

TANYI, Ruth A. *et al.* Perceptions of incorporating spirituality into their care: a phenomenological study of female patients on hemodialysis. **Nephrology Nursing Journal**, v. 33, n. 5, 2006.

TANYI, Ruth A. Towards clarification of the meaning of spirituality. **Journal of advanced nursing**, v. 39, n. 5, p. 500-509, 2002.

TAYLOR SG. Teoría déficit del auto-cuidado en enfermería. In: n: MARRINER-TOMEY, A.; ALLIGOOD, M. R. Teóricas de enfermería y su obra. **Modelos y teorías de enfermería**. 7. ed. Barcelona: Elsevier. p. 211-36, 2010.

TAYLOR, Elizabeth Johnston. Prevalence and associated factors of spiritual needs among patients with cancer and family caregivers. In: ONCOLOGY NURSING FORUM, 33, 2006, Pittsburgh. **Anais [...]**. Pittsburgh: Oncology Nursing Society, 2006. p. 249-260.

TAYLOR, Elizabeth Johnston. Spiritual needs of patients with cancer and family caregivers. **Cancer Nursing**, [s. l.], v. 26, n. 4, p. 260-266, 2003.

TAYLOR, Elizabeth Johnston. Spiritual Care: Nursing Theory and Practice. **Journal of Holistic Nursing**, Thousand Oaks, v. 29, n. 1, p. 67-78, 2011. Disponível em: journals.sagepub.com. Acesso em: 11 fev. 2025.

TEIXEIRA, Alfredo *et al.* **Identidades religiosas em Portugal**: representações, valores e práticas – Regiões Autónomas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012.

TEIXEIRA, Graziela Silveira *et al.* Quality of life at work and occupational stress of nursing in an emergency care unit. **Texto & Contexto - Enfermagem**, [s. l.], v. 28, p. e20180298, 2019. DOI: doi.org.

TEIXEIRA, J. S. Espírito. In: CABRAL, R. (ed.). **Logos**: enciclopédia luso-brasileira de filosofia. Lisboa: Verbo, 1990. v. 2, p. 238-248.

TEIXEIRA, Marcus Zulian. Interconexão entre saúde, espiritualidade e religiosidade: importância do ensino, da pesquisa e da assistência na educação médica. **Revista de Medicina**, São Paulo, v. 99, n. 2, p. 134-147, 2020.

THE WHOQOL GROUP. Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF quality of life assessment. **Psychological Medicine**, Cambridge, v. 28, n. 3, p. 551-558, 1998. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/development-of-the-world-health-organization-whoqolbref-quality-of-life-assessment/0F50596B33A1ABD59A6605C44A6A8F30> Acesso em: 14 abr. 2025.

THIENGO, Priscila Cristina da Silva *et al.* Espiritualidade e religiosidade no cuidado em saúde: revisão integrativa. **Cogitare Enfermagem**, Curitiba, v. 24, e58692, 2019. Disponível em: dx.doi.org. Acesso em: 7 ago. 2025.

THOMAS, Jeani C. *et al.* Self-transcendence, spiritual well-being, and spiritual practices of women with breast cancer. **Journal of Holistic Nursing**, [s. l.], v. 28, n. 2, p. 115-122, 2010.

TIBOLA, Ana Júlia *et al.* Síndrome de Burnout em profissionais da área da saúde: uma revisão integrativa da literatura. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 12, n. 1, p. e24412139797-e24412139797, 2023.

TIBOLA, Ana Júlia *et al.* Síndrome de Burnout em profissionais da área da saúde: uma revisão integrativa da literatura. **Research, Society and Development**, [s. l.] v. 12, n. 1, p. e24412139797-e24412139797, 2023.

TOMEY, A. M. Joyce travelbee: modelo de relación de persona a persona In: TOMEY, A. M; ALLIGOOD, M. R. **Teóricas de enfermería y su obra**. Modelos y teorías de enfermería. 7. ed. Barcelona: Elsevier. p. 467-79, 2011.

TRINDADE, Karine Araújo *et al.* Espiritualidade e Saúde: um olhar por meio de diferentes atores sociais. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 11, n. 2, p. e41311225874-e41311225874, 2022.

VAN LEEUWEN, René *et al.* Spiritual care: implications for nurses' professional responsibility. **Journal of Clinical Nursing**, [s. l.], v. 15, n. 7, p. 875-884, 2006.

VEENHOVEN, R. The study of life satisfaction. *In*: SARIS, W. E. *et al* (Org). **A comparative study of satisfaction with life in Europe**. [s. l.], Eötvös University Press, p. 11-48, 1996.

VIANA, Ricardo *et al.* Intervenções espirituais na prática clínica: uma revisão sistemática. **Contemporary Health Studies**, [S. l.], v. 1, p. 95-110, 2023. DOI: doi.org. Acesso em: 11 fev. 2025.

VIEGAS, M. F. Trabalhando todo o tempo: sobrecarga e intensificação no trabalho de professoras da educação básica. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 48, p. e244193, 2022.

VIEIRA, Anievelyn Alves *et al.* Espiritualidade e religiosidade: desafios e possibilidades para prática médica. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 12, n. 5, p. e1612541396-e1612541396, 2023.

VIEIRA, C. R. Essa pele que habito - reflexões sobre transexualidade, discriminação e abuso às garantias constitucionais no contexto do direito do trabalho. *Revista da Faculdade de Direito JURIS FURG*, 2017. p. 67-80. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/juris/article/view/6680/4603>. Acesso em: maio. 2025.

VILAÇA, Helena. Identidades, práticas e crenças religiosas. **Atitudes Sociais dos Portugueses: Religião e Bioética**. Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, p. 75-128, 2001.

VILAÇA, Helena. **Da Torre de Babel às terras prometidas: pluralismo religioso em Portugal**. Porto: Edições Afrontamento, 2006.

VILLAGOMEZA, Liwliwa R. Spiritual distress in adult cancer patients: toward conceptual clarity. **Holistic Nursing Practice**, [s. l.], v. 19, n. 6, p. 285-294, 2005.

VOLCAN, S. M., SOUSA, P. L.; Nitschke, R. G. The meaning of spirituality in health. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 37, n. 6, p. 739-744, 2003.

VOLLMAN, Michael W.; LAMONTAGNE, Lynda L.; WALLSTON, Kenneth A. Existential well-being predicts perceived control in adults with heart failure. **Applied Nursing Research**, [s. l.], v. 22, n. 3, p. 198-203, 2009.

WALTON, Joni. Finding a balance: a grounded theory study of spirituality in hemodialysis patients. **Nephrology Nursing Journal**, [s. l.], v. 29, n. 5, 2002.

WATSON, J. **Enfermagem: ciência humana e cuidar uma teoria de enfermagem**; tradução: J. Enes. Loures: Lusociência, 2002.

WATSON, Jean. **Nursing: the philosophy and science of caring**. Revised edition. Boulder: University Press of Colorado, 2008.

WELCH AZ. Cuidados culturales: La teoría de la diversidad y la universalidad. *In* Tomey AM, Alligood MR. Teóricas de enfermería y su obra. **Modelos y teorías de enfermería**. 7. ed. Barcelona: Elsevier, p. 563-91, 2010.

WEST, Colin P. *et al.* Interventions to prevent and reduce physician burnout: a systematic review and meta-analysis. **The Lancet**, [s. l.], v. 388, n. 10057, p. 2272-2281, 2016.

WHITE, Sarah C. Analysing wellbeing: A framework for development practice. **Development in Practice**, [s. l.], v. 20, n. 2, p. 158-172, 2010.

WHITE, Sarah C. Analysing wellbeing: A framework for development practice. **Development in Practice**, [s. l.], v. 20, n. 2, p. 158-172, 2010.

WHITEHOUSE, Harvey. **Modes of religiosity**: a cognitive theory of religious transmission. Walnut Creek: Rowman Altamira, 2004. 192 p.

WHOQOL GROUP *et al.* Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF quality of life assessment. **Psychological medicine**, [s. l.], v. 28, n. 3, p. 551-558, 1998.

WILLIAMS, Anna-Leila. Perspectives on spirituality at the end of life: A meta-summary. **Palliative & Supportive Care**, [s. l.], v. 4, n. 4, p. 407-417, 2006.

WILSON, Bryan R. (ed.). **The social impact of new religious movements**. Rose of Sharon Press: New York, 1981. 235 p. (Conference series, n. 9).

WITUKI JM. Modelo de salud. In: TOMEY, A. M; ALLIGOOD, M. R. **Teóricas de enfermagem y su obra**: modelos y teorías de enfermería. 7. ed. Barcelona: Elsevier, p. 655-82, 2010.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHOQOL-BREF introduction, administration, scoring and generic version of the assessment**: field trial version. Geneva: WHO, 1996.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHOQOL-BREF**: introduction, administration, scoring and generic version of the assessment. Geneva: WHO, 1996. Modelo ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Versão em português dos instrumentos de avaliação de qualidade de vida (WHOQOL). Genebra: OMS, 1998.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Suicide worldwide in 2019**: global health estimates. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: iris.who.int. Acesso em: 15 maio 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Supportive environments for health**: Sundsvall statement. Geneva: WHO, 1995. (WHO/HED/92.1). Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/59561>. Acesso em: 15 maio 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHOQOL-BREF**: introduction, administration, scoring and generic version of the assessment: field trial version, December 1996. Geneva: WHO, 1996. Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/63529>. Acesso em: 15 maio 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHOQOL-SRPB** field-test instrument: WHOQOL spirituality, religiousness and personal beliefs (SRPB) field-test instrument: the WHOQOL-100 questions plus 32 SRPB questions. Geneva: WHO, 2002. (WHO/MSD/MER/Rev.2012.05). Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/77777>. Acesso em: 15 maio 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Ottawa Charter for Health Promotion. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH PROMOTION, 1., 1986, Ottawa. **Anais** [...]. Ottawa: Canadian Public Health Association, 1986. p. 17-21. Disponível em: iris.who.int. Acesso em: 15 mai. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Jakarta Declaration on Leading Health Promotion into the 21st Century. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH PROMOTION, 4., 1997, Jakarta. **Anais** [...]. Jakarta: WHO, 1997. Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/63698>. Acesso em: 12 mai. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Ottawa Charter for Health Promotion. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH PROMOTION, 1., 1986, Ottawa. **Anais** [...]. Ottawa: Canadian Public Health Association, 1986. p. 17-21. Disponível em: iris.who.int. Acesso em: 15 mai. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Palliative care**: cancer control: knowledge into action: WHO guide for effective programmes. Geneva: WHO, 2007. (Module 5). Disponível em: iris.who.int. Acesso em: 12 mar. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Palliative care**: WHO definition of palliative care. Geneva: WHO, 2002. Disponível em: www.who.int. Acesso em: 15 mar. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Adelaide Recommendations on Healthy Public Policy. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH PROMOTION, 2., 1988, Adelaide. **Anais** [...]. Adelaide: WHO, 1988. Disponível em: iris.who.int. Acesso em: 12 mar. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHOQOL**: measuring quality of life. Geneva: WHO, 1997. (WHO/MSA/MNH/PSF/97.4). Disponível em: iris.who.int. Acesso em: 13 mar. 2026.

WRIGHT L. **Espiritualidade, sofrimento e doença**. Coimbra: Ariadne Editora; 2005.

YOUSEFI H, Abedi H.A. Spiritual care in hospitalized patients. **Iran Journal of Nursing and Midwifery Research**. [s. l.], v. 16, n. 1, p 125-32, 2011.

ZIMPEL, Rogério R.; MOSQUEIRO, Bruno Paz; ROCHA, Neusa Sica da. Espiritualidade como mecanismo de coping em transtornos mentais. **Debates em Psiquiatria**, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, p. 28-30, mar./abr. 2015. DOI: doi.org.

ZOHAR D, Marshall I. **Inteligência espiritual**. Lisboa: Sinais de Fogo; 2004.

ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Pesquisa sob o título: *COPING ESPIRITUAL E A SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE DOCENTES UNIVERSITÁRIOS DE ENFERMAGEM*

Pesquisador Responsável: Ma. Cristina Galdino de Alencar e orientadora o Prof^ª Dr^ª. Carolina Teles Lemes.

O (A) Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa como voluntário (a) de um estudo. Este documento, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visa assegurar seus direitos e deveres como participante e é elaborado em duas vias, uma que deverá ficar com você e outra com o pesquisador.

Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas dúvidas. Se existirem perguntas antes ou mesmo depois de assiná-lo, você poderá esclarecê-las com o pesquisador. Se preferir, pode levar para casa e consultar seus familiares ou outras pessoas antes de decidir participar. Se você não quiser participar ou retirar sua autorização, a qualquer momento, não haverá nenhum tipo de penalização ou prejuízo.

Nesse estudo, disponibilizaremos um questionário autopreenchido por meio do formulário google, através do envio de link e/ou código barrametrico, bidimensional (QR-Code), que pode ser escaneado e usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera. Por favor, leia este documento com bastante atenção antes de assiná-lo. Caso haja alguma palavra ou frase que o (a) senhor (a) não consiga entender, converse com o pesquisador responsável pelo estudo ou com um membro da equipe desta pesquisa para esclarecê-los.

A proposta deste termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) é explicar tudo sobre o estudo e solicitar a sua permissão para participar do mesmo, conforme orienta a Resolução CNS 510/2016 em seus artigos 15, 16 e 17, e a Norma Operacional 001/2013.

O objetivo desta pesquisa é explorar como as estratégias de enfrentamento baseadas na espiritualidade (ou seja, formas pelas quais indivíduos utilizam suas crenças e práticas espirituais ou religiosas para lidar com situações de estresse e adversidades) podem influenciar a experiência da Síndrome de Burnout entre docentes de enfermagem (Burnout é um estado de esgotamento físico, emocional e mental causado por um envolvimento prolongado em situações de trabalho emocionalmente demandantes, comumente vivenciado por profissionais da saúde e educação), além de investigar o impacto destas estratégias na qualidade de vida dos profissionais. Buscamos compreender de maneira profunda as relações entre coping espiritual, Burnout e bem-estar, visando contribuir para o desenvolvimento de intervenções eficazes que promovam a saúde mental e a qualidade de vida dos educadores na área da enfermagem.

Você está sendo comunicado (a) que ao participar dessa pesquisa não terá benefícios diretos, e os benefícios indiretos esperados com o conhecimento produzido na pesquisa serão o levantamento de fatores que possam ajudar na compreensão das relações entre coping espiritual, Burnout e bem-estar.

Atendendo à resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, esta pesquisa não oferece riscos físicos para os participantes. Caso haja desconforto com alguma pergunta do questionário e o entrevistado sinta-se incomodado em responder, o pesquisador responsável suspenderá a pesquisa imediatamente, estando garantido o sigilo a privacidade dos entrevistados. Nenhuma informação será dada a outras pessoas que não façam parte da equipe de pesquisa.

Os dados serão coletados por meio de um questionário do google forms, disponibilizado por meio da sua instituição de ensino empregadora. A data da entrevista será previamente agendada e o tempo total da entrevista será de aproximadamente 20 a 30 minutos.

Todos os dados coletados nessa entrevista ficarão armazenados por um período de 5 (cinco) anos sob responsabilidade do pesquisador responsável. Os dados desse estudo possivelmente serão apresentados em eventos científicos e/ou publicados em revistas de saúde. Nenhuma informação que identifique o entrevistado será utilizada para esse fim.

Sua participação é muito importante. Ao participar da pesquisa, ficam assegurados os seguintes direitos:

- De ter resposta a qualquer dúvida sobre os procedimentos, riscos e benefícios relacionados com a pesquisa;
- De retirar o seu consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento, e isso não vai implicar em prejuízo de qualquer natureza para sua pessoa ou seus familiares;
- Da segurança que o senhor (a) não será identificada de nenhuma forma e garantindo a sua privacidade;
- De não assumir qualquer despesa ao participar da pesquisa; e
- De saber os resultados da pesquisa realizada.

Os responsáveis pelo fornecimento das informações terão livre acesso ao acompanhamento de seus resultados, e caso queiram, poderão retirar sua autorização a qualquer momento, não havendo nenhum tipo de penalização ou prejuízo. Não haverá despesas por parte dos participantes.

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador responsável, na R. 227, Quadra 66, Lote 14-E – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO, 74610-155, telefone 62 996518056 ou através do e-mail cgaalencar@gmail.com. Em caso de dúvida sobre a ética aplicada a pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da PUC Goiás, via e-mail (cep@pucgoias.edu.br), telefone: (62) 3946-1512, localizado na Avenida Universitária, N° 1069, St. Universitário, Goiânia/GO. Funcionamento: das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas de segunda a sexta-feira. O CEP é uma instância vinculada à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) que por sua vez é subordinado ao Ministério da Saúde (MS). O CEP é responsável por realizar a análise ética de projetos de pesquisa, sendo aprovado aquele que segue os princípios estabelecidos pelas resoluções, normativas e complementares.

Caso você concorde em participar desta pesquisa, peço-lhe a gentileza de assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em duas vias, rubricando as demais páginas. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável.

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento que julgar necessário.

Goiânia /GO, _____ de _____ de _____

Cristina Galdino de Alencar
Pesquisador Responsável

Assinatura do participante

ANEXO B -TERMO DE COMPROMISSO

Eu, **CRISTINA GALDINO DE ALENCAR**, pesquisador responsável pelo projeto de pesquisa intitulado ***COPING ESPIRITUAL E A SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE DOCENTES UNIVERSITÁRIOS DE ENFERMAGEM***, comprometo-me com a utilização dos dados contidos google forms e pela PUC GO, a fim de obtenção dos objetivos previstos, e somente após receber a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.

Comprometo-me a manter a confidencialidade dos dados coletados nos arquivos/banco de dados. Bem como com a privacidade de seus conteúdos. Esclareço ainda que os dados a serem coletados se referem as escalas a serem utilizadas para coleta de dados, no período de junho a agosto de 2024.

Declaro entender que é minha a responsabilidade de cuidar da integridade das informações e de garantir a confidencialidade dos dados e a privacidade dos indivíduos que terão suas informações acessadas. Também é minha a responsabilidade de não repassar os dados coletados ou o banco de dados em sua íntegra, ou parte dele, às pessoas não envolvidas na equipe da pesquisa.

Por fim, comprometo-me com a guarda, cuidado e utilização das informações apenas para cumprimento dos objetivos previstos nesta pesquisa aqui referida. Qualquer outra pesquisa em que eu precise coletar informações serão submetidas a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa.

Goiânia, _____ de _____ de _____.

Assinatura do (s) Pesquisador (ES)

ANEXO C- ESCALA CRE ESCALA DE *COPING* (ENFRENTAMENTO) RELIGIOSO-ESPIRITUAL

<https://forms.gle/sFcUpQJo8qCRisUH9>

Estamos interessados em saber se, e o quanto você utiliza a religião e a espiritualidade para lidar com o estresse em sua vida. O estresse acontece quando você percebe que determinada situação é difícil ou problemática, porque vai além do que você julga poder suportar, ameaçando seu bem-estar. A situação pode envolver você, sua família, seu trabalho, seus amigos ou algo que é importante para você. Neste momento, pense na situação de maior estresse que você viveu nos últimos três anos. Por favor, descreva-a em poucas palavras:

As frases abaixo descrevem atitudes que podem ser tomadas em situações de estresse. Circule o número que melhor representa o quanto VOCÊ fez ou não o que está escrito em cada frase para lidar com a situação estressante que você descreveu acima. Ao ler as frases, entenda o significado da palavra Deus segundo seu próprio sistema de crença (aquilo que você acredita).

1. Orei pelo bem-estar de outros (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
2. Procurei o amor e a proteção de Deus (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
3. Não fiz muito, apenas esperei que Deus resolvesse meus problemas por mim (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
4. Procurei trabalhar pelo bem-estar social (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
5. Procurei ou realizei tratamentos espirituais (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
6. Procurei em Deus força, apoio e orientação (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
7. Senti insatisfação com os representantes religiosos de minha instituição (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
8. Pedi a Deus que me ajudasse a encontrar um novo propósito na vida (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
9. Imaginei se Deus permitiu que isso me acontecesse por causa dos meus erros (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
10. Realizei atos ou ritos espirituais (qualquer ação especificamente relacionada com sua crença: sinal da cruz, confissão, jejum, rituais de purificação, citação de provérbios, entoação de mantras, psicografia, etc.) (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
11. Tive dificuldades para receber conforto de minhas crenças religiosas (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
12. Fiz o melhor que pude e entreguei a situação a Deus (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
13. Convenci-me que forças do mal atuaram para tudo isso acontecer (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo

14. Pratiquei atos de caridade moral e/ou material (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
15. Procurei me aconselhar com meu guia espiritual superior (anjo da guarda, mentor, etc) (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
16. Voltei-me a Deus para encontrar uma nova direção de vida (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
17. Tentei lidar com meus sentimentos sem pedir a ajuda de Deus (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
18. Tentei proporcionar conforto espiritual a outras pessoas (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
19. Fiquei imaginando se Deus tinha me abandonado (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
20. Pedi para Deus me ajudar a ser melhor e errar menos (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
21. Pensei que o acontecido poderia me aproximar mais de Deus (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
22. Não tentei lidar com a situação, apenas esperei que Deus levasse minhas preocupações embora (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
23. Senti que o mal estava tentando me afastar de Deus (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
24. Entreguei a situação para Deus depois de fazer tudo que podia (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
25. Orei para descobrir o objetivo de minha vida (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
26. Fui a um templo religioso (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
27. Busquei proteção e orientação de entidades espirituais (santos, espíritos, orixás, etc) (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
28. Imaginei se minha instituição religiosa tinha me abandonado (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
29. Procurei por um total re-despertar espiritual (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
30. Confiei que Deus estava comigo (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
31. Comprei ou assinei revistas periódicas que falavam sobre Deus e questões espirituais (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
32. Pensei que Deus não existia (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
33. Questionei se até Deus tem limites (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
34. Busquei ajuda ou conforto na literatura religiosa (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo

35. Pedi perdão pelos meus erros (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
36. Participei de sessões de cura espiritual (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
37. Questionei se Deus realmente se importava (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
38. Tentei fazer o melhor que podia e deixei Deus fazer o resto (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
39. Envolvi-me voluntariamente em atividades pelo bem do próximo (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
40. Ouvi e/ou cantei músicas religiosas (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
41. Sabia que não poderia dar conta da situação, então apenas esperei que Deus assumisse o controle (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
42. Recebi ajuda através de imposição das mãos (passes, rezas, bênçãos, magnetismo, Reik, etc.) (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
43. Tentei lidar com a situação do meu jeito, sem a ajuda de Deus (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
44. Senti que meu grupo religioso parecia estar me rejeitando ou me ignorando (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
45. Participei de práticas, atividades ou festividades religiosas ou espirituais (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
46. Procurei auxílio nos livros sagrados (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
47. Tentei mudar meu caminho de vida e seguir um novo – o caminho de Deus (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
48. Culpei Deus pela situação, por ter deixado acontecer (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo
49. Refleti se não estava indo contra as leis de Deus e tentei modificar minha atitude (1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo

ANEXO D- INVENTÁRIO DE BURNOUT DE COPENHAGEN - CBI – PT.

<https://forms.gle/VpinUredZQoBSxqc7>

Este questionário destina-se à avaliação psicométrica das dimensões do *burnout*. Não há respostas melhores ou piores, a resposta correta é aquela que exprime com veracidade a sua própria experiência. A cada uma das frases deve responder consoante a frequência com que tem o sentimento, assinalando com uma cruz.

Com que frequência se sente cansado(a)?	Sempre	Frequentemente	Às vezes	Raramente	Nunca/quase nunca
O seu trabalho é emocionalmente desgastante?	Imenso	Muito	Nem muito, nem pouco	Pouco	Muito pouco
Acha difícil trabalhar com idosos/doentes crónicos?	Imenso	Muito	Nem muito, nem pouco	Pouco	Muito pouco
Com que frequência se sente fisicamente exausto(a)?	Sempre	Frequentemente	Às vezes	Raramente	Nunca/quase nunca
Sente-se esgotado por causa do seu trabalho?	Imenso	Muito	Nem muito, nem pouco	Pouco	Muito pouco
Acha frustrante trabalhar com idosos/doentes crónicos?	Imenso	Muito	Nem muito, nem pouco	Pouco	Muito pouco
Com que frequência se sente emocionalmente exausto(a)?	Sempre	Frequentemente	Às vezes	Raramente	Nunca/quase nunca
O seu trabalho deixa o(a) frustrado(a)?	Imenso	Muito	Nem muito, nem pouco	Pouco	Muito pouco
Trabalhar com idosos/doentes crónicos deixa o(a) sem energia?	Imenso	Muito	Nem muito, nem pouco	Pouco	Muito pouco
Com que frequência pensa “Eu não aguento mais isto”?	Sempre	Frequentemente	Às vezes	Raramente	Nunca/quase nunca
Sente-se esgotado(a) no final de um dia de trabalho?	Imenso	Muito	Nem muito, nem pouco	Pouco	Muito pouco
Sente que dá mais do que recebe quando trabalha com idosos /doentes crónicos?	Imenso	Muito	Nem muito, nem pouco	Pouco	Muito pouco
Com que frequência se sente fatigado(a)?	Sempre	Frequentemente	Às vezes	Raramente	Nunca/quase nunca

ANEXO E - ESCALA WHOQOL BREF (DE QUALIDADE DE VIDA)

<https://forms.gle/HYZW5sDx6oNKyfGt6>

Instruções

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e outras áreas de sua vida. Por favor responda a todas as questões. Se você não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas últimas semanas. **Por exemplo**, pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser:

Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor resposta.

1. Como você avalia sua qualidade de vida? (1) Muito ruim (2) Ruim (3) Nem ruim nem boa (4) Boa (5) Muito boa
2. Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde? (1) Muito ruim (2) Ruim (3) Nem ruim nem boa (4) Boa (5) Muito boa

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas.

3. Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer o que você precisa? (1) Nada (2) Muito pouco (3) Médio (4) Muito (5) Completamente
4. O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida diária? (1) Nada (2) Muito pouco (3) Médio (4) Muito (5) Completamente
5. O quanto você aproveita a vida? (1) Nada (2) Muito pouco (3) Médio (4) Muito (5) Completamente
6. Em que medida você acha que a sua vida tem sentido? (1) Nada (2) Muito pouco (3) Médio (4) Muito (5) Completamente
7. Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos)? (1) Nada (2) Muito pouco (3) Médio (4) Muito (5) Completamente

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de fazer

8. Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia? (1) Nada (2) Muito pouco (3) Médio (4) Muito (5) Completamente

9. Quão disponíveis para você estão as informações que precisa no seu dia-a-dia? (1) Nada (2) Muito pouco (3) Médio (4) Muito (5) Completamente
10. Em que medida você tem oportunidades de atividade de lazer? (1) Nada (2) Muito pouco (3) Médio (4) Muito (5) Completamente

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de vários aspectos de sua vida nas últimas.

11. Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de desempenhar as atividades do seu dia-a-dia? (1) Muito ruim (2) Ruim (3) Nem ruim nem bom (4) Bom (5) Muito bom
12. Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o trabalho? (1) Muito ruim (2) Ruim (3) Nem ruim, nem bom (4) Bom (5) Muito bom
13. Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, colegas)? (1) Muito ruim (2) Ruim (3) Nem ruim, nem bom (4) Bom (5) Muito bom
14. Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de saúde? (1) Muito ruim (2) Ruim (3) Nem ruim, nem bom (4) Bom (5) Muito bom

As questões seguintes referem-se a com que frequência você sentiu ou experimentou certas coisas nas últimas duas semanas.

15. Com que frequência você tem sentimentos negativos tais como maus humores, desespero, ansiedade, depressão? (1) Nunca (2) Algumas vezes (3) Frequentemente (4) Muito frequentemente (5) Sempre

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário?

Quanto tempo você levou para preencher este questionário?

ANEXO F - QUESTIONÁRIO COM CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS E DADOS OCUPACIONAIS

<https://forms.gle/wndrTKwAWT5ehT6J9>

Poderia responder algumas perguntas sobre você?

Antes de iniciar este questionário, gostaríamos de enfatizar sua importância para nosso estudo sobre a relação entre coping espiritual, Síndrome de Burnout e qualidade de vida entre docentes de enfermagem. Suas respostas nos ajudarão a entender melhor como fatores pessoais e profissionais influenciam essas dinâmicas.

A. DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS DO (A) TRABALHADOR (A)
--

1. Qual sua faixa etária?

() 20 – 30 anos

() 31 – 40 anos

() 41 – 50 anos

() 51 – 60 anos

() 61– 70 anos

() 71 Anos ou mais

2. Qual o seu gênero?

() (feminino/mulher cisgênera)

() (Masculino/homem cisgênera)

3. Estado civil?

() Casado (a) união de fato

() Solteiro (a)

() Viúvo (a)

() Divorciado (a)

4. Nº de filhos.

() nenhum

() 1

() 2

() 3 ou mais

B. DADOS OCUPACIONAIS DO (A) TRABALHADOR (A)

5. Habilidades literárias?

- ☐ Licenciatura
- ☐ Bacharelado
- ☐ Especialização
- ☐ Mestrado
- ☐ Doutorado

6. Há quanto tempo você trabalha na área de enfermagem? _____ (anos e meses).

7. Há quanto tempo você trabalha neste emprego atual? _____ (anos e meses)

8. Qual é o seu horário de trabalho nesta instituição?

09. Qual é o seu vínculo empregatício nesta instituição?

- ☐ CLT (carteira assinada);
- ☐ Concursado estatutário (sem carteira assinada);
- ☐ Contrato (processo seletivo).

Outro: _____

10. Tempo de conclusão do curso de enfermagem?

- ☐ Até 5 anos
- ☐ entre 6 e 10 anos
- ☐ entre 11 e 25
- ☐ entre 26 e 30 anos
- ☐ mais que 31 anos

11. Nº de alunos por sala.

- ☐ até 20 alunos
- ☐ 21 a 40 alunos
- ☐ acima de 41 alunos

12. Nº de disciplinas que ministra.

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ acima de 3 disciplinas

13. Faz horas-extras?

- ☐ Sim;
- ☐ Não

Se sim, com que frequência? _____.

13. Você já se afastou do trabalho por licença-médica?

☐ Sim

☐ Não

Se sim, quantas vezes se afastou no último ano (a partir de janeiro de 2014)? _____

14. Quando tempo durou o seu último afastamento? (o mais recente) _____ (meses ou dias).

15. Qual(is) foi (foram) o(s) motivo(s) do(s) afastamento(s) no último ano (a partir de janeiro de 2014)? _____

16. Qual sua carga horaria de trabalho docente?

☐ até 10 hs semanais

☐ de 11 á 20 hs semanais

☐ de 21 á 30 hs semanais

☐ de 31 á 40 hs semanais

Outra: _____

17. Nível de satisfação com o ambiente de trabalho atual:

☐ Muito satisfeito

☐ Satisfeito

☐ Neutro

☐ Insatisfeito

☐ Muito insatisfeito

18. Frequência de atividades de recuperação após o trabalho (atividades que ajudam a relaxar e se desligar do trabalho):

☐ Diariamente

☐ Várias vezes por semana

☐ Semanalmente

☐ Raramente

☐ Nunca

19. Percepção da própria saúde física e mental:

☐ Excelente

☐ Boa

☐ Regular

☐ Ruim

☐ Muito ruim

20. Grau de envolvimento em práticas espirituais ou religiosas:

☐ Muito envolvido

- ☐ Envolvido
- ☐ Pouco envolvido
- ☐ Não envolvido
- ☐ Não aplicável / Não prático

21. Percepção da eficácia do coping espiritual no manejo do estresse profissional:

- ☐ Muito eficaz
- ☐ Eficaz
- ☐ Neutro
- ☐ Pouco eficaz
- ☐ Ineficaz

22. Você teve algum diagnóstico médico de condições relacionadas ao estresse, como ansiedade, depressão ou Síndrome de Burnout?

- ☐ Não
- ☐ Sim, ansiedade
- ☐ Sim, depressão
- ☐ Sim, Síndrome de Burnout
- ☐ Sim, outra condição relacionada ao estresse (por favor, especifique): _____

23. Com que frequência você utiliza práticas de cuidado pessoal relacionadas à saúde mental? (Ex: meditação, exercícios físicos, consultas terapêuticas)

- ☐ Nunca
- ☐ Raramente
- ☐ Ocasionalmente
- ☐ Frequentemente
- ☐ Sempre

24. Como você classificaria a sua satisfação com o suporte emocional disponível no seu ambiente de trabalho?

- ☐ Muito insatisfeito(a)
- ☐ Insatisfeito(a)
- ☐ Neutro
- ☐ Satisfeito(a)
- ☐ Muito satisfeito(a)

(*) Responda apenas se você tiver outro emprego ligado à enfermagem:

26. (*) Em qual outra instituição você trabalha? _____

(*) Qual a carga horária de trabalho semanal neste outro emprego? _____ (em horas).

(*) Qual função você exerce neste emprego? _____

27. Há quanto tempo tirou suas últimas férias? _____

Obrigada pela colaboração!